



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai **PERAWATAN KEHAMILAN YANG OPTIMAL**

Nurrahma Layuk • Nur Aliyah Rangkuti • Siti Komariyah
Siti Nur Farida • Anis ervina • Maesaroh
Dian Fitriyani • Ni Nengah Arini Murni • Aida Ratna Wijayanti

Editor: Asmariyah



BUNGA RAMPAI: PERAWATAN KEHAMILAN YANG OPTIMAL

Penulis:

Nurrahma Layuk S.Tr.Keb., M.Keb.
Bd. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb., M.KM.
Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.
Bd. Siti Nur Farida, SST., M.Kes.
Anis ervina, S.S.T., M.Kes.
Maesaroh, S.ST., M.Kes.
Bdn. Dian Fitriyani, S.ST., M.Keb.
Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes.
Aida ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.

Editor:

Asmariyah, SST., M.Keb.



Bunga Rampai: Perawatan Kehamilan yang Optimal

Penulis: Nurrahma Layuk S.Tr.Keb., M.Keb.

Bd. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb., M.KM.

Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.

Bd. Siti Nur Farida, SST., M.Kes.

Anis ervina, S.S.T., M.Kes.

Maesaroh, S.ST., M.Kes.

Bdn. Dian Fitriyani, S.ST., M.Keb.

Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes.

Aida ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.

Editor: Asmariyah, SST., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-88-7

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Buku ini disusun sebagai panduan praktis bagi ibu hamil, keluarga, serta tenaga kesehatan dalam memberikan perhatian yang optimal selama masa kehamilan. Kehamilan adalah perjalanan yang penuh kebahagiaan dan tantangan, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam setiap aspek kesehatan ibu dan janin. Dalam buku ini, kami menyajikan berbagai topik penting yang dapat membantu mempersiapkan ibu hamil menghadapi perjalanan kehamilannya dengan lebih baik, aman, dan sehat.

Pemeriksaan kehamilan rutin adalah langkah pertama yang tidak boleh diabaikan. Melalui pemeriksaan yang teratur, kondisi ibu dan janin dapat dipantau dengan seksama untuk mendeteksi potensi risiko lebih dini, sehingga tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat dapat dilakukan. Kami juga membahas pentingnya nutrisi dan suplemen selama kehamilan, yang tidak hanya mendukung kesehatan ibu, tetapi juga pertumbuhan dan perkembangan janin.

Kehamilan dengan risiko tinggi memerlukan perhatian lebih intensif. Buku ini memberikan wawasan mengenai manajemen kehamilan berisiko tinggi, serta bagaimana mencegah infeksi yang dapat membahayakan ibu dan janin. Selain itu, menyusui adalah salah satu bagian penting dari perjalanan ibu setelah kelahiran, dan kami mengulas persiapan serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh ibu baru dalam menyusui.

Kehamilan juga bukan hanya sekadar proses fisik, tetapi juga emosional. Oleh karena itu, buku ini juga menekankan pentingnya persiapan mental emosional menjelang persalinan dan konseling psikososial bagi ibu hamil. Kami percaya bahwa dukungan mental dan emosional sangat vital untuk kesejahteraan ibu.

Dalam dunia medis, kondisi seperti Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil. Buku ini memberikan informasi tentang diagnosis dan pengelolaan PPOK selama kehamilan, agar ibu dapat mengelola kondisi ini dengan baik. Terakhir, kami juga membahas manajemen nyeri dan ketidaknyamanan selama kehamilan, yang sering kali menjadi tantangan bagi ibu hamil dalam menjalani hari-hari kehamilannya.

Semoga buku ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna untuk mendukung ibu hamil dalam meraih kehamilan yang sehat dan persalinan yang lancar. Kami berharap bahwa dengan perhatian yang optimal, setiap ibu dan janin dapat melewati masa kehamilan dengan sehat, bahagia, dan penuh harapan.

Maret, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PEMERIKSAAN KEHAMILAN RUITN DAN PENTINGNYA

PEMANTAUAN IBU DAN JANIN	1
Nurrahma Layuk, S.Tr.Keb., M.Keb.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Pemeriksaan Kehamilan yang Optimal.....	2
C. Pemeriksaan Kehamilan Trimester I.....	3
D. Pemeriksaan Kehamilan Trimester II	4
E. Pemeriksaan Kehamilan Trimester III	5
F. Pentingnya Pemantauan Kesehatan Ibu dan Janin	8
G. Asuhan Kebidanan Kehamilan Trimester I	9
H. Asuhan Kebidanan Kehamilan Trimester II.....	9
I. Asuhan Kebidanan Kehamilan Trimester III.....	10
J. Kesimpulan.....	10
K. Referensi	10
L. Glosarium	11

CHAPTER 2 NUTRISI DAN SUPLEMEN SELAMA KEHAMILAN..... 13

Bd. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb., M.KM.	13
A. Pendahuluan/Prolog	13
B. Defenisi Kehamilan	14
C. Nutrisi Dan Suplemen Selama Kehamilan.....	14
D. Manfaat Nutrisi dan Suplemen Untuk Ibu Hamil	20
E. Jenis-Jenis Bahan Makanan Yang Dihindari	21
F. Konseling Nutrisi Selama Kehamilan.....	24
G. Kebutuhan Nurtisi dan Sulemen Selama Kehamilan	25
H. Faktor Penghalang Kekurangan Nutrisi Dan Suplemen Selama Kehamilan ..	27
I. Kesimpulan.....	28
J. Referensi	29
K. Glosarium	29

CHAPTER 3 MANAJEMEN KEHAMILAN BERESIKO TINGGI.....31

Siti Komariyah, S.Sit., M.Kes.	31
A. Pendahuluan/Prolog	31
B. Manajemen Kehamilan Resiko Tinggi.....	32
C. Kesimpulan.....	50
D. Referensi	51
E. Glosarium	53

CHAPTER 4 PENCEGAHAN INFEKSI PADA KEHAMILAN.....55

Bd. Siti Nur Farida, SST., M.Kes.	55
A. Pendahuluan/Prolog	55
B. Jenis-jenis Infeksi Selama Kehamilan	56
C. Faktor Risiko Infeksi Kehamilan	58
D. Gejala Umum Infeksi Kehamilan	60
E. Diagnosis Infeksi Kehamilan	60
F. Pencegahan Infeksi Kehamilan	61
G. Pengobatan Infeksi Kehamilan	62
H. Komplikasi dan Risiko Kehamilan	64
I. Kesimpulan.....	64
J. Referensi	65
K. Glosarium	65

CHAPTER 5 PENYUSUAN ASI: PERSIAPAN DAN TANTANGAN YANG

MUNGKIN DIHADAPI IBU BARU67

Anis Ervina, S.S.T., M.Kes.	67
A. Pendahuluan/Prolog	67
B. Persiapan Penyusuan ASI.....	67
C. Tantangan dalam Penyusuan ASI	76
D. Solusi dan Strategi Mengatasi Tantangan	77
E. Kesimpulan.....	78
F. Referensi	78
G. Glosarium	78

CHAPTER 6 PERSIAPAN MENTAL EMOSIONAL MENJELANG

PERSALINAN.....79

Maesaroh, S.ST., M.Kes.	79
A. Pendahuluan/Prolog	79
B. Konsep Dasar Kecemasan	80
C. Mengelola Kecemasan serta Mempersiapkan Mental Menghadapi Persalinan	84
D. Teknik Relaksasi Nafas Dalam.....	87

E. Kesimpulan.....	91
F. Referensi	92
G. Glosarium	93
CHAPTER 7 KONSELING PSIKOSOSIAL BAGI IBU HAMIL	95
Bdn. Dian Fitriyani, S.ST., M.Keb.....	95
A. Pendahuluan	95
B. Perubahan Psikologi Dalam Kehamilan	96
C. Dukungan Psikososial Pada Ibu Hamil	97
D. Konseling Psikososial Pada Ibu Hamil	105
E. Referensi	107
CHAPTER 8 PERAWATAN GIGI DAN KESEHATAN MULUT SELAMA KEHAMILAN.....	109
Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes.	109
A. Pendahuluan/Prolog	109
B. Pentingnya Perawatan Gigi dan Kesehatan Mulut Selama Kehamilan.....	110
C. Masalah Kesehatan Gigi Dan Mulut Selama Kehamilan.....	112
D. Dampak kehamilan terhadap kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil dan dampak gangguan kesehatan gigi dan mulut terhadap kehamilan	115
E. Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut Selama Kehamilan	116
F. Simpulan	118
G. Referensi	119
H. Glosarium	121
CHAPTER 9 MANAJEMEN NYERI DAN KETIDAKNYAMANAN SELAMA KEHAMILAN.....	123
Aida ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.	123
A. Pendahuluan/Prolog	123
B. Nyeri Fisiologis yang Bisa Terjadi pada Kehamilan	124
C. Manajemen Nyeri melalui Relaksasi selama Kehamilan.....	125
D. Ketidaknyamanan Sesuai Dengan Usia Kehamilan.....	126
E. Ketidaknyamanan Umum dan Tindakan Mendapatkan Kenyamanan Selama Kehamilan	127
F. Kesimpulan.....	135
G. Referensi	135
H. Glosarium	137
PROFIL PENULIS	139

CHAPTER 1

PEMERIKSAAN KEHAMILAN RUITN DAN PENTINGNYA PEMANTAUAN IBU DAN JANIN

Nurrahma Layuk, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia telah terjadi penurunan, akan tetapi penurunan AKI dan AKB di Indonesia masih di bawah target yaitu AKI 183 per 100.000 kelahiran hidup dan AKN 10 per 1000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2020). Kesehatan ibu selama kehamilan sangat berperan penting terhadap keberlangsungan kesehatan bayi yang dilahirkan. Ibu hamil yang rutin memeriksakan kehamilannya mampu menghindarkan dirinya dari morbiditas maupun mortalitas serta akan menghasilkan kehamilan yang sehat baik pada ibu maupun pada bayi. Selama masa kehamilan, terjadi berbagai perubahan baik fisik maupun mental pada ibu hamil. Pemeriksaan fisik yang optimal pada ibu hamil diharapkan mampu mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental sehingga ibu hamil mampu melewati masa kehamilan, persalinan, masa nifas dan masa menyusui dengan baik (Mutalib et al., 2024).

Pelayanan ante natal care atau pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil yang dilakukan rutin diharapkan mampu mendeteksi dini terjadinya risiko tinggi pada kehamilan. Ibu hamil diwajibkan melakukan pemeriksaan selama masa kehamilan minimal enam kali selama masa kehamilan yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan kelainan atau kesulitan dalam kehamilan yang akan timbul di kemudian hari sehingga petugas Kesehatan dalam hal ini bidan mampu mengantisipasi dan memberikan penanganan sesegera mungkin sebelum memberikan pengaruh yang tidak diinginkan terhadap kehamilan (Oktapianti & Triyanti, 2023).

Pemeriksaan kehamilan yang rutin pada ibu hamil juga dapat mencegah terjadinya stunting dimana kita ketahui bahwa pencegahan stunting dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Dengan melakukan pemeriksaan sedini mungkin, ibu hamil akan mendapatkan informasi dan edukasi sehingga dapat mengurangi kejadian stunting pada bayi baru lahir (Huru et al., 2023).

B. Pemeriksaan Kehamilan yang Optimal

Kehamilan yang sehat merupakan kehamilan yang direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangannya dengan baik. Agar kehamilan sehat dapat tercapai, ibu hamil diharapkan rutin memeriksakan kehamilannya (Kementerian kesehatan RI, 2021). Pemeriksaan kehamilan merupakan pemeriksaan ibu hamil yang diwajibkan oleh pemerintah dan bertujuan untuk memastikan kesehatan serta kesejahteraan ibu dan janin (Astuti et al., 2017). Pemeriksaan kehamilan yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu sebanyak enam kali selama masa kehamilan yaitu satu dua kali pada trimester satu, satu kali trimester dua dan tiga kali pada trimester tiga. Pada saat pemeriksaan kehamilan, bidan memantau kondisi ibu hamil diantaranya,:

1. Memeriksa kondisi fisik ibu secara keseluruhan termasuk memeriksa tanda-tanda vital ibu.
2. Menentukan taksiran perkiraan persalinan ibu.
3. Memeriksa kondisi janin.
4. Melakukan pemeriksaan laboratorium termasuk triple eliminasi.
5. Memberikan imunisasi TT dengan memperhatikan status imunisasi ibu terdahulu.
6. Memberikan tablet FE.
7. Memberikan tindakan segera jika terdapat komplikasi.

Selain melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil, bidan juga berkewajiban dalam penyampaian edukasi seperti memberikan penyuluhan konseling pada ibu hamil dan keluarga, meliputi :

1. Tanda bahaya yang terjadi pada masa kehamilan dan persalinan
2. Menyampaikan informasi terkait tanda-tanda persalinan pada ibu hamil
3. Kebersihan diri dan kebersihan lingkungan
4. Gizi pada ibu hamil
5. Informasi dan perencanaan persalinan pada ibu, apakah akan bersalin di bidan atau di rumah sakit, mempersiapkan perawatan ibu dan bayi, mempersiapkan transportasi serta biaya dan menyiapkan calon donor darah.
6. Mengedukasi ibu perlunya IMD dan pentingnya memberikan ASI eksklusif.
7. Memberikan informasi terkait KB yang akan di gunakan ibu pasca bersalin nanti.

Bidan juga berperan dalam melakukan kunjungan rumah, baik kunjungan ibu hamil maupun kunjungan rumah ibu nifas dan bayi baru lahir. Hal-hal yang dilakukan bidan ketika melakukan kunjungan rumah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan konseling terkait perencanaan persalinan kepada ibu hamil dan keluarga

2. Melakukan pelayanan ANC pada ibu hamil yang tidak dapat melakukan pemeriksaan ke Puskesmas / fasilitas kesehatan.
3. Membangun komunikasi persuasif antara bidan dan ibu hamil, kader dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif unsur-unsur masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu.

Selain itu, pemeriksaan kehamilan dalam pelayanan kebidanan meliputi tiga ruang lingkup pelayanan, yaitu: (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016)

1. Pelayanan kebidanan primer, bidan berperan dan bertanggung jawab penuh atas pelayanan yang diberikan.
2. Pelayanan kebidanan kolaborasi, pelayanan kebidanan yang dilakukan bidan Bersama tim profesi kesehatan lainnya.
3. Pelayanan kebidana rujukan, bidan merujuk ke pusat pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi

C. Pemeriksaan Kehamilan Trimester I

Pada trimester I bidan melakukan pemeriksaan awal/ pertama kali kepada ibu hamil. Pemeriksaan yang dilakukan bidan meliputi pemeriksaan fisik secara menyeluruh, pemeriksaan panggul dan pemeriksaan laboratorium. Berikut merupakan rincian pemeriksaan yang dilakukan bidan ketika melakukan pemeriksaan kehamilan trimester I pada ibu hamil:

1. Keadaan umum dan tanda-tanda vital: bidan memeriksa TTV ibu hamil meliputi tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu tubuh.
2. Menimbang berat badan: penimbangan berat badan pada ibu hamil dilakukan setiap kali ibu hamil datang memeriksakan kehamilannya. Penimbangan berat badan pada ibu hamil bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilogram selama kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin.
3. Mengukur lingkar lengan atas (lila): pengukuran lila dilakukan hanya pada saat pemeriksaan pertama kali untuk mendeteksi kejadian KEK pada ibu hamil. Ibu hamil dengan KEK yaitu ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronik/ mengalami kurang gizi dimana hasil pengukuran lingkar lengan atas $<23,5$ cm. Ibu hamil dengan KEK akan melahirkan bayi BBLR.
4. Mengukur tekanan darah: pengukuran tekanan darah dilakukan pada setiap kali ibu hamil datang memeriksakan kehamilannya. Pemeriksaan tekanan darah bertujuan untuk mendeteksi adanya kenaikan berlebih pada tekanan darah $>140/90$ mmHg, atau untuk mencegah terjadinya preeklampsia pada ibu hamil.

5. Mengukur tinggi fundus uteri: pengukuran tinggi fundus uteri bertujuan untuk memantau perkembangan janin sesuai atau tidak dengan usia kehamilan. Jika pengukuran tinggi fundus uteri tidak sesuai dengan usia kehamilan maka kemungkinan terdapat gangguan pertumbuhan kehamilan pada janin. Pengukuran tinggi fundus uteri dilakukan menggunakan pita pengukur/cm dan dilakukan setelah usia 24 minggu.
6. Menghitung denyut jantung janin: penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester 1 dan selanjutnya setiap kali ibu hamil datang memeriksakan kehamilannya. Denyut jantung normal pada bayi berkisar antara 120-160x/m.
7. Menentukan presentasi janin: melakukan pemeriksaan untuk mengetahui presentasi janin dilakukan pada akhir trimester 2 kehamilan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui posisi dan letak janin, jika pada akhir trimester ke tiga bagian terendah janin bukan kepala, atau belum masuk pintu atas panggul, maka terdapat kesalahan letak atau posisi pada janin, panggul sempit dan atau penyebab masalah lain.
8. Imunisasi tetaus toksoid: imunisasi TT di berikan untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Bidan melakukan skrining imunisasi TT pada ibu hamil dan untuk pemberiannya diberikan sesuai status imunisasi TT pada ibu hamil.
9. Pemberian tablet tambah darah: tablet tambah darah diberikan bidan kepada ibu hami dan ibu hamil wajib mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan dan diberikan bidan kepada ibu hamil sejak pertama kali kontak pemeriksaan kehamilan.
10. Pemeriksaan fisik: bidan melakukan pemeriksaan head to toe

D. Pemeriksaan Kehamilan Trimester II

Pemeriksaan kehamilan pada trimester II (14-28 minggu) yaitu minimal sebanyak 2 kali selama trimester II. Rincian pemeriksaan kehamilan di trimester II yaitu minimal 1 kali bersama bidan dan minimal 1 kali bersama dokter. Pada saat melakukan pemeriksaan kunjungan ulang, atau pemeriksaan lanjutan di kehamilan trimester II, diharapkan ibu hamil datang bersama suami/ keluarga sehingga suami/ keluarga juga dapat mengetahui kondisi ibu hamil maupun janinnya. Kunjungan kehamilan di trimester ke II dapat dilakukan lebih dari dua kali dan atau jika terdapat keluhan selama kehamilan maka ibu hamil diharapkan langsung menemui bidan/ tenaga kesehatan. Pemeriksaan kehamilan pada trimester ke II sama dengan yang telah dilakukan pada pemeriksaan kehamilan trimester I dan ditambahkan dengan edukasi terkait komplikasi yang kemungkinan terjadi di kehamilan trimester 2 serta pengobatannya. Pemeriksaan kunjungan ulang di trimester kedua bertujuan untuk mengevaluasi kesejahteraan ibu dan janin dan mendeteksi komplikasi atau kondisi

patologi dalam kehamilan. Pada kehamilan trimester II juga dilakukan skrining preeklampsia, gemeli, infeksi saluran reproduksi dan infeksi saluran kemih. Bidan juga memberikan informasi terkait kelas ibu hamil dan menganjurkan ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil.

Saat melakukan anamnesa pada ibu hamil trimester II bidan perlu menanyakan tanda-tanda yang berhubungan dengan masalah kehamilan dan penyakit yang kemungkinan dialami oleh ibu hamil seperti: apakah ibu hamil mual dan muntah di kehamilan trimester II ini ?, apakah ibu hamil merasakan pusing, nyeri kepala, nyeri abdomen? Apakah ibu hamil mengalami perdarahan, demam, batuk dalam waktu yang lama serta merasa cepat lelah? Apakah ibu mengalami keputihan berlebih serta kurang pergerakan janin?. Jika ibu hamil merasakan beberapa tanda tersebut, bidan harus proaktif dalam memberikan informasi pengetahuan kesehatan terkait masalah yang kemungkinan terjadi pada ibu hamil dan mengharuskan ibu hamil untuk segera mendatangi bidan atau petugas kesehatan terdekat jika mengalami hal tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan pada saat kunjungan ulang trimester II yaitu: pemeriksaan TTV, pemeriksaan berat badan, pemeriksaan fisik head to toe, pemeriksaan HB, pemeriksaan urin, pemeriksaan glukosa urin dan gula darah, serta melakukan pemeriksaan penunjang lain seperti BTA, HIV, sifilis, malaria dan USG.

E. Pemeriksaan Kehamilan Trimester III

Pada kehamilan trimester III, ibu hamil melakukan pemeriksaan yang sama seperti dilakukan di kehamilan trimester sebelumnya yang memiliki prinsip dan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat permasalahan dalam kehamilan dan cara mengatasinya. Bidan juga memantau tumbuh kembang janin dengan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri dan disesuaikan dengan umur kehamilan serta melakukan pemeriksaan Leopold dan mendengarkan DJJ. Pada kehamilan trimester III bidan juga melakukan pemeriksaan protein urin untuk mendeteksi dini terhadap kemungkinan preeklampsia pada ibu hamil. Selain itu, bidan juga melakukan pemeriksaan hemoglobin terutama jika dicurigai ibu hamil mengalami anemia. Bidan juga menganjurkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan USG kepada dokter dan merencanakan persalinannya.

Pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil, bidan diharapkan mampu memberikan diagnosa dan asuhan yang tepat dan memastikan kehamilan tersebut apakah berlangsung normal atau terdapat kendala dalam kehamilan tersebut sehingga apabila kehamilan tersebut berlangsung secara tidak normal maka bidan mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam berkonsultasi dan merujuk ibu hamil tersebut ke fasilitas kesehatan yang lebih

lengkap. Hal penting yang perlu dilakukan oleh bidan dalam menentukan diagnosa kebidanan yaitu dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan pada ibu hamil yang benar dan tepat. Hasil pemeriksaan yang normal pada ibu hamil yaitu tekanan darah <140/90 mmHg, penambahan berat badan sesuai dengan IMT sebelum hamil, oedema pada ibu hanya terjadi pada ekstremitas, tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan, djj 120-160 kali/menit, gerakan janin mulai 16-20 minggu hingga melahirkan. Dengan begitu, bidan dapat memastikan jika kehamilan pada ibu berlangsung secara normal dan sehat tanpa ada komplikasi.

Sesaat setelah melakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap ibu hamil, bidan langsung memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu maupun suami/keluarganya. Bidan juga memberikan konseling dan pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh ibu hamil.

Pada kehamilan trimester III bidan melakukan pemeriksaan fisik diantaranya

1. KU dan TTV : untuk mengetahui keadaan ibu hamil secara umum dan memastikan keadaan ibu hamil dan janin berlangsung baik dan normal.
2. Berat bada : mengetahui dan memantau penambahan berat badan ibu hamil apakah kurang atau berlebih.
3. Kepala dan leher : melihat dan menilai apakah wajah ibu pucat (anemia) dan apakah terdapat oedema pada wajah ibu
4. Payudara : menilai payudara ibu apakah terdapat pengeluaran kolostrum dan menilai apakah puting ibu keluar atau tenggelam.
5. Abdomen : mengukur tinggi fundus uteri, melakukan pemeriksaan leopold, mendeteksi apakah terdapat gemeli, mendeteksi kelainan letak, dan mendengarkan DJJ.
6. Ekstremitas atas dan bawah: menilai apakah terdapat oedema.
7. Punggung dan genetalia : jika terdapat keluhan
8. Pemeriksaan hemoglobin : untuk menilai apakah ibu mengalami anemia
9. Protein urin : indikasi kejadian preelampsia pada ibu hamil
10. Pemeriksaan fisik lain : dilakukan jika pada pemeriksaan sebelumnya terdapat keluhan seperti perdarahan, sesak nafas dan keadaan berbahaya lainnya
11. Pemeriksaan penunjang : BTA, HIV, sifilis, malaria dan USG dilakukan jika terdapat indikasi.

Salah satu yang perlu di perhatikan bidan yaitu memastikan status imunisasi ibu hamil untuk memastikan ketepatan dalam pemberian imunisasi TT.

Ringkasan penatalaksanaan yang dilakukan oleh bidan dapat dilihat pada tabel diawah ini : (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016)

Table 1.1 Ringkasan Penatalaksanaan

Penatalaksanaan	Trimester		
	1	2	3
Pemberian suplemen dan pencegahan penyakit			
Skrining status TT dan vaksinasi sesuai status	√		
Zat besi dan asam folat	√		
Aspirin	Atas indikasi	Atas indikasi	Atas indikasi
Kalsium	Atas indikasi	Atas indikasi	Atas indikasi
Pendidikan kesehatan			
Pendidikan persalinan	√	√	√
Pentingnya peran suami atau pasangan serta keluarga selama kehamilan dan persalinan	√	√	√
Tanda bahaya yang perlu diwaspadai ibu hamil selama kehamilan maupun persalinan	√	√	√
Pemberian IMD dan ASI eksklusif	√	√	√
Penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin (hipertensi, TB, HIV serta penyakit menular seksual lainnya)	√	√	√
Pengetahuan terkait bahaya rokok dan konsumsi minuman beralkohol	√	√	√
Penggunaan kontrasepsi pasca bersalin	√	√	√
Informasi terkait kekerasan terhadap wanita	√	√	√
Kebersihan diri ibu, aktifitas dan nutrisi	√	√	√
Identifikasi komplikasi dan rujukan	√	√	√
Kehamilan dengan masalah khusus (kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan finansial dan lain-lain)	√	√	√
Kehamilan dengan disertai masalah kesehatan yang memerlukan rujukan/ kerjasama dengan petugas kesehatan lainnya, misalnya: 1. Riwayat kehamilan sebelumnya antara lain janin atau neonatus mati, keguguran >3x, berat bayi <2500 gram atau >4500 gram, hipertensi serta pembedahan pada organ reproduksi. 2. Gemeli (kehamilan ganda), usia ibu <16 tahun atau >40tahun, Rh (-), dan penyakit lainnya.	√	√	√

Kehamilan dengan kondisi kegawatdaruratan yang membutuhkan rujukan segera (perdarahan, preeklampsia, eklampsia, KPD, gawat janin, atau kondisi lain yang mengancam kesehatan ibu)	√	√	√
---	---	---	---

F. Pentingnya Pemantauan Kesehatan Ibu dan Janin

Pemeriksaan kesehatan selama kehamilan kepada ibu dan janin sangat penting dan berperan besar dalam mengurangi angka kematian ibu dan janin. Pemantauan kesehatan untuk mengurangi AKI dan AKB tidak hanya dilakukan ketika masa kehamilan melainkan jauh sebelum ibu mengalami kehamilan. Pertumbuhan sangat cepat terjadi pada usia remaja (<18 tahun), pada usia ini pertumbuhan akan optimal apabila asupan zat gizi makro dan mikro terpenuhi. Nutrisi selama kehamilan sangat berperan penting dalam menunjang kualitas hidup ibu dan janin yang dikandungnya. Jika nutrisi yang dikonsumsi ibu selama masa kehamilan tidak adekuat maka akan berdampak pada kehamilan dan persalinannya kelak. Kurangnya konsumsi zat besi selama masa kehamilan akan menyebabkan ibu hamil mengalami anemia. Ibu hamil yang mengalami anemia akan meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, abortus, prematur, risiko perdarahan sebelum atau setelah persalinan yang dapat mengancam nyawa ibu maupun janin.

1. Suport/ dukungan bidan dan tenaga kesehatan

Dukungan bidan dalam pemantauan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan sangat memiliki peran besar terhadap kepatuhan ibu melakukan pemeriksaan kehamilannya. Pada saat melakukan pemeriksaan dan atau asuhan kehamilan, bidan dapat mengedepankan sikap empati serta memberikan pelayanan berkualitas kepada ibu hamil sehingga mampu membuat ibu hamil tersebut merasa tenang dan nyaman ketika memeriksakan kehamilannya. Ibu hamil yang merasa puas dengan pelayanan yang didapatkan akan membuatnya kembali memeriksakan kehamilannya. Dalam melakukan pemeriksaan dan asuhan kehamilan, bidan harus mampu berkomunikasi yang baik dengan ibu hamil. Pada saat berkomunikasi dengan ibu hamil, sesekali bidan diharapkan dapat menunjukkan rasa empatynya kepada ibu dengan cara sentuhan lembut ke punggung ibu agar menciptakan perasaan aman dan terciptanya rasa saling percaya antara ibu hamil dan bidan.

2. Suport/ dukungan suami dan keluarga

Ketika hamil, ibu hamil memerlukan dukungan psikologi dari suami dan keluarga yang berguna untuk kesehatan dan pemulihan ibu hamil secara keseluruhan. Cinta dan kasih sayang yang diberikan suami dan keluarga serta

perlakuan positif juga akan selalu membuat suasana hati ibu menjadi selalu senang dan menghindarkan ibu dari kejadian stress ketika hamil.

G. Asuhan Kebidanan Kehamilan Trimester I

Bidan atau petugas kesehatan harus mampu memberikan asuhan yang menyeluruh selama masa kehamilan untuk mempersiapkan kelahiran bayi yang sehat dan sejahtera. Kunjungan awal ibu hamil biasanya dilakukan ketika ibu hamil pertama kali memeriksakan kehamilannya kepada bidan atau petugas kesehatan. Pada kunjungan awal, bidan harus mampu memberikan diagnosa yang akurat apakah ibu tersebut hamil atau tidak. Setelah mendapati hasil pemeriksaan pada ibu hamil, bidan menjelaskan hasil yang didapati kepada ibu hamil serta bidan harus membangun kepercayaan kepada ibu hamil agar proses asuhan kebidanan yang dilakukan berjalan lancar. Pada kehamilan trimester I, bidan juga memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil terkait ketidaknyamanan yang akan ibu hamil rasakan akibat perubahan fisiologis. Ketidaknyamanan yang mungkin timbul di kehamilan trimester satu diantaranya perubahan pada payudara, mual muntah, sering merasa lelah dan letih, pusing, nyeri kepala, peningkatan salivasi, sering berkemih, keputihan berlebih, serta perubahan pada kulit. Ibu hamil trimester satu juga merasakan ketidaknyamanan psikologis seperti perubahan suasana perasaan/ mood swing. Bidan diharapkan mampu berempati dan memberikan pendidikan kesehatan terkait ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh perubahan fisiologis dan psikologis ibu hamil dengan memberikan informasi cara mengatasi ketidaknyamanan tersebut.

H. Asuhan Kebidanan Kehamilan Trimester II

Asuhan yang diberikan pada ibu hamil trimester II tidak jauh berbeda dengan ibu hamil trimester I. Bidan memberikan asuhan sesuai anamnesa dan diagnosis dari ibu hamil serta melakukan pemeriksaan penunjang pada kasus yang diperlukan. Pada kehamilan trimester II, ibu hamil sering mengalami ketidaknyamanan selama kehamilan. Bidan diharapkan mampu memberikan solusi terhadap ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu hamil. Ketidaknyamanan yang dialami ibu diantaranya: perubahan warna kulit (chloasma dan atau striae), konstipasi, oedema, heartburn, varises dan lain sebagainya. Selain menjelaskan penanganan ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu hamil pada trimester II, bidan juga harus menjelaskan sejumlah tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh ibu hamil.

I. Asuhan Kebidanan Kehamilan Trimester III

Pada kehamilan trimester III, ibu hamil akan semakin mengalami ketidaknyamanan saat kehamilan. Uterus yang semakin membesar juga menyebabkan salah satu ketidaknyamanan pada ibu hamil. Pada trimester ini ibu hamil juga banyak merasakan gelisah akibat ketidaknyamanan yang ibu alami. Asuhan yang diberikan bidan diantaranya:

1. Anjurkan untuk mengkonsumsi nutrisi seimbang sesuai anjuran ISI PIRINGKU, makan sayur dan buah-buahan yang cukup agar ibu terhindar dari sembelit dan ambeien.
2. Menganjurkan ibu hamil untuk melakukan olahraga ringan seperti senam ibu hamil ataupun yoga ibu hamil.
3. Melakukan pemberian edukasi kesehatan terkait tanda bahaya kehamilan dan tanda bahaya persalinan.
4. Memberikan massage pada punggung jika untuk merileksasi agar nyeri punggung yang dirasakan ibu dapat berkurang.
5. Anjurkan ibu untuk istirahat cukup, perbanyak aktifitas di pagi-siang hari sehingga ibu tidak mengalami kesulitan tidur di malam hari.
6. Anjurkan ibu untuk mendengarkan musik yang menenangkan atau mendengarkan ayat Al-Quran agar ibu merasa tenang.

J. Kesimpulan

Pemeriksaan kehamilan rutin yang dilakukan oleh ibu hamil mulai dari trimester I hingga trimester III dapat menekan terjadinya kejadian kegawatdaruratan pada ibu dan janin. Pentingnya pemantauan kehamilan pada ibu hamil dikarenakan dengan melakukan kunjungan kehamilan pada bidan/ petugas kesehatan, ibu hamil mampu memantau perkembangan serta memastikan kehamilannya berjalan dengan normal. Kepatuhan kunjungan ibu hamil tentunya tidak jauh dari dukungan lingkungan dan keluarga dalam hal ini suami. Peran suami sangat mendukung tercapainya kepatuhan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh ibu hamil selama masa kehamilannya.

K. Referensi

- Astuti, S., Susanti, A., & Nurparidah, R. (2017). Asuhan Ibu Dalam Masa Kehamilan. In Erlangga.
- Huru, M. M., Yulianti, H., Kristin, D. M., Seran, A. A., Mamoh, K., & Mangi, J. L. (2023). PEMERIKSAAN KEHAMILAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN UNTUK MENCEGAH STUNTING DALAM 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN. JMM

(Jurnal Masyarakat Mandiri), 7(1), 807.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12761>

Kemenkes RI. (2020). PEDOMAN PELAYANAN ANTENATAL TERPADU (Edisi ke 3).

Kementerian kesehatan RI. (2021). Buku Saku Merencanakan Kehamilan Sehat.

Mutalib, R., Siregar, A. A., Layuk, N., & Djama, N. T. (2024). Buku Ajar ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN. AIKOMEDIA PRESS.

Oktapianti, R., & Triyanti, D. (2023). HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL DENGAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN (ANTENATAL CARE) DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG. *Masker Medika*, 11(1), 166–172.
<https://doi.org/10.52523/maskermedika.v11i1.532>

Tyastuti, S., & Wahyuningsih, H. F. (2016). Asuhan Kebidanan Kehamilan (Pertama). Pundik SDM Kemenkes.

L. Glosarium

AKI	: Angka kematian ibu
AKB/AKN	: Angka kemarian bayi/ angka kematian neonatal
BBLR	: Berat badan lahir rendah
Lila	: Lingkar lengan atas
KEK	: Kekurangan energi kronik
TD	: Tekanan darah
TFU	: Tinggi fundus uteri
TB	: Tuberkulosis
KU	: Keadaan umum
TTV	: Tanda-tanda vital
HIV	: Human immunodefisiensi virus

CHAPTER 2

NUTRISI DAN SUPLEMEN SELAMA KEHAMILAN

Bd. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb., M.KM.

A. Pendahuluan/Prolog

Nutrisi selama hamil merupakan asupan makanan dan nutrisi yang diperlukan guna mendukung kesehatan ibu hamil serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin yang optimal. Nutrisi ini mencakup berbagai macam makronutrien (karbohidrat, protein, lemak) dan mikronutrien (vitamin dan mineral) yang penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang meningkat selama kehamilan. Selain itu ibu hamil perlu memperhatikan asupan gizinya selama kehamilan sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin maupun untuk keperluan pertumbuhan dan perkembangan janin. Sebab itu seorang ibu hamil juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu seperti asam folat, asam lemak tak jenuh, vitamin B6, vitamin B12, vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, seng, dan Iodium.

Masa kehamilan ialah masa yang penting bagi kesehatan bayi dimulai dari janin hingga ke tahap kehidupan selanjutnya, termasuk kesehatan pada ibu itu sendiri. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak bayi, seperti kecerdasan, resiko melahirkan janin dengan kondisi berat badan bayi lahir rendah dibawah 2500 gr serta ibu beresiko terjadinya komplikasi pada saat proses persalinan.

Pada masa kehamilan nutrisi merupakan pengaruh paling utama untuk tumbuh kembang janin. Jika ibu hamil bermasalah pada asupan nutrisi, akan sangat berdampak pada janin. Apabila nutrisinya seimbang dan tercukupi, maka janinnya akan sehat dalam kandungan maupun saat lahir, apabila nutrisinya tidak seimbang dan tercukupi, maka janin yang dikandungnya akan berdampak tidak baik hingga kemungkinan terjadi kelainan pada janinnya. Untuk melihat nutrisi ibu hamil tidak dilihat dari jumlah nutrisi pada tiap porsi yang dimakan, tetapi dilihat pada kandungan pada tiap porsi makanan yang dikonsumsi tersebut

Jika seorang ibu hamil kekurangan nutrisi, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah Kekurangan Energi Kronis (KEK), yang bisa berdampak negatif pada ibu, seperti kelemahan fisik, kekurangan zat besi, pendarahan, berat badan tidak sesuai usia kehamilan, dan diabetes. Pada janin, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), anemia,

keguguran, hingga kematian janin. Kekurangan gizi juga bisa secara tidak langsung menyebabkan kematian ibu dan anak, meskipun hal ini sebenarnya masih bisa dicegah. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kekurangan gizi karena kebutuhan gizi yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin yang dikandung.

B. Defenisi Kehamilan

Suatu keadaan atau kondisi ketika seorang wanita membawa janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya disebut kehamilan. Proses kehamilan dimulai dari pembuahan, yaitu ketika sel sperma berhasil membuahi sel telur, dan berlangsung hingga kelahiran bayi. Selama periode ini, tubuh wanita mengalami berbagai perubahan fisik dan hormonal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin.

Kehamilan adalah periode penting yang memerlukan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan janin, termasuk perawatan prenatal, nutrisi yang tepat, dan pengawasan medis rutin.

Kehamilan biasanya berakhir pada usia 40 minggu atau sekitar 9 bulan, yang dikelompokkan menjadi tiga trimester:

1. Trimester Pertama (0-12 minggu): Pada tahap ini, pembentukan organ-organ dasar janin terjadi, dan wanita hamil mungkin mengalami gejala awal seperti mual dan kelelahan.
2. Trimester Kedua (13-26 minggu): Pada tahap ini, janin mulai berkembang lebih pesat, ibu biasanya merasa lebih energik, dan perubahan fisik seperti pembesaran perut mulai terlihat.
3. Trimester Ketiga (27-40 minggu): Janin terus berkembang dan bersiap untuk kelahiran. Ibu mungkin mengalami ketidaknyamanan fisik yang meningkat karena pertumbuhan janin yang signifikan.

C. Nutrisi Dan Suplemen Selama Kehamilan

Nutrisi dan suplemen selama masa kehamilan mencakup yaitu :

1. Karbohidrat

Karbohidrat adalah salah satu dari tiga makronutrien utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, selain protein dan lemak. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, terutama bagi otak dan sistem saraf. Mereka terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen.

Secara umum, karbohidrat dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

- a. Gula Sederhana (Monosakarida dan Disakarida): Ini termasuk glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Mereka cepat diserap oleh tubuh dan memberikan energi instan.

- b. Karbohidrat Kompleks (Polisakarida): Ini termasuk pati dan serat. Pati ditemukan dalam makanan seperti roti, pasta, nasi, dan kentang, sedangkan serat ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian.
- c. Serat: Meskipun tidak dicerna oleh tubuh, serat sangat penting untuk pencernaan yang sehat dan membantu mencegah berbagai penyakit.

Tubuh mengubah karbohidrat menjadi glukosa (gula darah), yang kemudian digunakan sebagai energi atau disimpan dalam otot dan hati untuk digunakan nanti.

Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa merupakan sumber energi utama bagi pertumbuhan. Janin membutuhkan persediaan glukosa dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pertumbuhannya. Kebutuhan karbohidrat saat masa kehamilan adalah sekitar 50 – 60% dari total energi. Jumlah minimal karbohidrat yang disarankan bagi wanita hamil adalah sekitar 175 gram. Sedangkan dalam AKG tahun 2019 penambahan kebutuhan karbohidrat adalah sebesar 25 gram pada trimester pertama dan 40 gram pada trimester kedua dan ketiga.

Konsumsi karbohidrat yang tidak mencukupi pada ibu hamil beresiko terhadap pertumbuhan janin. Pembatasan ringan karbohidrat dapat dianjurkan hanya pada ibu hamil yang menderita diabetes. Apabila ibu hamil mengalami diabetes sebelum kehamilan ataupun saat kehamilan maka pembatasan karbohidrat akan diperlukan namun harus dipastikan janin tetap memperoleh glukosa yang cukup untuk pertumbuhan.

Untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan yaitu karbohidrat sebagai sumber utama yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Roti, serelia, nasi dan pasta merupakan jenis karbohidrat yang dianjurkan. Vitamin dan mineral serta meningkatkan asupan serat untuk mencegah terjadinya konstipasi mengandung karbohidrat kompleks.

Aneka makanan yang mengandung serat seperti sayur, buah dan produk whole grain sangatlah direkomendasikan dikonsumsi oleh ibu hamil. Bahan makanan ini mengandung antioksidan dan serat bermanfaat untuk mengatasi konstipasi. Konstipasi yang terjadi pada masa kehamilan yang disebabkan oleh penurunan motilitas saluran pencernaan. Dengan konsumsi serat 12- 24 gram per hari diimbangi dengan konsumsi air yang cukup maka akan membantu mengatasi konstipasi pada kehamilan.

2. Protein

Penambahan kebutuhan protein selama masa kehamilan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi tahun 2019 adalah sebesar 1 gram untuk trimester pertama, 10 gram untuk trimester kedua dan 30 gram untuk trimester ketiga.

Penambahan protein ini berfungsi untuk proses sintesis jaringan kehamilan dan jaringan janin. Jenis protein yang dikonsumsi seperlimanya sebaiknya berasal dari protein hewani seperti daging, ikan, telur, susu, yogurt dan selebihnya berasal dari protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan dan lain-lain.

Adanya penyesuaian fisiologis pada metabolisme protein menyebabkan adanya pergeseran fungsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Hal ini mengakibatkan penurunan penggunaan protein untuk energi dan peningkatan sintesis protein.

Peningkatan protein saat kehamilan disebabkan oleh adanya pertambahan jaringan protein. Sekitar 925 gram protein akan terakumulasi pada jaringan protein saat kehamilan, 440 gram akan diserap oleh janin, 216 gram digunakan untuk peningkatan darah dan volume cairan ekstraseluler dan 100 gram protein terakumulasi pada plasenta. Peningkatan kebutuhan protein juga dibutuhkan untuk proses perkembangan jaringan.

Apabila terjadi defisiensi protein pada masa kehamilan hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan janin yang terhambat. Dimana protein juga terlibat dalam sintesis hormone dan neurotransmitter. Inadequate intake protein dan energi biasanya terjadi secara bersamaan, sehingga sulit untuk menentukan efek kekurangan energi dan kekurangan protein. Karena itu ada beberapa kelompok yang harus diperhatikan karena beresiko untuk defisiensi intake protein yaitu pada vegetarian dan kehamilan kembar.

Seorang ibu hamil membutuhkan sekitar 60 gram setiap harinya atau 10 gram lebih banyak dari kondisi sebelum hamil. Kebutuhan protein bisa didapat dari nabati maupun hewani. Sumber protein hewani seperti daging tak berlemak, ikan, telur, susu. Sedangkan sumber nabati seperti tahu, tempe dan kacang-kacangan. Protein berfungsi sebagai :

- a. Pertumbuhan jaringan baru, baik plasenta dan janin.
- b. Perkembangan dan diferensiasi sel.
- c. Pembentukan cadangan darah.
- d. Proses laktasi.

3. Lemak

Berdasarkan AKG 2019 untuk penambahan kebutuhan lemak pada masa kehamilan sesuai pada ibu hamil dengan adalah sebesar 2.3 gram pada tiap trimester. Asam lemak esensial yaitu DHA dan AA sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi saat masa kehamilan. DHA dan AA sangat dibutuhkan untuk pembentukan otak dan sistem syaraf pada janin terutama di akhir masa kehamilan. Minyak ikan merupakan sumber DHA yang paling baik. Menurut

penelitian tentang konsumsi DHA pada masa kehamilan dan mampu memberikan manfaat dalam berat badan lahir bayi dan durasi kehamilan.

Lemak bertugas sebagai sumber tenaga, pertumbuhan jaringan plasenta dan persiapan ibu sewaktu menyusui. Kadar lemak akan meningkat pada akhir usia kehamilan. Perkembangan dan pertumbuhan janin selama dalam kandungan sebagai kalori utama membutuhkan lemak.

4. Vitamin A

Fungsi vitamin A untuk pertumbuhan dan perkembangan janin saat kehamilan. Vitamin A juga berperan dalam diferensiasi sel, perkembangan pengelihan, fungsi imunitas dan perkembangan paru-paru. Kebutuhan vitamin A pada masa kehamilan mengalami peningkatan sebesar 300 RE tiap trimester. Sumber vitamin A dapat diperoleh baik dari produk hewani maupun non hewani. Makanan sumber vitamin A dapat diperoleh melalui susu, sayuran berdaun hijau, buah-buahan berwarna orange dan kuning. Jika ibu hamil mengalami kekurangan vitamin A maka dapat mengakibatkan kejadian IUGR (*Intra Uterine Growth Restriction*) dan peningkatan mortalitas ibu dan bayi.

5. Asam Folat, Thiamin, Riboflavin,

Asam folat, Thiamin (Vitamin B1) dan Riboflavin (vitamin B2) berfungsi dalam metabolisme energi. Berdasarkan AKG kebutuhan thiamin dan riboflavin mengalami peningkatan sebesar 0.3 mg pada tiap trimester. Ibu hamil sangat direkomendasikan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung riboflavin yang terdapat pada susu dan produk susu, cereal dan produk cereal, daging dan produk daging, dan sayuran hijau.

Konsumsi suplementasi asam folat sebelum kehamilan juga direkomendasikan untuk mencegah anemia megaloblastic. Konsumsi bahan makanan seperti sayuran hijau, hati, cereal produk, kacang-kacangan dan jeruk merupakan makanan sumber asam folat. Asam Folat dibutuhkan untuk membangun sel dan sistem syaraf janin. Saat trimester satu janin akan membutuhkan 400 mikrogram asam folat per hari. Dan apabila tidak terpenuhi, akan membuat perkembangan janin tidak sempurna (*anencephaly* (tanpa batok kepala), bibir sumbing dan menderita spina bifida / kondisi dimana tulang belakang tidak tersambung. Kandungan asam folat bisa diperoleh dari buah-buahan, beras merah, kacang-kacangan dan beragam sayuran hijau.

6. Vitamin C

Vitamin C sangat penting bagi ibu hamil karena membantu mendukung sistem kekebalan tubuh, meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati, dan berperan dalam perkembangan jaringan dan tulang janin. manfaat vitamin C selama masa kehamilan yaitu:

- a. Penyerapan Zat Besi : Vitamin C membantu tubuh dalam menyerap zat besi non-heme, yang ditemukan dalam sumber makanan nabati. Ini penting untuk mencegah anemia pada ibu hamil.
- b. Pertumbuhan dan Perkembangan : Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen, yang penting untuk pertumbuhan kulit, tendon, ligamen, dan pembuluh darah pada janin.
- c. Sistem Kekebalan Tubuh : Vitamin C membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ibu hamil, melindungi dari infeksi dan penyakit.
- d. Antioksidan : Vitamin C merupakan antioksidan yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

Biasanya, kebutuhan vitamin C harian untuk ibu hamil adalah sekitar 85 mg per hari. Namun, selalu baik untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai suplemen dan pola makan yang tepat selama kehamilan. Vitamin C berperan penting dalam meningkatkan penyerapan zat besi.

Sumber vitamin C yang baik untuk ibu hamil termasuk buah-buahan seperti jeruk, stroberi, kiwi, dan pepaya, serta sayuran seperti brokoli, paprika, dan bayam. Ibu hamil juga disarankan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C bersamaan dengan makanan yang kaya zat besi untuk memaksimalkan penyerapan zat besi. Buah-buahan seperti jeruk, pepaya, stroberi, dan lainnya adalah sumber vitamin C yang baik.

7. Vitamin D

Vitamin D untuk ibu hamil merupakan salah satu nutrisi esensial yang berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu serta perkembangan janin. Berikut adalah beberapa manfaat vitamin D bagi ibu hamil :

- a. Penyerap Kalsium dan Fosfor: Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor, dua mineral penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang serta gigi. Hal ini sangat penting bagi pertumbuhan tulang janin yang sehat.
- b. Mendukung Sistem Imun: Vitamin D memperkuat sistem kekebalan tubuh ibu, membantu melindungi dari infeksi dan penyakit.
- c. Mencegah Komplikasi: Kekurangan vitamin D selama kehamilan dapat meningkatkan risiko preeklampsia, kelahiran prematur, dan komplikasi lainnya.
- d. Pertumbuhan Janin: Vitamin D mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh janin.

Adapun sumber Vitamin D yaitu:

- a. Sinar Matahari : Tubuh memproduksi vitamin D ketika kulit terkena sinar matahari langsung. Sekitar 10-15 menit paparan sinar matahari pagi biasanya sudah cukup.

- b. Makanan : makanan yang bersumber dari Ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan makarel, hati sapi, keju dan kuning telur, produk makanan dan minuman yang diperkaya vitamin D seperti susu, sereal, dan jus jeruk
- c. Suplemen : Jika asupan vitamin D dari makanan dan sinar matahari tidak mencukupi, suplemen vitamin D dapat direkomendasikan oleh dokter.

Biasanya, kebutuhan vitamin D harian untuk ibu hamil adalah sekitar 600 IU (International Units). Namun, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk memastikan dosis yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan individu. Kekurangan vitamin D pada masa kehamilan dapat menurunkan masa tulang pada anak dan juga mampu meningkatkan resiko osteoporosis pada masa yang akan datang. Kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan penyakit riket dan resiko patah tulang.

8. Kalsium

Berdasarkan AKG tahun 2019 diketahui bahwa peningkatan kebutuhan kalsium pada masa kehamilan adalah sebesar 200 mg. Kalsium diperlukan untuk mineralisasi tulang dan gizi janin. Kekurangan kalsium dapat beresiko terhadap IUGR dan preeklamsi. Kalsium juga berperan dalam beberapa proses dalam tubuh seperti pembekuan darah, *proteolysis intraseluler*, sintesis nitrit oksida dan regulasi kontraksi uterine.

Pada masa kehamilan, metabolisme kalsium mengalami perubahan. Penyerapan kalsium menjadi meningkat sedangkan ekskresi kalsium pada urin menurun. Peningkatan kebutuhan kalsium juga terjadi dengan pengeluaran kalsium pada tulang. Peningkatan pengeluaran kalsium pada tulang mampu tergantikan kembali setelah masa kehamilan apabila ibu mengonsumsi kalsium dan vitamin D dalam jumlah yang cukup. Konsumsi kalsium dapat dipenuhi melalui konsumsi bahan makanan sumber kalsium seperti produk susu, ikan dan jus yang sudah difortifikasi kalsium, bayam, brokoli, sari kedelai, kacang-kacangan.

Kalsium berguna untuk pembentukan gigi dan tulang janin di dalam kandungan dan mencegah osteoporosis pada ibu hamil. Sumber zat kalsium diantaranya adalah susu dan produk olahan susu lainnya.

9. Zat Besi

Zat besi pada pertumbuhan dan perkembangan janin memiliki peran dalam cofactor enzim yang terlibat proses reaksi oksidasi dan reduksi, yang terjadi pada tingkat sel selama proses metabolisme. Zat besi merupakan kelompok trace mineral yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Zat besi juga merupakan komponen penting dari hemoglobin yang membawa oksigen pada sel darah merah keseluruh tubuh.

Kondisi kehamilan menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan zat besi pada tubuh. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan volume darah selama masa kehamilan. Sesuai AKG 2019 diketahui bahwa peningkatan kebutuhan zat besi adalah sebesar 9 mg pada trimester II dan trimester III. Ibu hamil diharapkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah, namun konsumsi tablet tambah darah memiliki beberapa efek samping seperti konstipasi dan mual. Salah satu strategi dalam meredakan efek samping akibat konsumsi tablet tambah darah adalah dengan mengkonsumsinya sebelum tidur.

Daging merah, telur, produk ikan, sereal yang di fortifikasi dan sayuran berwarna hijau. Konsumsi vitamin C dibarengi dengan konsumsi sumber zat besi yang berasal dari sayuran sangat direkomendasikan untuk meningkatkan penyerapan zat besi merupakan sumber makanan yang mengandung zat besi.

D. Manfaat Nutrisi dan Suplemen Untuk Ibu Hamil

Nutrisi dan suplemen seimbang yang di konsumsi sehari-hari mengandung berbagai jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Berikut manfaat gizi seimbang yaitu :

1. Pemenuhan nutrisi ibu dan janin
2. Mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman
3. Membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu
4. Mengatasi permasalahan selama kehamilan
5. Ibu mendapat asupan yang cukup untuk prosen masa nifas
6. Mencegah terjadinya berat badan lahir rendah
7. Mencegah terjadinya anemia saat hamil
8. Mencegah bayi lahir cacat

Menggunakan aneka bahan makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi, protein dan vitamin serta mineral sebagai pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan janin serta cadangan selama masa menyusui. Kurangi konsumsi yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi karena meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Serta minum air putih lebih banyak mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion dan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Perbanyak minum air putih sekitar 2-3 liter perhari (8 12 gelas sehari). Hindari minum kopi, kandungan kafein dalam kopi meningkatkan buang air

kecil yang berakibat dehidrasi, tekanan darah meningkat dan detak jantung meningkat.

Sehubungan dengan hal itu, ibu hamil harus mempunyai status gizi yang baik dan mengonsumsi makanan yang beranekaragam baik proporsi maupun jumlahnya. Selain itu kondisi ini dapat diperburuk oleh beban kerja ibu hamil yang biasanya sama atau lebih berat dibandingkan dengan sebelum hamil. Penyebabnya, bayi kurang mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Ada 13 Pesan umum Gizi Seimbang, yaitu :

1. Konsumsi beragam jenis makanan
2. Konsumsi makanan yang mencukupi kebutuhan energi
3. Konsumsi sumber karbohidrat untuk mencukupi kebutuhan energi
4. Kurangi konsumsi lemak seperempat dari kecukupan energi
5. Pakai garam beryodium
6. Konsumsi makanan sumber zat besi
7. Asi eksklusif pada bayi
8. Biasakan sarapan pagi
9. Minum air mineral
10. Lakukan aktifitas fisik
11. Jauhi minuman beralkohol
12. Konsumsi makanan yang sehat
13. Periksa bungkus makanan saat pembelian.

Sementara itu untuk ibu hamil ada tambahan 4 pesan khusus, yaitu :

1. Mengonsumsi aneka ragam makanan secara teratur
2. Kurangi mengonsumsi garam
3. Perbanyak minum air putih
4. Kurangi konsumsi minum kopi.

E. Jenis-Jenis Bahan Makanan Yang Dihindari

Makanan merupakan elemen yang sangat krusial dalam kehidupan kita, terutama bagi ibu selama masa kehamilan. Makanan yang bergizi akan memberikan nutrisi penting bagi tubuh ibu dan perkembangan calon bayi. Namun, ada juga jenis makanan yang berpotensi berbahaya dan dapat menimbulkan risiko serius bagi kehamilan, sehingga perlu dihindari. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa saja makanan yang dilarang untuk ibu hamil, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Alkohol

Minuman ini pastinya harus dihindari ibu hamil, bahkan orang yang berada dalam kondisi normal pun sebaiknya melakukan hal ini. Sangat disarankan untuk

benar- benar menghindari minum alkohol saat hamil, karena dapat meningkatkan risiko keguguran dan kematian di dalam kandungan. Bahkan jumlah kecil pun dapat berdampak negatif pada perkembangan otak bayi kita. Minum alkohol selama kehamilan juga dapat menyebabkan sindrom alkohol janin, yang meliputi kelainan bentuk wajah, kelainan jantung, dan cacat intelektual. Karena tidak ada tingkat alkohol yang terbukti aman selama kehamilan, disarankan untuk menghindarinya sama sekali.

2. Daging yang Mentah

Beberapa masalah yang sama dengan ikan mentah juga ditemukan dalam daging yang kurang matang. Makan daging yang kurang matang atau mentah akan meningkatkan risiko infeksi dari beberapa bakteri atau parasit, termasuk Toxoplasma, E. coli, Listeria, dan Salmonella.

Jenis bakteri ini dapat mengancam kesehatan janin bayi, dan mungkin juga menyebabkan kematian di dalam kandungan atau penyakit saraf yang parah, termasuk cacat intelektual, kebutaan, dan epilepsy. Meskipun sebagian besar bakteri ditemukan di permukaan potongan daging, bakteri lain mungkin tertinggal di dalam serat otot.

3. Kecambah Mentah

Kecambah mentah, lobak dan kacang hijau, dapat terkontaminasi dengan Salmonella. Jenis makanan ini dapat tumbuh di kondisi lingkungan yang lembab. Karena alasan inilah, ibu hamil dilarang makan kecambah mentah sama sekali. Namun, kecambah aman dikonsumsi setelah dimasak.

4. Makanan Junkfood

Tidak ada waktu yang lebih baik daripada kehamilan untuk mulai makan makanan padat nutrisi untuk membantu tubuh ibu dan janin yang sedang tumbuh di dalam kandungan. Ibu juga akan membutuhkan banyak nutrisi penting dalam jumlah yang meningkat, termasuk protein, folat, kolin, dan zat besi. Makanan junkfood mengandung zat gizi yang rendah. Konsumsilah makanan dan camilan yang berfokus pada protein, sayuran dan buah - buahan, lemak sehat, dan karbohidrat kaya serat seperti biji - bijian, kacang- kacangan, dan sayuran

5. Ikan dengan Kandungan Merkuri

Tinggi Merkuri adalah unsur yang sangat beracun dan umum ditemukan di air yang tercemar. Dalam jumlah yang lebih tinggi, makanan dengan merkuri tinggi bisa menjadi racun bagi sistem saraf, sistem kekebalan, dan ginjal kita. Tak hanya itu juga dapat menyebabkan masalah perkembangan yang serius pada anak-anak, dengan efek samping bahkan dalam jumlah yang lebih rendah. Karena ditemukan di laut yang tercemar, maka sebaiknya hindari ikan dengan kadar

merkuri tinggi saat hamil dan menyusui. Ikan dengan kandungan merkuri tinggi antara lain: hiu, ikan tongkol, makarel raja, tuna, marlin.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua ikan mengandung merkuri tinggi, hanya jenis tertentu saja. Ikan dengan kadar merkuri rendah sangat berlimpah, diantaranya adalah: teri, ikan salmon, jenis ikan air tawar. Ikan berlemak seperti salmon dan ikan teri adalah pilihan yang sangat baik karena mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi, yang penting untuk janin di dalam kandungan kita.

6. Daging Jeroan

Daging jeroan atau organ dalam merupakan sumber berbagai nutrisi, termasuk zat besi, vitamin B12, vitamin A, seng, selenium, dan tembaga, lemak. Semua nutrisi ini baik untuk ibu hamil dan janin. Namun, makan terlalu banyak vitamin A hewani (vitamin A dalam bentuk sebelumnya) tidak dianjurkan selama kehamilan. Mengonsumsi terlalu banyak vitamin A terutama pada trimester pertama kehamilan, dapat menyebabkan kelainan bentuk bawaan dan keguguran.

7. Ikan Mentah

Ibu hamil dilarang mengonsumsi mentah. Ikan memang memiliki banyak nutrisi yang baik bagi tubuh kita, namun tidak dengan ikan yang belum benar-benar matang. Ikan mentah, terutama kerang, dapat menyebabkan beberapa infeksi. Ini dapat berupa virus, bakteri atau parasit, seperti norovirus, Vibrio, Salmonella dan Listeria. Sebagian dari infeksi ini hanya mempengaruhi kondisi ibu dan mengalami diare sehingga menyebabkan dehidrasi dan lemah.

8. Kafein

Kafein diserap dengan sangat cepat dan mudah masuk ke dalam plasenta. Karena bayi dan plasentanya tidak memiliki enzim utama yang dibutuhkan untuk memetabolisme kafein, kadar kafein yang tinggi dapat menumpuk. Asupan kafein yang tinggi selama kehamilan dapat membatasi pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko berat badan lahir rendah saat melahirkan.

9. Telur Mentah.

Makanan yang dilarang untuk ibu hamil karena dapat terkontaminasi dengan bakteri Salmonella salah satunya telur mentah. Gejala infeksi salmonella yang mungkin akan timbul seperti demam, mual, muntah. Untuk amannya, pastikan selalu memasak telur sampai matang atau gunakan telur yang sudah dibersihkan.

10. Makanan yang diawetkan

Ibu hamil disarankan untuk menghindari makan makanan yang diawetkan seperti daging yang diawetkan atau ikan asap karena ada risiko kecil makanan ini

mengandung listeria, atau parasit toksoplasma yang menyebabkan toksoplasmosis

11. Makanan yang Tidak Dicuci

Permukaan buah dan sayuran yang tidak dicuci atau dikupas dapat terkontaminasi oleh pestisida, beberapa bakteri dan parasit, seperti Toxoplasma, E. coli, Salmonella, dan Listeria, yang dapat diperoleh dari tanah atau melalui tangan kita.

Kontaminasi dapat terjadi kapan saja selama produksi, panen, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, atau distribusi makanan. Salah satu parasit berbahaya yang mungkin tertinggal pada buah dan sayuran disebut Toxoplasma. Sebagian besar orang yang terkena toksoplasmosis tidak memiliki gejala, sementara ada juga yang mungkin merasa seperti terserang flu selama sebulan atau lebih. Kebanyakan bayi yang terinfeksi bakteri Toxoplasma saat masih dalam kandungan tidak memiliki gejala saat lahir, sebagian kecil bayi baru lahir yang terinfeksi mengalami kerusakan mata atau otak yang serius saat lahir.

12. Minuman Berenergi

Minuman energi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi selama ibu hamil, karena besar kemungkinan minuman tersebut mengandung kafein tingkat tinggi, dan bahan lain yang sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi ibu hamil.

F. Konseling Nutrisi Selama Kehamilan

1. Gizi Seimbang

Ibu hamil diberikan panduan mengenai gizi seimbang yang diperlukan selama kehamilan. Asupan nutrisi yang tepat, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, akan mendukung perkembangan janin dan kesehatan ibu.

2. Suplemen

Penting juga untuk membahas penggunaan suplemen, seperti asam folat dan zat besi, yang mungkin diperlukan selama kehamilan. Suplemen tersebut dapat membantu mencegah cacat tabung saraf dan mengatasi anemia pada ibu hamil.

3. Makanan yang Dihindari

Ibu hamil diberikan informasi tentang makanan yang perlu dihindari selama kehamilan, seperti makanan mentah atau tidak matang, makanan tinggi merkuri, dan makanan yang dapat menyebabkan infeksi.

4. Peningkatan Kebutuhan Kalori

Konseling juga melibatkan penekanan tentang peningkatan kebutuhan kalori selama kehamilan. Ibu hamil perlu mengonsumsi makanan yang cukup

untuk mendukung pertumbuhan janin dan memastikan kesehatan ibu tetap optimal.

G. Kebutuhan Nutrisi dan Suplemen Selama Kehamilan

Kebutuhan gizi ibu selama hamil lebih tinggi dibandingkan kebutuhan gizi ibu sebelum hamil, begitu juga saat usia kehamilan bertambah maka makin tinggi pula jumlah zat gizi yang dibutuhkan. Asupan gizi yang optimal yang disesuaikan dengan usia kehamilan diperlukan untuk mencapai kehamilan yang sehat.

Trimester satu terjadi penambahan jumlah sel dan pembentukan organ, serta pertumbuhan otak dan sel saraf sebagian besar berlangsung selama trimester I. Untuk menunjang proses ini diperlukan asupan zat gizi terutama protein, asam folat, vitamin B12, zink, dan Iodium. Tambahan energi dan protein pada trimester I ini sebesar 100 kalori dan 17 gram protein. Semua zat gizi yang dibutuhkan tersebut harus dicukupi sebagai persiapan untuk pertumbuhan yang lebih cepat pada trimester berikutnya, karena pada trimester I ini pertumbuhan janin belum pesat.

Pada trimester dua dan trimester tiga, pertumbuhan janin cukup pesat mencapai 90% dari seluruh proses tumbuh kembang selama kehamilan. Zat gizi yang dibutuhkan untuk menunjang proses tersebut adalah protein, zat besi, kalsium, magnesium, vitamin B kompleks, serta asam lemak omega 3 dan omega 6. Tambahan energi sekitar 350-500 kalori setiap hari, dan tambahan protein sebesar 17 gram per hari.

Kecukupan gizi pada masa kehamilan dapat dipantau dengan kenaikan berat badan yang sesuai dengan usia kehamilan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada asupan gizi dan rendahnya kenaikan berat badan selama kehamilan adalah :

1. Rasa mual dan muntah
2. Rasa panas pada perut bagian atas
3. Sembelit
4. Konsumsi makanan dan minuman beralkohol, minuman yang mengandung kafein, dan minuman penambah energi
5. Pola makan tidak seimbang
6. Aktivitas fisik yang berlebihan.

Kebutuhan energi dan zat gizi antar kehamilan satu dengan yang lainnya sangat beragam terkait ukuran tubuh dan gaya hidup masing-masing ibu hamil. Berikut beberapa zat gizi yang diperlukan ibu hamil berdasarkan usia kehamilannya. Berikut kebutuhan gizi ibu selama kehamilan :

Trimester I

Tabel 2.1 Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Trimester I

Nama Zat Gizi	Fungsi	Bahan Makanan
Asam Folat	Pembentukan sistem syaraf pusat, termasuk otak	Sayuran berdaun hijau, tempe, serta sereal atau kacang-kacangan yang sudah ditambahkan asam folat.
Asam Lemak	Tak Jenuh Tumbuh kembang sistem syaraf pusat dan otak	Ikan laut
Vitamin B12	Perkembangan janin	sel Hasil ternak dan produk olahannya, serta produk olahan kacang kedelai seperti tempe dan tahu.
Vitamin D	Membantu penyerapan kalsium dan mineral di dalam darah	Ikan salmon dan susu.

Trimester II

Tabel 2.2 Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Trimester II

Nama Zat Gizi	Fungsi	Bahan Makanan
Vitamin A	Proses metabolisme, pembentukan tulang, dan sistem syaraf.	Buah-buahan berwarna kuning hingga merah, daging ayam, telur bebek, dan wortel
Kalsium (Ca)	Pembentukan tulang dan gigi bagi janin dan ibu	Susu, yoghurt, bayam, jeruk, roti gandum, ikan teri.
Zat Besi (Fe)	Membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin	Sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, ikan, kacang-kacangan.

Trimester III

Tabel 3.3 Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Trimester III

Nama Zat Gizi	Fungsi	Bahan Makanan
Vitamin B6	Membantu proses sistem syaraf	Gandum, kacang-kacangan, dan hati.
Vitamin C	Membantu penyerapan zat besi dan sebagai antioksidan	Jeruk, tomat, jambu, pepaya, nenas.
Serat	Memperlancar buang air besar, mempersingkat waktu transit feses	Sayuran dan buah-buahan.

Seng (Zn)	Membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh	Telur, hati sapi, daging sapi, ikan laut, kacang-kacangan.
Iodium	Mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah serta fungsi otot dan syaraf	Garam dapur yang ditambahkan Iodium, ikan laut.

H. Faktor Penghalang Kekurangan Nutrisi Dan Suplemen Selama Kehamilan

Permasalahan gizi di masyarakat Indonesia memiliki hubungan dengan aspek pangan, karena kualitas gizi individu dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas pangan yang mereka konsumsi. Permasalahan yang berhubungan dengan aspek pangan mencakup ketersediaan pangan serta risiko konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan kepercayaan tradisional yang melibatkan larangan konsumsi makanan tertentu. Larangan konsumsi pangan, yang dikenal sebagai tabu makanan, adalah pembatasan yang melarang seseorang mengonsumsi jenis makanan tertentu karena dianggap membawa ancaman atau dampak negatif bagi yang melanggarnya. Larangan ini dapat berakar dari berbagai alasan, seperti kekhawatiran akan keracunan, pertimbangan agama, kepercayaan pribadi, atau bahkan kekhawatiran akan timbulnya penyakit.

Budaya dan lingkungan yang berhubungan dengan larangan konsumsi makanan dengan anemia pada ibu hamil memiliki dampak yang signifikan terhadap asupan gizi. Beberapa jenis makanan yang sering dihindari mencakup makanan yang kaya akan zat besi, seperti makanan hewani seperti cumi-cumi, udang, kepiting, gurita, telur bebek, dan berbagai jenis ikan. Sejalan dengan itu, makanan nabati seperti daun kelor, rebung, tebu, nenas, durian, terong, serta berbagai jenis buah-buahan juga kerap dihindari. Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, tradisi larangan makanan bagi ibu hamil masih umum dijumpai. Walaupun demikian, perlu diakui bahwa tidak semua pembatasan ini berdampak negatif terhadap status gizi dan kesehatan. Larangan yang tidak memiliki dampak kesehatan yang jelas dapat dipertahankan, sambil terus diselidiki pengaruhnya dalam jangka panjang. Selain itu, keterbatasan dalam pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi permasalahan kekurangan gizi. Pendidikan yang minim dapat menyulitkan seseorang dalam mencari pekerjaan yang sesuai, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan yang rendah. Dampaknya adalah kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan oleh seseorang juga menjadi terbatas.

Selain hal diatas berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kekurangan nutrisi dan konsumsi suplemen selama kehamilan:

1. Pola Makan: Pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya konsumsi makanan kaya nutrisi seperti daging merah, sayuran hijau, dan kacang-kacangan dapat menyebabkan kekurangan nutrisi.
2. Pendapatan Keluarga: Rendahnya pendapatan keluarga dapat membatasi akses terhadap makanan bergizi dan suplemen.
3. Pengetahuan tentang Gizi: Kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan gizi selama kehamilan dapat mempengaruhi konsumsi suplemen.
4. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan: Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dapat menghambat ibu hamil dalam mendapatkan saran dan suplemen gizi yang diperlukan.
5. Kebiasaan Merokok: Merokok dapat mengurangi penyerapan zat besi dan vitamin lainnya, yang penting selama kehamilan.
6. Aktivitas Fisik: Aktivitas fisik yang berlebihan tanpa penambahan asupan gizi yang cukup dapat menyebabkan kekurangan nutrisi.
7. Penggunaan Suplemen: Ketidaktepatan dalam mengonsumsi suplemen yang direkomendasikan oleh tenaga medis juga dapat memperburuk kondisi nutrisi.

I. Kesimpulan

Kebutuhan zat gizi saat kehamilan mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan janin maupun untuk ibu hamil dan juga untuk persiapan menyusui. Peningkatan kebutuhan masing-masing zat gizi dapat dihitung berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 2019. Kebutuhan zat gizi baik makro yaitu karbohidrat, protein dan lemak serta zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral harus terpenuhi pada ibu hamil agar terhindar dari defisiensi zat gizi yang tidak diharapkan. Makanan-makanan sumber zat-zat gizi tertentu harus diperhatikan untuk dapat mencapai intake zat gizi yang adekuat bagi ibu hamil.

Kurang gizi selama kehamilan mempengaruhi hasil kelahiran, hasil neonatal dan kemudian hasil kesehatan ibu dan bayinya. Saat kurang gizi pada wanita hamil, janin memiliki peningkatan risiko untuk berat lahir rendah. Penyebab ibu kurang gizi sangat kompleks dan saling terkait yang meliputi tidak memadainya asupan makanan, adanya penyakit, kerawanan pangan, perawatan yang tidak memadai, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, kurangnya pelayanan kesehatan, kemiskinan, kekurangan modal, masalah sosial dan politik. Adapun manfaat gizi pada ibu selama kehamilan antara lain adalah gizi pada ibu hamil dapat mencegah BBLR, mencegah anemia, mencegah bayi lahir cacat dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan janin.

J. Referensi

- Agustuni R, DKK. (2023). Asuhan Kebidanan Kehamilan. Media Sains Indonesia. Jawa Barat.
- Aryanti Novi, Dkk. (2021). Kesehatan Dan Gizi Ibu Hamil. Eureka Media Aksara. Jawa Tengah.
- Direktorat Bina Gizi. (2020). Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Edisi Ketiga.
- Fitriah A, DKK. (2018). Buku Praktis Gizi Ibu Hamil. Media Nusa Creative. Malang.
- Hatijar, Saleh I, Yanti L. (2020). Buku Ajar Asuhan kebidanan Pada Kehamilan. Cahaya Bintang Cemerlang. Gowa.
- Irawan N, Widagda M, Widiastuti A. (2021). Perangkat Training Of Trainer (Tot) Pendampingan Keluarga Dalam Percepatan Penurunan Stunting Bagi Fasilitator Tingkat Provinsi . Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. Jakarta Timur.
- Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta : Menteri Kesehatan RI;2014.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak.
- Marwagati A, DKK. (2021). Kesehatan Ibu Hamil Di Era Pandemi Covid-19. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semarang.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 28 Tahun 2019.
- Noviyanti N, DKK. (2022). Panduan Lengkap Untuk Ibu Hamil. Get press indonesia. Kota Padang Sumatera Barat
- Paramita F. (2019). Gizi Pada Kehamilan. Wineka Media. Malang
- Tyastuti S. Wahyuningsih, H. (2016). Asuhan Kebidanan Kehamilan. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pmberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Yulizawati, DKK. (2017). Draf Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Rumahkayu Pustaka Utama. Padang.

K. Glosarium

Makronutrien = nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar dan berfungsi sebagai sumber energi

Mikronutrien = zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran penting untuk kesehatan.

KEK	= Kurang Energi Kronis
BBLR	= Berat Badan Lahir Rendah
AKG	= Angka Kecukupan Gizi
DHA	= Docosahexaenoic Acid
AA	= Arachidonic Acid
IU	= International Unit
IUGR	= Intra Uterine Growth Restriction

CHAPTER 3

MANAJEMEN KEHAMILAN BERESIKO TINGGI

Siti Komariyah, S.Sit., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Manajemen kehamilan berisiko tinggi merupakan aspek penting dari perawatan prenatal yang berfokus pada pengembangan rencana yang dipersonalisasi untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Rencana ini mempertimbangkan usia ibu, riwayat medis, dan kondisi yang sudah ada sebelumnya untuk mencegah komplikasi dan meminimalkan risiko selama kehamilan, persalinan, dan melahirkan.(Alexander Kofinas, 2024)

Tujuan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Salah satunya dengan memberikan edukasi terhadap kesehatan ibu hamil karena mempersiapkan kesehatan diri bagi hadirnya generasi muda yang akan lahir agar dapat menunjang perkembangan janin yang dikandungnya. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka Kematian Ibu di Indonesia salah satunya kehamilan risiko tinggi yang masih menjadi permasalahan berat dalam kesehatan ibu hamil. (Indrawati, Nuke Devi, 2018)

Menurut data yang disampaikan World Health Organization (WHO) (2021) telah dirilis bahwa Angka Kematian Ibu sebanyak 295.000 kematian di dunia menjelaskan belum berkurang dari harapan perbaikan kesehatan bagi wanita yang hamil. Pada tahun 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia yaitu sebanyak 303.000 jiwa atau sekitar 810 ibu hamil per 100.000 kelahiran hidup meninggal setiap harinya karena risiko kehamilan dan persalinan yang belum mengalami peningkatan layanan kesehatan(WHO, 2021)

Puskesmas Kenanga tahun 2019 risiko tinggi primigravida sebanyak 58 kasus, penyebab terbanyak yaitu kekurangan energi kronik (KEK) 42 kasus. Pada tahun 2020 risiko tinggi primigravida meningkat menjadi 73 kasus, penyebab terbanyak yaitu kekurangan energi kronik (KEK) sebanyak 60 kasus. Berdasarkan tahun 2021 kasus risiko tinggi primigravida mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 66 kasus (37%) dari 179 ibu hamil primigravida, penyebab terbanyak yaitu kekurangan energi kronik (KEK) sebanyak 42 kasus. Pada tahun 2022 risiko tinggi primigravida sebanyak 54 kasus, penyebab terbanyak yaitu anemia sebanyak 18 kasus(Ferdita Yurike Viariska, 2024)

Identifikasi dan penanganan dini kehamilan berisiko tinggi dapat meningkatkan hasil bagi ibu dan bayi. Penanganan kehamilan berisiko tinggi bertujuan untuk memberikan perawatan komprehensif kepada ibu hamil yang mengurangi kemungkinan mengalami hasil buruk selama persalinan. Pengembangan rencana penanganan kehamilan berisiko tinggi dimulai dengan penilaian status kesehatan ibu. Hal ini meliputi peninjauan riwayat medis ibu, identifikasi kondisi atau faktor risiko yang sudah ada sebelumnya yang dapat memengaruhi kehamilannya, dan pelaksanaan tes khusus untuk mengevaluasi kesehatan ibu secara keseluruhan. Setelah penilaian ini selesai, penyedia layanan kesehatan bekerja sama erat dengan ibu hamil untuk mengembangkan rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka. Ini dapat mencakup pemantauan rutin, pengobatan, perubahan gaya hidup, pengujian khusus seperti pemantauan janin atau pemindaian ultrasonografi, dan komunikasi yang erat dengan penyedia layanan kesehatan. Pemantauan teratur merupakan komponen penting dalam manajemen kehamilan berisiko tinggi. Ibu hamil mungkin memerlukan pemeriksaan pranatal yang lebih sering daripada mereka yang dianggap berisiko rendah. Selama pemeriksaan ini, penyedia layanan kesehatan akan memantau tanda-tanda vital seperti tekanan darah dan penambahan berat badan sambil menilai pertumbuhan janin melalui pemindaian ultrasonografi. Ibu hamil juga dapat diberi resep obat untuk mengelola kondisi atau komplikasi yang sudah ada sebelumnya terkait kehamilan mereka. Misalnya, wanita dengan diabetes gestasional mungkin memerlukan suntikan insulin atau obat oral untuk mengendalikan kadar gula darah mereka. Perubahan gaya hidup seperti menjaga pola makan sehat dan olahraga teratur juga dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kehamilan berisiko tinggi. Penyedia layanan kesehatan sering kali bekerja sama dengan ibu hamil untuk mengembangkan rencana makan yang memenuhi kebutuhan gizi mereka sekaligus memastikan pertumbuhan janin yang optimal. (Alexander Kofinas, 2024)

B. Manajemen Kehamilan Resiko Tinggi

1. Pengertian

Kehamilan merupakan proses tumbuh kembang janin dalam rahim dimana kebanyakan ibu akan mengalami banyak perubahan di alat reproduksi dan organ lainnya (Prawirohardjo, 2014).

Kehamilan risiko tinggi yaitu suatu kehamilan dimana keadaannya bisa mengancam keselamatan ibu maupun janinnya atau keduanya (Mochtar, 2018).

Kehamilan risiko tinggi adalah adanya ciri atau keadaan tertentu pada ibu hamil yang dapat menyebabkan bahaya kemungkinan terjadinya komplikasi

persalinan, mengakibatkan kematian/ kesakitan/ kecacatan/ ketidak nyamanan / ketidakpuasaan pada ibu /janin.(dr.Putri Skar W, 2022).

2. Faktor Risiko Umum untuk Kehamilan Berisiko Tinggi

Kehamilan berisiko tinggi memiliki kemungkinan komplikasi yang lebih besar bagi ibu dan bayi. Di bagian ini, kita akan membahas faktor risiko umum untuk kehamilan berisiko tinggi.

a. Usia Ibu Lanjut

Usia ibu yang lanjut merupakan salah satu faktor risiko paling umum untuk kehamilan berisiko tinggi. Wanita yang berusia 35 tahun atau lebih saat hamil memiliki risiko komplikasi kehamilan yang lebih tinggi seperti diabetes gestasional dan hipertensi. Seiring bertambahnya usia wanita, kesuburan mereka menurun, dan kemungkinan kelainan kromosom janin meningkat. Wanita yang lebih tua mungkin lebih mungkin memiliki kondisi medis yang sudah ada sebelumnya yang dapat mempersulit kehamilan.

b. Kondisi Medis yang Sudah Ada Sebelumnya

Wanita dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes atau hipertensi juga berisiko lebih tinggi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Wanita yang menderita diabetes sebelum hamil berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan, termasuk preeklamsia dan kelahiran prematur. Demikian pula, wanita dengan hipertensi dapat mengalami preeklamsia selama kehamilan, yang menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi.

c. Riwayat Kehamilan Berisiko Tinggi Sebelumnya

Wanita dengan kehamilan berisiko tinggi sebelumnya juga lebih mungkin mengalami komplikasi pada kehamilan berikutnya. Misalnya, wanita dengan kelahiran prematur sebelumnya mungkin lebih mungkin mengalami kelahiran prematur lagi pada kehamilan berikutnya.

d. Gangguan Genetik

Keluarga dengan riwayat kelainan genetik atau cacat lahir juga mungkin berisiko lebih tinggi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Konseling genetik dapat membantu keluarga memahami risiko mereka dan membuat keputusan yang tepat tentang perencanaan keluarga.

e. Kehamilan Ganda

Wanita yang mengandung banyak janin (kembar, kembar tiga, dsb.) juga berisiko lebih tinggi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Kehamilan ganda meningkatkan kemungkinan komplikasi seperti persalinan prematur.

f. Pilihan Gaya Hidup

Pilihan gaya hidup tertentu juga dapat menyebabkan kehamilan berisiko tinggi. Misalnya, merokok selama kehamilan meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Demikian pula, penggunaan obat-obatan selama kehamilan dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi.(Alexander Kofinas, 2024)

3. Tanda bahaya kehamilan TM I, II, III

a. Pengertian Tanda Bahaya Ibu Hamil

Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan/periode antenatal, yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu.(BPPSDM, 2015) Menurut, kehamilan merupakan hal yang fisiologis. Namun kehamilan yang normal dapat berubah menjadi patologi. Salah satu asuhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menapis adanya risiko ini yaitu melakukan pendeteksian dini adanya komplikasi/ penyakit yang mungkin terjadi selama hamil.

b. Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan

Pada umumnya 80-90% kehamilan berlangsung normal dan hanya 10-12% kehamilan yang disertai dengan penyulit atau berkembang menjadi kehamilan patologis. Kehamilan patologis tidak terjadi secara mendadak karena kehamilan dan efeknya terhadap organ tubuh berlangsung secara bertahap dan berangsur-angsur. Deteksi dini gejala dan tanda bahaya selama kehamilan merupakan upaya terbaik untuk mencegah terjadinya gangguan yang serius terhadap kehamilan ataupun keselamatan ibu hamil. Faktor predisposisi dan adanya penyulit penyerta sebaiknya diketahui sejak awal sehingga dapat dilakukan berbagai upaya maksimal untuk mencegah gangguan yang berat baik terhadap kehamilan dan keselamatan ibu maupun bayi yang dikandungnya.(Retnaningtyas, 2016)

c. Macam-macam Tanda Bahaya Kehamilan

1) Tanda Bahaya Kehamilan Trimester I (0 – 12 minggu)

a) Perdarahan Pada Kehamilan Muda

Salah satu komplikasi terbanyak pada kehamilan ialah terjadinya perdarahan. Perdarahan dapat terjadi pada setiap kehamilan. Pada kehamilan muda sering dikaitkan dengan kejadian abortus, misscarriage, early pregnancy loss. Perdarahan pada kehamilan muda dikenal beberapa istilah sesuai dengan pertimbangan masing-masing, setiap terjadinya perdarahan pada kehamilan maka harus selalu berfikir tentang akibat dari perdarahan ini yang menyebabkan kegagalan kelangsungan kehamilan.

(1) Abortus

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sebagai batasan ialah kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Penyebab kematian ibu dikarenakan abortus (5%).

(a) Abortus Imminens (*threatened*)

Abortus imminens dicurigai bila terdapat pengeluaran vagina yang mengandung darah, atau perdarahan pervaginam pada trimester pertama kehamilan. Abortus imminens dapat atau tanpa disertai rasa mules ringan, dengan pada waktu menstruasi atau nyeri pinggang bawah. Perdarahan pada abortus imminens seringkali hanya sedikit, namun hal tersebut berlangsung beberapa hari atau minggu. Pemeriksaan vagina pada kelainan ini memperlihatkan tidak adanya pembukaan serviks. Sementara pemeriksaan dengan real time ultrasound pada panggul menunjukkan ukuran kantong amnion normal, jantung janin berdenyut, dan kantong amnion kosong, serviks tertutup, dan masih terdapat janin utuh.

(b) Abortus Insipien (*inevitable*)

Merupakan suatu abortus yang tidak dapat dipertahankan lagi ditandai dengan pecahnya selaput janin dan adanya pembukaan serviks. Pada keadaan ini didapatkan juga nyeri perut bagian bawah atau nyeri kolek uterus yang hebat. Pada pemeriksaan vagina memperlihatkan dilatasi ostium serviks dengan bagian kantung konsepsi menonjol. Hasil Pemeriksaan USG mungkin didapatkan jantung janin masih berdenyut, kantung gestasi kosong (lima hingga enam minggu) uterus kosong (tiga-lima minggu) atau perdarahan subkorionik banyak di bagian bawah.

(c) Abortus Incompletus (*incomplete*)

Adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa yang tertinggal dalam uterus. Pada pemeriksaan vagina, kanalis servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalam cavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol dari ostium uteri eksternum. Pada USG didapatkan endometrium yang tipis dan ireguler

(d) Abortus Completus (*complete*)

Pada abortus completus semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan. Pada penderita ditemukan perdarahan sedikit, ostium uteri telah

menutup, dan uterus sudah banyak mengecil. Selain ini, tidak ada lagi gejala kehamilan dan uji kehamilan menjadi negatif. Pada pemeriksaan USG didapatkan uterus yang kosong.

(e) *Missed Abortion*

Adalah kematian janin berusia sebelum 20 minggu, tetapi janin mati itu tidak dikeluarkan selama delapan minggu atau lebih.

(f) *Abortus Habitualis (habitual abortion)*

Adalah abortus spontan yang terjadi berturut-turut tiga kali atau lebih. Pada umumnya penderita tidak sukar menjadi hamil, namun kehamilannya berakhir sebelum 28 minggu.(Rinata, 2023)

(2) Kehamilan Ektopik

Adalah kehamilan yang pertumbuhan sel telur telah dibuahi tidak menempel pada dinding endometrium kavum uteri. Lebih dari 95% kehamilan ektopik berada di saluran telur (tuba Fallopii). Kejadian kehamilan ektopik tidak terjadi diantara senter pelayanan kesehatan. Hal ini bergantung pada kejadian salpingitis seseorang. Di Indonesia kejadian sekitar lima-enam perseribu kehamilan.

Patofisiologi terjadinya kehamilan ektopik tersering karena sel telur yang telah dibuahi dalam perjalanannya menuju endometrium tersendat sehingga embrio sudah berkembang sebelum mencapai kavum uteri dan akibatnya tumbuh di luar rongga rahim. Bila kemudian tempat nidasi tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan besarnya buah kehamilan, hal ini dapat menyebabkan terjadi rupture dan menjadi kehamilan ektopik terganggu.

Tanda dan gejala pada kehamilan muda, dapat atau tidak ada perdarahan pervaginam, ada nyeri perut kanan/kiri bawah. Berat atau ringannya nyeri tergantung pada banyaknya darah yang terkumpul dalam peritoneum.

Dari pemeriksaan fisik didapatkan rahim yang juga membesar, adanya tumor didaerah adneksa. Adanya tandatanda syok hipovolemik yaitu hipotensi, pucat dan ekstremitas dingin, adanya tanda-tanda abdomen akut yaitu perut tegang bagian bawah, nyeri tekan dan nyeri lepas dinding abdomen. Dari pemeriksaan dalam serviks teraba lunak, nyeri tekan, nyeri pada uterus kanan dan kiri(Rinata, 2023)

(3) Mola Hidatidosa

Adalah suatu kehamilan yang berkembang tidak wajar dimana tidak ditemukan janin dan hampir seluruh vili korialis mengalami

perubahan berupa degenerasi hidropik. Secara makroskopik, mola hidatidosa mudah dikenal yaitu berupa gelembung-gelembung putih, tembus pandang, berisi cairan jernih, dengan ukuran bervariasi dari beberapa millimeter sampai satu atau dua cm. Permulaannya gejala mola hidatidosa tidak seberapa berbeda dengan kehamilan biasa yaitu mual, muntah, pusing, dan lain-lain, hanya saja derajat keluhannya sering lebih hebat. Selanjutnya perkembangan lebih pesat, sehingga pada umumnya besar uterus lebih besar dari umur kehamilan.

Ada pula kasus-kasus yang uterusnya lebih kecil atau sama besar walaupun jaringannya belum dikeluarkan. Dalam hal ini perkembangan jaringan trofoblas tidak begitu aktif sehingga perlu dipikirkan kemungkinan adanya *dying mole*. Perdarahan merupakan gejala utama mola. Biasanya keluhan perdarahan inilah yang menyebabkan mereka datang ke rumah sakit

Gejala perdarahan ini biasanya terjadi antara bulan pertama sampai ketujuh dengan rata-rata 12-14 minggu. Sifat perdarahan bisa intermiten, sedikit-sedikit atau sekaligus banyak sehingga menyebabkan syok atau kematian. Karena perdarahan ini umumnya pasien mola hidatidosa masuk dalam keadaan anemia. (Rinata, 2023)

b) Muntah Terus dan Tidak Bisa Makan pada Kehamilan

Mual dan muntah adalah gejala yang sering ditemukan pada kehamilan trimester I. Mual biasa terjadi pada pagi hari, gejala ini biasa terjadi enam minggu setelah HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) dan berlangsung selama 10 minggu. Perasaan mual ini karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan HCG (Human Chorionic Gonadotropin) dalam serum. Mual dan muntah yang sampai mengganggu aktifitas sehari-hari dan keadaan umum menjadi lebih buruk, dinamakan *Hiperemesis Gravidarum* (Miskawati, 2023)

c) Selaput Kelopak Mata Pucat

Merupakan salah satu tanda anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin di bawah 11 gr% pada trimester I. Anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut bahkan tak jarang keduanya saling berinteraksi. Anemia pada trimester I *hamdulillah* bisa disebabkan karena mual muntah pada ibu hamil dan perdarahan pada ibu hamil trimester I (Miskawati, 2023)

d) Demam Tinggi

Ibu menderita demam dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penyebab kematian ibu karena infeksi (11%). Penanganan demam antara lain dengan istirahat baring, minum banyak dan mengompres untuk menurunkan suhu. Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh wanita hamil yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi berat dapat terjadi demam dan gangguan fungsi organ vital. Infeksi dapat terjadi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas(Rinata, 2023)

2) Tanda Bahaya Kehamilan Trimester II (13 – 28 minggu)

a) Demam Tinggi

Ibu menderita demam dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penyebab kematian ibu karena infeksi (11%). Penanganan demam antara lain dengan istirahat baring, minum banyak dan mengompres untuk menurunkan suhu. Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh wanita hamil yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi berat dapat terjadi demam dan gangguan fungsi organ vital. Infeksi dapat terjadi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas.

b) Bayi Kurang Bergerak Seperti Biasa

Gerakan janin tidak ada atau kurang (minimal tiga kali dalam satu jam). Ibu mulai merasakan gerakan bayi selama bulan ke-lima atau ke-enam. Jika bayi tidak bergerak seperti biasa dinamakan IUFD (Intra Uterine Fetal Death). IUFD adalah tidak adanya tanda-tanda kehidupan janin didalam kandungan. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal. Jika bayi tidur gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit tiga kali dalam satu jam jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik.

c) Selaput Kelopak Mata Pucat

Merupakan salah satu tanda anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin di bawah $<10,5 \text{ gr\%}$ pada trimester II. Anemia pada trimester II disebabkan oleh hemodilusi atau pengenceran darah. Anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi(Rinata, 2023)

3) Tanda Bahaya Kehamilan Trimester III (29 – 42 minggu)

a) Perdarahan Pervaginam

Penyebab kematian ibu dikarenakan perdarahan (28%). Pada akhir kehamilan perdarahan yang tidak normal adalah merah, banyak dan kadang-kadang tidak disertai dengan rasa nyeri. Perdarahan semacam ini berarti plasenta previa. Plasenta previa adalah keadaan dimana plasenta berimplantasi pada tempat yang abnormal yaitu segmen bawah Rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri interna. Penyebab lain adalah solusio plasenta dimana keadaan plasenta yang letaknya normal, terlepas dari perlekatannya sebelum janin lahir, biasanya dihitung sejak kehamilan 28 minggu.

b) Sakit Kepala yang Hebat

Sakit kepala selama kehamilan adalah umum, seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan masalah yang serius adalah sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang dengan sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin mengalami penglihatan yang kabur. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari pre-eklampsia.

c) Penglihatan Kabur

Penglihatan menjadi kabur atau berbayang dapat disebabkan oleh sakit kepala yang hebat, sehingga terjadi oedema pada otak dan meningkatkan resistensi otak yang mempengaruhi sistem saraf pusat, yang dapat menimbulkan kelainan serebral (nyeri kepala, kejang) dan gangguan penglihatan. Perubahan penglihatan atau pandangan kabur, dapat menjadi tanda pre-eklampsia. Masalah visual yang mengidentifikasi keadaan yang mengancam jiwa adalah perubahan visual yang mendadak, misalnya penglihatan kabur atau berbayang, melihat bintik-bintik (spot), berkunang-kunang. Selain itu adanya skotoma, diplopia dan ambliopia merupakan tanda-tanda yang menunjukkan adanya preeklampsia berat yang mengarah pada eklampsia. Hal ini disebabkan adanya perubahan peredaran darah dalam pusat penglihatan di korteks cerebri atau didalam retina (oedema retina dan spasme pembuluh darah).

d) Bengkak di Muka atau Tangan

Hampir separuh dari ibu-ibu akan mengalami bengkak yang normal pada kaki yang biasanya muncul pada sore hari dan biasanya hilang setelah beristirahat atau meletakkannya lebih tinggi. Bengkak dapat

menunjukkan adanya masalah serius jika muncul pada permukaan muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat, dan diikuti dengan keluhan fisik yang lain. Hal ini bisa merupakan pertanda pre-eklampsia.

e) Janin Kurang Bergerak Seperti Biasa

Gerakan janin tidak ada atau kurang (minimal tiga kali dalam satu jam), ibu mulai merasakan gerakan bayi selama bulan ke-lima atau ke-enam. Jika bayi tidak bergerak seperti biasa dinamakan IUFD (Intra Uterine Fetal Death). IUFD adalah tidak adanya tanda-tanda kehidupan janin di dalam kandungan. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal. Jika bayi tidur gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit tiga kali dalam satu jam jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik.

f) Pengeluaran Cairan Pervaginam (Ketuban Pecah Dini)

Yang dimaksud cairan di sini adalah air ketuban. Ketuban yang pecah pada kehamilan aterm dan disertai dengan munculnya tanda-tanda persalinan adalah normal. Pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda-tanda persalinan dan ditunggu satu jam belum dimulainya tanda-tanda persalinan ini disebut ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan ruangan dalam rahim sehingga memudahkan terjadinya infeksi. Makin lama periode laten (waktu sejak ketuban pecah sampai terjadi kontraksi rahim), makin besar kemungkinan kejadian kesakitan dan kematian ibu atau janin dalam rahim.

g) Kejang

Penyebab kematian ibu karena eklampsia (24%). Pada umumnya kejang didahului oleh makin memburuknya keadaan dan terjadinya gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati sehingga muntah. Bila semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun kemudian kejang

h) Selaput Kelopak mata Pucat

Merupakan salah satu tanda anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin di bawah 11 gr% pada trimester III. Anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut bahkan tak jarang keduanya bisa berinteraksi. Anemia pada Trimester III dapat menyebabkan perdarahan pada waktu persalinan dan nifas, BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) yaitu kurang dari 2500 gram).

i) Demam Tinggi

Ibu menderita demam dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penyebab kematian ibu karena infeksi (11%). Penanganan demam antara lain dengan istirahat baring, minum banyak dan mengompres untuk menurunkan suhu. Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan disebabkan masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh wanita hamil yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi berat dapat terjadi demam dan gangguan fungsi organ vital, infeksi dapat terjadi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas (Rinata, 2023)

d. Tujuan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan

Tujuan pentingnya mengetahui tanda bahaya kehamilan untuk mengenali tanda-tanda yang mengancam bagi ibu hamil dan janinnya sejak dini. Dapat mengambil tindakan yang tepat yaitu menghubungi tenaga kesehatan terdekat bila menemui tanda bahaya kehamilan untuk mendapat perawatan segera (Miskawati, 2023).

4. Deteksi dini komplikasi ibu dan janin menggunakan KSPR

Gambar 3.1 Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)
(Kemenkes RI, 2020)

Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) adalah alat skrining berbentuk kartu yang berbasis keluarga untuk menemukan nilai risiko ibu hamil, agar dilakukan upaya

berkelanjutan menghindari dan mencegah kemungkinan komplikasi obstetrik saat persalinan. KSPR mengelompokkan ibu hamil kedalam kehamilan resiko rendah (KRR), kehamilan risiko tinggi (KRT), dan kehamilan resiko sangat tinggi (KSRT). (Suryani, 2023)

Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) adalah kartu skor yang digunakan sebagai alat skrining antenatal berbasis keluarga untuk menemukan faktor risiko ibu hamil, yang selanjutnya mempermudah pengenalan kondisi untuk mencegah terjadi komplikasi obstetrik pada saat persalinan. KSPR disusun dengan format kombinasi antara checklist dari kondisi ibu hamil / faktor risiko dengan sistem skor. Kartu skor ini dikembangkan sebagai suatu teknologi sederhana, mudah, dapat diterima dan cepat digunakan oleh tenaga non profesional.

Tujuannya agar berkembang perilaku untuk penentuan tempat dan penolong sesuai dengan kondisi ibu hamil dan keluarga serta masyarakat memberikan dukungan dan bantuan kesiapan mental, biaya, dan transportasi untuk rujukan terencana . (Suryani, 2023)

Fungsi dari KSPR adalah:

- a. Melakukan skrining deteksi dini ibu hamil risiko tinggi.
- b. Memantau kondisi ibu dan janin selama kehamilan.
- c. Memberi pedoman penyuluhan untuk persalinan aman berencana (Komunikasi Informasi Edukasi/KIE).
- d. Mencatat dan melaporkan keadaan kehamilan, persalinan, nifas.
- e. Validasi data mengenai perawatan ibu selama kehamilan, persalinan, nifas dengan kondisi ibu dan bayinya.
- f. Audit Maternal Perinatal (AMP)(Senditya Indah M;Nicky Danur, 2022)

Sistem SKOR

Cara Pemberian SKOR:

- a. Skor 2: Kehamilan Risiko Rendah (KRR) Untuk umur dan paritas pada semua ibu hamil sebagai skor awal
- b. Skor 4: Kehamilan Risiko Tinggi (KRT) Untuk tiap faktor risiko
- c. Skor 8: Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST) Untuk bekas operasi sesar, letak sungsang, letak lintang, perdarahan antepartum dan pre-eklamsia berat / eklamsia.

Sistem skor memudahkan pengedukasian mengenai berat ringannya faktor risiko kepada ibu hamil, suami, maupun keluarga. Skor dengan nilai 2, 4, dan 8 merupakan bobot risiko dari tiap faktor risiko. Sedangkan jumlah skor setiap kontak merupakan perkiraan besar risiko persalinan dengan perencanaan pencegahan. Kelompok risiko dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Kehamilan Risiko Rendah (KRR) : Skor 2 (hijau)

- b. Kehamilan Risiko Tinggi (KRT) : Skor 6-10 (kuning)
- c. Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST) : Skor ≥ 12 (merah)(Senditya Indah M;Nicky Danur, 2022)

Terdapat 20 faktor risiko yang dibagi menjadi 3 kelompok faktor risiko pada penilaian KSPR.

Kelompok Faktor Risiko I (Ada Potensi Gawat Obstetrik)

- a. Primi muda : terlalu muda, hamil pertama usia 16 tahun atau kurang
- b. Primi Tua : terlalu tua, hamil usia ≥ 35 tahun
- c. Primi Tua Sekunder : jarak anak terkecil > 10 tahun
- d. Anak terkecil < 2 tahun : terlalu cepat memiliki anak lagi
- e. Grande multi : terlalu banyak memiliki anak, anak ≥ 4
- f. Umur ibu ≥ 35 tahun : terlalu tua
- g. Tinggi badan ≤ 145 cm : terlalu pendek, belum pernah melahirkan normal dengan bayi cukup bulan dan hidup, curiga panggul sempit
- h. Pernah gagal kehamilan
- i. Persalinan yang lalu dengan tindakan
- j. Bekas operasi sesar

Kelompok Faktor Risiko II

- a. Penyakit ibu : anemia, malaria, TBC paru, payah jantung, dan penyakit lain.
- b. Preeklampsia ringan
- c. Hamil kembar
- d. Hidramnion : air ketuban terlalu banyak
- e. IUFD (Intra Uterine Fetal Death) : bayi mati dalam kandungan
- f. Hamil serotinus : hamil lebih bulan (≥ 42 minggu belum melahirkan)
- g. Letak sungsang
- h. Letak Lintang

Kelompok Faktor Risiko III

- a. Perdarahan Antepartum : dapat berupa solusio plasenta, plasenta previa, atau vasa previa
- b. Preeklampsia berat/eclampsia(Senditya Indah M;Nicky Danur, 2022)

Rencana Persalinan pada Kehamilan Sekarang

Berdasarkan SKOR POEDJI ROCHJATI

- a. Ibu hamil dengan SKOR 6 atau lebih, dianjurkan bersalin dengantenaga kesehatan
- b. Bila SKOR 12 atau lebih dianjurkan bersalin di RS / SpOG(Senditya Indah M;Nicky Danur, 2022)



Gambar 2.2 Interpretasi KSPR

Sumber : (BPPSDM, 2015)

5. Diagnosis dan Tes untuk Kehamilan Berisiko Tinggi

Amniosentesis adalah tes diagnostik yang melibatkan pengambilan sampel kecil cairan ketuban untuk memeriksa kelainan genetik pada janin. Prosedur ini biasanya dilakukan antara minggu ke-15 dan ke-20 kehamilan dan dapat memberikan informasi berharga tentang kesehatan bayi. Selama tes, jarum tipis dimasukkan melalui perut ibu dan ke dalam kantung ketuban untuk mengambil sejumlah kecil cairan. Sampel yang terkumpul kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis.

Meskipun amniosentesis secara umum dianggap aman, prosedur ini memiliki beberapa risiko. Risiko ini meliputi infeksi, pendarahan, dan keguguran. Namun, komplikasi ini jarang terjadi, dan sebagian besar wanita yang menjalani amniosentesis tidak mengalami efek samping. Tes lain yang dapat dilakukan selama kehamilan berisiko tinggi meliputi pengambilan sampel vilus korionik (CVS), pengujian prenatal noninvasif (NIPT), dan pemindaian ultrasonografi. CVS melibatkan pengambilan sampel sel dari plasenta untuk memeriksa kelainan genetik. NIPT menggunakan sampel darah dari ibu untuk menyaring kelainan kromosom tertentu pada janin. Pemindaian ultrasonografi dapat membantu mengidentifikasi potensi komplikasi seperti preeklamsia, diabetes gestasional, dan hambatan pertumbuhan janin. (Alexander Kofinas, 2024)

Dalam beberapa kasus, kehamilan berisiko tinggi mungkin memerlukan pemantauan dan pengujian yang lebih sering untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Misalnya, jika seorang wanita menderita diabetes gestasional atau hipertensi, penyedia layanan kesehatannya mungkin menyarankan tes darah atau USG secara teratur untuk memantau kondisinya. Jika ada kekhawatiran tentang pertumbuhan atau perkembangan janin, USG yang lebih sering mungkin diperlukan. Wanita dengan kehamilan berisiko tinggi harus

bekerja sama erat dengan penyedia layanan kesehatan mereka untuk menentukan tes diagnostik dan rencana penanganan yang tepat. Dengan tetap mendapatkan informasi tentang kondisi mereka dan mengikuti anjuran dokter, wanita dapat meningkatkan peluang mereka untuk memiliki kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat.(Alexander Kofinas, 2024)

6. Manajemen Kehamilan Berisiko Tinggi

a. Pengobatan

Kehamilan berisiko tinggi memerlukan perawatan khusus untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Pilihan pengobatan untuk kehamilan berisiko tinggi dapat mencakup pengobatan, istirahat di tempat tidur, dan operasi. Obat-obatan dapat diresepkan untuk mengelola hipertensi, diabetes gestasional, dan persalinan prematur.

Hipertensi merupakan komplikasi umum selama kehamilan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi ibu dan bayi. Obat-obatan seperti labetalol atau nifedipine sering digunakan untuk mengendalikan tekanan darah pada wanita hamil yang mengalami hipertensi. Obat-obatan ini bekerja dengan merelaksasi pembuluh darah, mengurangi beban kerja jantung, dan menurunkan tekanan darah.

Diabetes gestasional merupakan kondisi lain yang dapat terjadi selama kehamilan. Jenis diabetes ini berkembang selama kehamilan ketika hormon yang diproduksi oleh plasenta menyulitkan insulin untuk mengatur kadar gula darah. Wanita dengan diabetes gestasional mungkin memerlukan suntikan insulin atau obat oral seperti metformin untuk membantu mengelola kondisi mereka.

Persalinan prematur merupakan masalah bagi banyak kehamilan berisiko tinggi. Wanita yang mengalami persalinan prematur dapat diberikan obat-obatan seperti suntikan progesteron atau magnesium sulfat untuk membantu mencegah kelahiran prematur.

b. Istirahat di Tempat Tidur

Istirahat di tempat tidur dapat direkomendasikan bagi wanita yang berisiko melahirkan prematur atau dengan kondisi seperti plasenta previa atau inkompetensi serviks. Istirahat di tempat tidur memberi waktu bagi tubuh untuk pulih dan membantu mengurangi stres pada rahim.

Plasenta previa adalah kondisi di mana plasenta menutupi sebagian atau seluruh serviks. Kondisi ini dapat menyebabkan pendarahan selama kehamilan dan komplikasi persalinan. Wanita dengan kondisi ini mungkin harus istirahat di tempat tidur hingga persalinan.

Inkompetensi serviks terjadi ketika serviks mulai terbuka terlalu dini pada masa kehamilan, yang dapat menyebabkan kelahiran prematur atau keguguran. Istirahat di tempat tidur dapat direkomendasikan bersama dengan perawatan lain, seperti cerclage (prosedur bedah yang menjahit serviks) untuk membantu mencegah kelahiran prematur.

c. Operasi

Pembedahan terkadang diperlukan untuk mengatasi kondisi seperti kehamilan ektopik, plasenta akreta, atau kelainan janin. Kehamilan ektopik terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel di luar rahim, biasanya di tuba falopi. Pembedahan sering kali diperlukan untuk mengangkat kehamilan ektopik dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

Plasenta akreta adalah kondisi di mana plasenta menempel terlalu dalam pada dinding rahim. Kondisi ini dapat menyebabkan pendarahan hebat saat melahirkan dan mungkin memerlukan histerektomi (pengangkatan rahim) untuk menghentikan pendarahan. Kelainan janin merupakan masalah lain yang perlu diperhatikan pada kehamilan berisiko tinggi. Beberapa kelainan janin mungkin memerlukan pembedahan, sementara kelainan lainnya dapat diatasi dengan pengobatan atau perawatan lain. (Alexander Kofinas, 2024)

7. Pemantauan dan Penanganan Kehamilan Berisiko Tinggi

Pemantauan Rutin Sangat Penting dalam Menangani Kehamilan Berisiko Tinggi

Kehamilan bisa menjadi masa yang penuh kegembiraan dan penantian, tetapi juga bisa menjadi masa yang penuh kekhawatiran dan ketidakpastian, terutama jika kehamilan tersebut dianggap berisiko tinggi. Kehamilan berisiko tinggi memiliki risiko komplikasi yang lebih besar bagi ibu dan bayi. Komplikasi ini dapat berkisar dari ringan hingga berat dan mungkin memerlukan perawatan atau pengobatan khusus. Salah satu faktor penting dalam penanganan kehamilan berisiko tinggi adalah pemantauan rutin. Spesialis obstetri risiko yang terlatih untuk mengidentifikasi dan menangani potensi komplikasi memantau secara ketat ibu hamil dengan kehamilan berisiko tinggi. Pemantauan ini dapat mencakup kunjungan pranatal yang lebih sering, USG, tes darah, dan prosedur diagnostik lainnya. Selama kunjungan ini, dokter spesialis akan menilai kesehatan ibu hamil dan mencari tanda-tanda masalah potensial seperti persalinan prematur, preeklamsia, diabetes gestasional, atau hambatan pertumbuhan janin. Jika ada masalah yang teridentifikasi, dokter spesialis akan bekerja sama dengan ibu hamil untuk menyusun rencana penanganan. Spesialis Obstetri Risiko Tinggi Dilatih untuk Mengidentifikasi dan Mengelola Potensi Komplikasi Penanganan kehamilan berisiko tinggi memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus.

Spesialis obstetri risiko memiliki pelatihan ekstensif dalam mengidentifikasi dan menangani potensi komplikasi yang mungkin timbul selama kehamilan. Spesialis ini bekerja erat dengan profesional perawatan kesehatan lainnya, seperti spesialis kedokteran ibu dan janin, ahli neonatologi, konselor genetik, ahli gizi, pekerja sosial, dan anggota tim perawatan kesehatan lainnya, untuk memberikan perawatan komprehensif bagi ibu hamil dengan kehamilan berisiko tinggi. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan ibu dipantau secara ketat selama kehamilan sehingga masalah potensial dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani dengan tepat.

Kesehatan Ibu Dipantau Secara Ketat Selama Kehamilan Berisiko Tinggi

Kesehatan ibu hamil merupakan hal terpenting selama kehamilan berisiko tinggi. Kesehatan ibu dipantau secara ketat selama kehamilan untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah dengan segera. Pemantauan ini dapat mencakup pemeriksaan rutin untuk menilai tekanan darah, penambahan berat badan, dan tanda-tanda vital lainnya. Dokter spesialis juga dapat merekomendasikan perubahan gaya hidup seperti diet sehat, olahraga, teknik pengurangan stres, atau istirahat di tempat tidur untuk membantu mengelola potensi komplikasi. Obat-obatan atau prosedur medis terkadang diperlukan untuk mengurangi risiko dan memastikan kehamilan yang sehat. Misalnya, jika seorang wanita hamil menderita diabetes gestasional, mereka mungkin memerlukan insulin atau obat-obatan lain untuk mengendalikan kadar gula darah mereka. Jika ada risiko persalinan prematur, dokter spesialis dapat merekomendasikan obat-obatan yang dapat membantu menunda persalinan hingga bayi lebih matang. (Alexander Kofinas, 2024)

8. Tips Merawat Diri Sendiri Selama Kehamilan Berisiko Tinggi

a. Tetap Terinformasi Tentang Informasi Kesehatan Anda

Salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan selama kehamilan berisiko tinggi adalah tetap mendapatkan informasi tentang kesehatan Anda. Hadiri semua jadwal konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan Anda, dan jangan takut untuk mengajukan pertanyaan tentang masalah Anda. Penyedia layanan kesehatan akan memantau kesehatan Anda secara ketat dan memberikan panduan tentang cara menangani masalah apa pun. Penting juga untuk memantau informasi kesehatan Anda, seperti hasil tekanan darah atau kadar glukosa, jika Anda menderita diabetes gestasional. Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi perubahan atau tren apa pun dan membagikannya dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

b. Sayuran, wortel, bawang putihPrioritaskan Kesehatan Anda

Selama kehamilan berisiko tinggi, sangat penting untuk memprioritaskan kesehatan Anda dengan mengonsumsi makanan yang seimbang, tetap terhidrasi, dan cukup istirahat. Mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dapat membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin sekaligus menjaga kesehatan Anda. Tetap terhidrasi dapat membantu mencegah dehidrasi, yang dapat menyebabkan komplikasi seperti persalinan prematur.

- c. Istirahat yang cukup juga penting untuk kesehatan Anda dan bayi Anda. Usahakan untuk tidur setidaknya 7-8 jam setiap malam, dan sempatkan istirahat di siang hari bila diperlukan.

- d. Jadilah Peserta Aktif dalam Perawatan Anda

Sebagai pasien selama kehamilan berisiko tinggi, penting untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan Anda. Ajukan pertanyaan tentang prosedur atau perawatan apa pun yang direkomendasikan oleh penyedia layanan kesehatan Anda sehingga Anda benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Jika ada yang terasa tidak beres atau jika Anda memiliki kekhawatiran tentang rencana perawatan Anda, bicarakanlah! Anda adalah anggota tim penting yang bertanggung jawab untuk memastikan hasil terbaik bagi Anda dan bayi Anda.

- e. Cari Dukungan Emosional

Mengelola stres dan kecemasan selama kehamilan berisiko tinggi bisa jadi sulit, tetapi mencari dukungan emosional dari orang-orang terkasih atau bergabung dengan kelompok pendukung dapat mempermudahnya. Berhubungan dengan orang lain yang mengalami pengalaman serupa dapat memberikan kenyamanan dan kepastian yang sangat dibutuhkan. Pertimbangkan untuk melakukan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dalam atau kelas yoga prenatal untuk membantu mengelola tingkat stres.

- f. Ikuti Rencana Perawatan yang Diresepkan

Jika penyedia layanan kesehatan Anda memberikan resep rencana perawatan atau pengobatan, ikuti petunjuknya. Melewatkan dosis atau tidak mengikuti petunjuk dapat menyebabkan komplikasi dan berpotensi membahayakan Anda atau bayi Anda.

- g. Ambil Tindakan Pencegahan yang Diperlukan

Untuk menghindari infeksi dan penyakit selama kehamilan berisiko tinggi, lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan seperti mencuci tangan sesering mungkin dan menghindari kontak dengan orang yang sakit. Bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan Anda tentang tindakan pencegahan tambahan jika Anda bekerja di lingkungan berisiko tinggi, seperti rumah sakit atau pusat penitipan anak. (Alexander Kofinas, 2024)

9. Tips Merawat Bayi Anda Selama Kehamilan Berisiko Tinggi

Perawatan prenatal sangat penting bagi ibu dan bayi selama kehamilan berisiko tinggi. Pemeriksaan prenatal rutin memastikan ibu dan bayi sehat selama kehamilan. Pada kehamilan berisiko tinggi, pemeriksaan ini menjadi lebih penting karena memungkinkan penyedia layanan kesehatan memantau kesehatan ibu dan bayi secara ketat. Selama pemeriksaan ini, penyedia layanan kesehatan dapat melakukan tes tambahan atau USG untuk memeriksa pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Penting juga bagi ibu untuk mengikuti anjuran penyedia layanan kesehatan dengan saksama. Misalnya, jika istirahat di tempat tidur dianjurkan, penting untuk menganggapnya serius karena dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan kehamilan berisiko tinggi. Ibu harus berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan tentang obat-obatan atau suplemen, karena beberapa mungkin tidak aman selama kehamilan.

Perawatan untuk bayi baru lahir yang lahir dari ibu berisiko tinggi mungkin memerlukan perhatian dan pemantauan ekstra. Bayi baru lahir yang lahir dari ibu berisiko tinggi mungkin memerlukan perawatan tambahan di rumah sakit atau di rumah setelah lahir. Penyedia layanan kesehatan akan memantau bayi-bayi ini secara ketat untuk mengetahui tanda-tanda komplikasi atau masalah kesehatan yang terkait dengan kehamilan berisiko tinggi ibu mereka. Pemantauan ini dapat mencakup pengujian atau prosedur tambahan seperti tes darah, studi pencitraan, atau perawatan khusus di unit perawatan intensif neonatal (NICU).

Orang tua juga dapat merawat bayi mereka secara aktif dengan mengikuti petunjuk dari penyedia layanan kesehatan secara saksama. Ini dapat mencakup jadwal pemberian makanan, pemberian obat, atau petunjuk khusus untuk peralatan medis yang dibutuhkan di rumah. Penting untuk mencatat segala pertanyaan atau kekhawatiran tentang perawatan bayi Anda selama kehamilan berisiko tinggi dan mendiskusikannya dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Orang tua harus merasa nyaman mengajukan pertanyaan tentang cara terbaik merawat bayi baru lahir selama kehamilan berisiko tinggi. Sangat penting untuk bertanya dan mendengarkan dengan saksama saran dari penyedia layanan kesehatan yang memiliki pengalaman merawat bayi yang lahir dalam kondisi serupa. Orang tua sebaiknya mempertimbangkan untuk membuat daftar sumber daya dan sistem pendukung yang bermanfaat yang dapat membantu selama masa-masa sulit. Ini dapat mencakup kelompok pendukung, layanan konseling, atau organisasi yang mengkhususkan diri dalam merawat bayi yang lahir dari ibu yang berisiko tinggi. (Alexander Kofinas, 2024)

10. Kapan Harus Menghubungi Dokter Selama Kehamilan Berisiko Tinggi

a. Perdarahan Vagina atau Bercak

Salah satu alasan paling umum untuk menghubungi dokter selama kehamilan berisiko tinggi adalah pendarahan vagina atau bercak. Ini dapat menandakan banyak hal, termasuk plasenta previa, persalinan prematur, atau keguguran. Jika Anda mengalami pendarahan vagina dalam jumlah berapa pun selama kehamilan, penting untuk segera menghubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

b. Sakit Perut Parah atau Kram

Alasan lain untuk menghubungi dokter selama kehamilan berisiko tinggi adalah jika Anda mengalami nyeri perut atau kram yang parah. Ini dapat menandakan persalinan prematur, preeklamsia, solusio plasenta, atau kondisi serius lainnya.

c. Gerakan Janin Berkurang

Jika Anda menyadari adanya penurunan gerakan janin selama kehamilan berisiko tinggi, penting untuk segera menghubungi penyedia layanan kesehatan Anda. Hal ini dapat menandakan bahwa ada yang salah dengan kesehatan bayi Anda dan memerlukan perhatian segera.

d. Tanda-tanda Persalinan Prematur

Persalinan prematur terjadi saat kontraksi dimulai sebelum usia kehamilan 37 minggu dan dapat menyebabkan kelahiran prematur. Tanda-tanda persalinan prematur meliputi kontraksi teratur setiap 10 menit atau kurang, tekanan panggul, nyeri punggung, dan keluarnya cairan dari vagina.

e. Demam Tinggi atau Tanda-tanda Infeksi

Jika Anda mengalami demam tinggi atau tanda-tanda infeksi selama kehamilan berisiko tinggi, penting untuk segera menghubungi penyedia layanan kesehatan Anda. Ini bisa menjadi tanda infeksi serius yang memerlukan perhatian segera.

f. Kekhawatiran atau Pertanyaan Lain Mengenai Kehamilan Anda

Terakhir, jika Anda memiliki kekhawatiran atau pertanyaan lain tentang kehamilan berisiko tinggi Anda, penting untuk segera menghubungi penyedia layanan kesehatan Anda. Mereka akan mendukung Anda selama proses ini dan memastikan Anda dan bayi Anda tetap sehat. (Alexander Kofinas, 2024)

C. Kesimpulan

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang terjadi pada tubuh wanita, tetapi dapat berkembang menjadi kondisi patologis yang berisiko tinggi bagi ibu maupun janin. Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang memiliki potensi komplikasi

serius sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Faktor-faktor risiko umum kehamilan risiko tinggi meliputi usia ibu lanjut, kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, riwayat kehamilan risiko tinggi, gangguan genetik, kehamilan ganda, dan gaya hidup yang tidak sehat.

Deteksi dini tanda bahaya kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan janin. Tanda bahaya kehamilan bervariasi pada setiap trimester:

1. Trimester I: Perdarahan pervaginam, kehamilan ektopik, mola hidatidosa, muntah berlebihan, anemia, dan demam tinggi.
2. Trimester II: Demam tinggi, gerakan janin berkurang, dan anemia.
3. Trimester III: Perdarahan pervaginam, sakit kepala hebat, penglihatan kabur, bengkak abnormal, gerakan janin berkurang, ketuban pecah dini, kejang, anemia, dan demam tinggi.

Pemahaman tentang tanda bahaya dan risiko pada setiap trimester kehamilan sangat penting bagi ibu hamil dan tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan yang tepat dan mencegah komplikasi serius. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pemantauan berkala, konseling genetik, gaya hidup sehat, serta perawatan medis yang sesuai dengan kondisi ibu dan janin.

D. Referensi

- Alexander Kofinas. (2024). *High-Risk Pregnancy Management: Perspectives, Tips & Care*. <https://drkofinas.com/high-risk-pregnancy-management-perspectives-tips-care/>
- BPPSDM. (2015). *Modul Asuhan Kebidanan Kehamilan* (BPPSDMK (ed.)).
- Ferdita Yurike Viariska, M. (2024). FAKTOR–FAKTORYANGBERHUBUNGANDENGAN KEJADIAN KEHAMILAN RISIKO TINGGIPADAPRIMIGRAVIDA. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(2).
- Kemenkes RI. (2020). *Buku KIA*. Kemenkes.
- Miskawati. (2023). *Tanda Bahaya Kehamilan*. http://eprints.poltekkesjogja.ac.id.https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Feprints.poltekkesjogja.ac.id%2F13427%2F4%2FBab%2520II.pdf&sca_esv=0871ff21afb3ee13&sxsrf=ADLYWIJJAz58hnyt5wIp2bZgGTSNgbnu6Q%3A1725838114642&ei=IjPeZrf2JoWPseMPxLv0iAU&ved=0ahUKEwi3j43-v7SIAxWFR2wGHcQdHVEQ4dUDCA
- Retnaningtyas, E. (2016). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–215. [repository.unimus.ac.id/.../5. BAB II TINJAUAN TEORI.pdf](https://repository.unimus.ac.id/.../5.BAB%20II%20TINJAUAN%20TEORI.pdf)
- Rinata, E. (2023). *Buku Ajar ASuhan Kebidanan Pathologi (Kehamilan)*. Umsida Press.

- Senditya Indah M;Nicky Danur. (2022). *Buku Saku Bagi Kader Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi*. STIKES Widyagama Husada.
- Suryani, Z. . (2023). *DETEKSI DINI KEHAMILAN BERESIKO DENGAN KARTU SKOR POEDJI ROCHJATI*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/zt5v8>
- WHO. (2021). *WHO recommendation on effective communication between maternity care providers and women in labour*. <https://srhr.org/rhl/article/who>
- Alexander Kofinas. (2024). *High-Risk Pregnancy Management: Perspectives, Tips & Care*. <https://drkofinas.com/high-risk-pregnancy-management-perspectives-tips-care/>
- BPPSDM. (2015). *Modul Asuhan Kebidanan Kehamilan* (BPPSDMK (ed.)).
- Ferdita Yurike Viariska, M. (2024). FAKTOR–FAKTORYANGBERHUBUNGANDENGAN KEJADIAN KEHAMILAN RISIKO TINGGIPADAPRIMIGRAVIDA. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(2).
- Kemenkes RI. (2020). *Buku KIA*. Kemenkes.
- Miskawati. (2023). *Tanda Bahaya Kehamilan*. http://eprints.poltekkesjogja.ac.id.https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Feprints.poltekkesjogja.ac.id%2F13427%2F4%2FBab%2520II.pdf&sca_esv=0871ff21afb3ee13&sxsrf=ADLYWIJJAz58hnyt5wIp2bZgGTSNgbnu6Q%3A1725838114642&ei=IjPeZrf2JoWPseMPxLv0iAU&ved=0ahUKEwi3j43-v7SIAxWFR2wGHcQdHVEQ4dUDCA
- Retnaningtyas, E. (2016). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–215. repository.unimus.ac.id/.../5. BAB II TINJAUAN TEORI.pdf
- Rinata, E. (2023). *Buku Ajar ASuhan Kebidanan Pathologi (Kehamilan)*. Umsida Press.
- Senditya Indah M;Nicky Danur. (2022). *Buku Saku Bagi Kader Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi*. STIKES Widyagama Husada.
- Suryani, Z. . (2023). *DETEKSI DINI KEHAMILAN BERESIKO DENGAN KARTU SKOR POEDJI ROCHJATI*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/zt5v8>
- WHO. (2021). *WHO recommendation on effective communication between maternity care providers and women in labour*. <https://srhr.org/rhl/article/who>
- Alexander Kofinas. (2024). *High-Risk Pregnancy Management: Perspectives, Tips & Care*. <https://drkofinas.com/high-risk-pregnancy-management-perspectives-tips-care/>
- BPPSDM. (2015). *Modul Asuhan Kebidanan Kehamilan* (BPPSDMK (ed.)).
- Ferdita Yurike Viariska, M. (2024). FAKTOR–FAKTORYANGBERHUBUNGANDENGAN KEJADIAN KEHAMILAN RISIKO TINGGIPADAPRIMIGRAVIDA. *Jurnal*

Kesehatan Tambusai, 3(2).

Kemenkes RI. (2020). *Buku KIA*. Kemenkes.

Miskawati. (2023). *Tanda Bahaya Kehamilan*. http://eprints.poltekkesjogja.ac.id.https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Feprints.poltekkesjogja.ac.id%2F13427%2F4%2FBab%2520II.pdf&sca_esv=0871ff21afb3ee13&sxsrf=ADLYWIJJAz58hnyt5wIp2bZgGTSNgbnu6Q%3A1725838114642&ei=IjPeZrf2JoWPseMPxLv0iAU&ved=0ahUKEwi3j43-v7SIAxWFR2wGHcQdHVEQ4dUDCA

Retnaningtyas, E. (2016). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–215. [repository.unimus.ac.id/.../5. BAB II TINJAUAN TEORI.pdf](https://repository.unimus.ac.id/.../5.BAB%20II%20TINJAUAN%20TEORI.pdf)

Rinata, E. (2023). *Buku Ajar ASuhan Kebidanan Pathologi (Kehamilan)*. Umsida Press.

Senditya Indah M;Nicky Danur. (2022). *Buku Saku Bagi Kader Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi*. STIKES Widyagama Husada.

Suryani, Z. . (2023). *DETEKSI DINI KEHAMILAN BERESIKO DENGAN KARTU SKOR POEDJI ROCHJATI*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/zt5v8>

WHO. (2021). *WHO recommendation on effective communication between maternity care providers and women in labour*. <https://srhr.org/rhl/article/who>

E. Glosarium

NIPT	= Non-Invasive Prenatal Tes
CVS	= Computer Vision Syndrome
USG	= Ultrasonografi
NICU	= Neonatal Intensive Care Unit

CHAPTER 4

PENCEGAHAN INFEKSI PADA KEHAMILAN

Bd. Siti Nur Farida, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa kehamilan adalah saat-saat yang rentan baik bagi ibu hamil maupun bagi janinnya. Banyak penyesuaian yang perlu dilakukan agar ibu hamil bisa melewati masa kehamilannya dengan baik dan melahirkan bayi yang sehat. Salah satunya adalah memastikan tubuh bebas dari infeksi dan penyakit yang dapat membahayakan janin. Infeksi pada ibu hamil dapat mengakibatkan penularan melalui plasenta ke janin dan dapat terjadi kelahiran premature

Masa kehamilan merupakan masa yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan, karena tumbuh kembang anak sangat ditentukan kondisinya pada masa janin dalam kandungan. Ibu hamil merupakan kelompok rentan yang terkena infeksi. Ibu hamil yang terinfeksi penyakit dapat menularkan ke janin dalam kandungannya sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin menjadi terganggu bahkan dapat menyebabkan kematian. Beberapa penyakit yang harus dideteksi selama kehamilan adalah infeksi HIV, Sifilis, dan Hepatitis B (Kemenkes RI, 2015).

World Health Organization (2016) menyebutkan selama periode neonatal, kematian bayi disebabkan prematuritas (35,2%), komplikasi berhubungan dengan intrapartum (23,9%) dan sepsis (15,2%). Angka kelahiran prematur di Indonesia menempati posisi ke 6 dari 10 negara atau setara dengan 15,5 % per 100 kelahiran. Persalinan preterm, berat lahir rendah, infeksi, asfiksia dan trauma kelahiran merupakan faktor penyebab utama kematian bayi di dunia. Dan prematurity penyebab kematian paling tinggi kematian bayi di Indonesia.

Data dari World Health Organization (WHO) di Asia Tenggara pada tahun 2015, angka HIV mencapai 5,1 juta jiwa pasien dengan 77.000 wanita hamil hidup dengan HIV, dan 19.000 kasus infeksi HIV pediatrik baru telah ditemukan. Data Sifilis, incidence rate telah menunjukkan peningkatan sebanyak 0,32% di wilayah Asia Tenggara. Jumlah pasien menunjukkan angka hingga 167.000 kasus Sifilis pada ibu hamil. Data Hepatitis B di Asia Tenggara tercatat 15% dari jumlah total pasien Hepatitis B di seluruh dunia dengan jumlah 39 juta orang. Data di Indonesia pada tahun 2019 prevalensi HIV mencapai 0,39%, prevalensi sifilis 2,5%, dan Hepatitis B 2,5% (Kemenkes RI, 2019).

Salah satu infeksi vagina yang paling sering yang dialami oleh Wanita hamil adalah bakterial vaginosis. Hal ini sebagai faktor penting dalam etiologic ketuban pecah dini dan morbiditas perinatal. Dan komplikasi yang paling sering terjadi setelah ketuban pecah dini adalah infeksi intrauterin (Demet et al. 2013)

Program Pencegahan Penularan Ibu dan Anak (PPIA) yang terdiri dari tiga penyakit menular yaitu HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dimanfaatkan untuk mencegah penularan infeksi penyakit menular langsung dari ibu ke bayi yang terjadi secara vertikal. Program PPIA yang dilaksanakan dalam paket pelayanan antenatal terpadu bertujuan untuk mencapai triple eliminasi penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak. Pelayanan antenatal terpadu melalui program PPIA sebagai program triple eliminasi penyakit HIV, sifilis dan hepatitis B dari ibu ke anak menjadi prioritas utama kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Pemeriksaan skrining yang digunakan adalah HIV rapid test, RPR (Rapid Plasma Reagin), Tp rapid (*Treponema pallidum* rapid), dan HBsAg (Hepatitis B surface Antigen) rapid test (Kemenkes RI, 2019).

B. Jenis-jenis Infeksi Selama Kehamilan

1. Infeksi Bakteri

Infeksi bakteri dapat terjadi selama kehamilan dan menimbulkan berbagai masalah bagi ibu dan janin. Contoh infeksi bakteri yang umum adalah infeksi saluran kemih (ISK), infeksi vagina, dan infeksi pada plasenta

Infeksi bakteri pada kehamilan merupakan masalah kesehatan yang serius dan dapat berdampak buruk pada ibu dan janin. Bakteri dapat masuk ke tubuh ibu melalui berbagai cara, seperti melalui saluran vagina, saluran kemih, atau luka terbuka. Beberapa jenis bakteri yang umum menyebabkan infeksi selama kehamilan antara lain *Escherichia coli*, *Streptococcus Group B*, *Chlamydia trachomatis*, dan *Neisseria gonorrhoeae*.

Infeksi bakteri dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, seperti infeksi kandung kemih, infeksi vagina, infeksi rahim, infeksi selaput ketuban, dan infeksi darah (sepsis). Beberapa infeksi bakteri juga dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, atau kematian janin. Untuk mencegah infeksi bakteri, penting bagi ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan yang sehat, dan berkonsultasi dengan dokter secara teratur untuk pemeriksaan kehamilan dan vaksinasi yang diperlukan.

Beberapa contoh infeksi bakteri yang umum terjadi pada kehamilan

- a. Infeksi saluran kemih (ISK) yang disebabkan oleh bakteri seperti *Escherichia coli*. ISK dapat menyebabkan nyeri saat berkemih, frekuensi buang air kecil yang meningkat, dan darah dalam urine.
- b. Infeksi vagina (vaginitis) yang disebabkan oleh bakteri seperti *Gardnerella*

vaginalis atau *Candida albicans*. Vaginitis dapat menyebabkan keputihan abnormal, rasa gatal, dan pembengkakan di sekitar vagina.

- c. Infeksi selaput ketuban (chorioamnionitis) yang disebabkan oleh bakteri seperti *Streptococcus Group B*. Chorioamnionitis dapat menyebabkan demam, nyeri perut, dan peningkatan detak jantung janin

2. Infeksi Virus

Infeksi virus seperti rubella, cytomegalovirus (CMV), dan herpes simplex virus (HSV) dapat menyebabkan komplikasi serius bagi janin. Infeksi ini dapat menyebabkan cacat lahir, masalah perkembangan, dan kematian janin

Infeksi virus selama kehamilan dapat menjadi ancaman serius bagi ibu dan janin. Beberapa jenis virus yang paling umum dan berpotensi berbahaya selama kehamilan termasuk:

- a. Virus cytomegalovirus (CMV)
- b. Virus rubella (campak Jerman)
- c. Virus varicella zoster (cacar air)
- d. Virus influenza
- e. Virus Zika

Infeksi CMV dapat menyebabkan cacat lahir, keterlambatan perkembangan, dan masalah pendengaran pada bayi. Rubella dapat menyebabkan kelainan jantung, katarak, dan tuli pada bayi. Varicella zoster dapat menyebabkan cacat lahir, masalah pernapasan, dan infeksi kulit pada bayi. Influenza dapat menyebabkan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Virus Zika dapat menyebabkan mikrosefali dan cacat lahir lainnya pada bayi

Infeksi virus selama kehamilan dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, melalui cairan tubuh seperti air liur, air mata, dan darah, atau melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Penting bagi ibu hamil untuk menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi dan untuk mendapatkan vaksinasi yang tepat untuk mencegah infeksi virus tertentu

Gejala infeksi virus selama kehamilan dapat bervariasi tergantung pada jenis virusnya. Beberapa gejala umum termasuk demam, ruam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Jika Anda hamil dan mengalami gejala infeksi virus, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat

3. Infeksi Parasit

Infeksi parasit seperti toksoplasmosis, malaria, dan sifilis dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Parasit dapat menginfeksi plasenta dan janin, menyebabkan cacat lahir, kelahiran prematur, dan masalah kesehatan jangka panjang

Infeksi parasit selama kehamilan dapat terjadi melalui berbagai jalur, seperti konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, kontak dengan tanah atau air yang tercemar, atau gigitan serangga. Beberapa parasit yang dapat menginfeksi ibu hamil dan berpotensi membahayakan janin meliputi:

- a. *Toxoplasma gondii*: Parasit ini dapat ditularkan melalui konsumsi daging mentah atau kurang matang, kontak dengan kotoran kucing, atau kontak dengan tanah yang terkontaminasi. Infeksi *Toxoplasma gondii* dapat menyebabkan kerusakan otak, kebutaan, atau cacat lahir pada janin.
- b. Cytomegalovirus (CMV): Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan air liur, urine, atau tinja orang yang terinfeksi. CMV dapat menyebabkan gangguan pendengaran, kerusakan otak, atau kebutaan pada janin.
- c. Zika Virus: Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Zika virus dapat menyebabkan cacat lahir seperti mikrosefali pada janin.
- d. *Plasmodium falciparum*: Parasit penyebab malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles*. Malaria dapat menyebabkan anemia, kerusakan organ, dan bahkan kematian pada ibu hamil dan janin.

Gejala infeksi parasit selama kehamilan dapat bervariasi, tergantung pada jenis parasit dan tingkat keparahan infeksi. Beberapa gejala umum meliputi demam, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Infeksi parasit yang tidak tertangani dapat menyebabkan komplikasi serius baik bagi ibu maupun janin.

4. Infeksi Jamur

Infeksi jamur seperti kandidiasis atau infeksi jamur vagina, dapat terjadi selama kehamilan. Infeksi ini biasanya tidak berbahaya bagi janin, tetapi dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan peradangan pada ibu.

C. Faktor Risiko Infeksi Kehamilan

1. Kondisi Kesehatan Ibu

Wanita dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan autoimun, memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi selama kehamilan. Sistem kekebalan tubuh mereka mungkin lemah, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi.

Kondisi kesehatan ibu hamil merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi risiko infeksi selama kehamilan. Beberapa kondisi kesehatan yang dapat meningkatkan risiko infeksi meliputi:

- 1) Sistem Imun yang Lemah: Kondisi seperti HIV/AIDS, diabetes, penyakit autoimun, atau pengobatan imunosupresif dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ibu hamil, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi.

- 2) Penyakit Menular Seksual (PMS): Infeksi PMS seperti gonore, klamidia, dan sifilis dapat menyebabkan komplikasi serius selama kehamilan, termasuk kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian janin.
- 3) Penyakit Kronis: Kondisi kronis seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit hati dapat meningkatkan risiko infeksi selama kehamilan karena melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko komplikasi.
- 4) Kehamilan Ganda: Kehamilan ganda dapat meningkatkan risiko infeksi karena beban kerja tubuh yang lebih berat dan risiko komplikasi yang lebih tinggi.
- 5) Usia Ibu: Wanita hamil yang berusia muda atau tua memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita hamil di usia subur.

Jika ibu hamil memiliki kondisi kesehatan tertentu, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran dan pengobatan yang tepat guna mencegah risiko infeksi.

2. Gaya Hidup Ibu

Merokok, konsumsi alkohol, penggunaan narkoba, dan diet yang tidak sehat dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ibu hamil, meningkatkan risiko infeksi. Kurangnya asupan nutrisi penting seperti vitamin dan mineral juga dapat memperburuk kondisi ini.

- a. Merokok : Merokok selama kehamilan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi. Asap rokok juga dapat memengaruhi perkembangan janin dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan
- b. Konsumsi Alkohol : Konsumsi alkohol selama kehamilan dapat meningkatkan risiko infeksi karena alkohol dapat menekan sistem kekebalan tubuh dan memengaruhi pertumbuhan janin.
- c. Penggunaan Obat-obatan Terlarang : Penggunaan obat-obatan terlarang selama kehamilan dapat meningkatkan risiko infeksi, komplikasi kehamilan, dan cacat lahir pada janin. Obat-obatan terlarang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memengaruhi perkembangan janin.
- d. Kurangnya Aktivitas Fisik : Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko infeksi karena dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Olahraga ringan dan teratur selama kehamilan dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu mencegah infeksi
- e. Diet yang Tidak Seimbang : Diet yang tidak seimbang dan kekurangan nutrisi penting dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi. Konsumsi makanan bergizi seimbang dan kaya vitamin dan mineral sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin.

- f. Kurang Istirahat : Kurang istirahat dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin selama kehamilan.

3. Lingkungan Sekitar

Lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi risiko infeksi selama kehamilan. Paparan terhadap zat-zat berbahaya seperti polusi udara, air yang terkontaminasi, atau bahan kimia dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ibu hamil dan meningkatkan risiko infeksi

- Polusi udara: Udara yang tercemar dapat mengandung bakteri, virus, dan jamur yang dapat menginfeksi ibu hamil.
- Air yang terkontaminasi: Air minum atau air yang digunakan untuk mandi yang terkontaminasi dapat mengandung bakteri, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan infeksi.
- Paparan bahan kimia: Pekerjaan yang melibatkan paparan bahan kimia berbahaya, seperti pestisida atau logam berat, dapat meningkatkan risiko infeksi.

D. Gejala Umum Inferksi Kehamilan

Infeksi selama kehamilan dapat memicu berbagai gejala, yang dapat bervariasi tergantung pada jenis infeksi dan tingkat keparahannya. Gejala ini bisa muncul secara tiba-tiba atau bertahap, dan mungkin menyerupai gejala penyakit lain. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan dokter segera jika Anda mengalami gejala yang mencurigakan

Demam

Demam merupakan salah satu gejala umum infeksi, termasuk infeksi selama kehamilan. Peningkatan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius dapat menjadi tanda infeksi yang perlu diwaspadai.

Nyeri Perut

Nyeri perut yang tidak biasa, terutama jika disertai demam, dapat menjadi tanda infeksi di saluran pencernaan atau organ reproduksi. Konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis yang tepat.

Keputihan Abnormal

Perubahan warna, bau, atau tekstur keputihan bisa menandakan infeksi pada vagina atau serviks. Keputihan abnormal yang disertai gejala lain seperti demam atau nyeri perlu segera ditangani.

Nyeri Saat Berkemih

Nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil dapat mengindikasikan infeksi saluran kemih. Infeksi ini dapat terjadi selama kehamilan dan perlu ditangani secara tepat untuk mencegah komplikasi.

Gambar 4.1 Gejala Selama Kehamilan

E. Diagnosis Infeksi Kehamilan

Mendiagnosis infeksi selama kehamilan memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan riwayat medis pasien, pemeriksaan fisik, dan

berbagai tes laboratorium dan pencitraan. Dokter akan menanyakan tentang gejala yang dialami, riwayat kesehatan ibu, dan riwayat paparan risiko infeksi

1	Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan fisik meliputi pengukuran suhu tubuh, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan jantung, dan pemeriksaan perut untuk menilai kondisi umum ibu dan janin	2	Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan laboratorium sangat penting untuk mengidentifikasi jenis infeksi. Tes darah dapat mendeteksi adanya infeksi bakteri, virus, atau parasit. Urin dan cairan vagina juga dapat diuji untuk mendiagnosis infeksi saluran kemih atau infeksi vagina.	3	Pemeriksaan Pencitraan Pemeriksaan pencitraan seperti USG dapat digunakan untuk menilai kondisi janin dan mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi akibat infeksi. Pemeriksaan pencitraan lainnya, seperti X-ray, CT scan, atau MRI, mungkin diperlukan dalam beberapa kasus untuk menilai kondisi ibu lebih lanjut.
----------	--	----------	--	----------	--

Gambar 4.2 Diagnosis Infeksi Selama Kehamilan

F. Pencegahan Infeksi Kehamilan

1. Menjaga Kebersihan Diri

Salah satu cara paling efektif untuk mencegah infeksi selama kehamilan adalah dengan menjaga kebersihan diri. Hal ini termasuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air, terutama setelah menggunakan toilet, mengganti popok, atau berhubungan dengan hewan peliharaan. Mandi atau membersihkan diri secara teratur juga penting untuk menjaga kebersihan tubuh dan meminimalkan risiko infeksi. Selain itu, menjaga kebersihan area genital dengan membersihkan dari depan ke belakang setelah buang air kecil atau besar dapat membantu mencegah infeksi saluran kemih. Hindari menggunakan sabun yang beraroma atau mengandung bahan kimia keras, karena dapat mengiritasi area genital.

2. Nutrisi Seimbang

Menjaga asupan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Beberapa jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi selama kehamilan meliputi buah-buahan, sayuran, daging tanpa lemak, ikan, dan produk susu rendah lemak. Hindari makanan olahan, makanan cepat saji, dan makanan tinggi gula, karena dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi.

3. Aktivitas Fisik Teratur

Olahraga teratur selama kehamilan dapat meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kebugaran, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat membantu mencegah infeksi dan menjaga kesehatan ibu dan janin. Namun, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program olahraga baru. Hindari olahraga yang terlalu berat atau berisiko tinggi, seperti lari maraton atau olahraga kontak. Berjalan kaki, berenang, atau yoga ringan merupakan pilihan olahraga yang aman dan efektif selama kehamilan.

4. Menghindari Paparan Risiko

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko infeksi selama kehamilan, seperti kontak dengan orang yang sakit, penggunaan narkoba, atau paparan zat kimia berbahaya. Hindari kontak dengan orang yang sakit, terutama mereka yang menderita penyakit menular seperti flu atau campak. Sebaiknya juga menghindari penggunaan narkoba atau zat kimia berbahaya selama kehamilan.

G. Pengobatan Infeksi Kehamilan

1. Terapi Antibiotik

Terapi antibiotik merupakan salah satu metode pengobatan utama untuk mengatasi infeksi bakteri selama kehamilan. Pemilihan jenis antibiotik disesuaikan dengan jenis bakteri penyebab infeksi dan kondisi kehamilan ibu. Ada beberapa antibiotik yang aman digunakan selama kehamilan, seperti penisilin, amoksisilin, dan eritromisin. Namun, beberapa antibiotik lain memiliki risiko terhadap janin, seperti tetrasiklin, streptomisin, dan kloramfenikol. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi antibiotik selama kehamilan.

Penggunaan antibiotik selama kehamilan harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan dokter. Dosis dan durasi terapi antibiotik disesuaikan dengan jenis infeksi, kondisi ibu, dan usia kehamilan. Dokter akan mempertimbangkan risiko dan manfaat dari penggunaan antibiotik terhadap ibu dan janin sebelum meresepkannya.

Terapi antibiotik dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti oral, intravena, atau intramuskular. Pemilihan cara pemberian antibiotik tergantung pada kondisi ibu dan jenis infeksi yang dialami. Penting untuk menyelesaikan terapi antibiotik sesuai dengan anjuran dokter, meskipun gejala infeksi telah hilang. Hal ini untuk memastikan bahwa semua bakteri penyebab infeksi telah dimusnahkan dan mencegah resistensi antibiotik.

2. Terapi Antiviral

Terapi antiviral merupakan pengobatan yang ditujukan untuk melawan infeksi virus selama kehamilan. Obat-obatan antiviral bekerja dengan cara

menghambat replikasi virus di dalam tubuh, sehingga mengurangi jumlah virus dan mempercepat proses penyembuhan.

Terapi antiviral diberikan berdasarkan jenis virus yang menginfeksi dan tingkat keparahan infeksi. Beberapa obat antiviral umum yang digunakan selama kehamilan meliputi:

- a. Acyclovir: Obat ini efektif dalam mengatasi infeksi herpes simplex virus (HSV) dan varicella zoster virus (VZV).
- b. Ganciclovir: Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi cytomegalovirus (CMV), virus yang dapat menyebabkan masalah pada janin.
- c. Oseltamivir: Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi influenza, terutama pada trimester pertama kehamilan.

Penggunaan terapi antiviral selama kehamilan harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat potensi efek samping pada ibu dan janin. Dokter akan mempertimbangkan manfaat terapi antiviral dibandingkan dengan risikonya sebelum meresepkan obat. Dalam beberapa kasus, pengobatan antiviral mungkin perlu dihindari atau diubah selama kehamilan untuk meminimalkan risiko bagi janin

3. Terapi Antiparasit

Infeksi parasit selama kehamilan dapat diobati dengan terapi antiparasit. Terapi ini bertujuan untuk membunuh atau mengendalikan parasit yang menginfeksi tubuh ibu hamil. Jenis obat antiparasit yang digunakan akan disesuaikan dengan jenis parasit yang menginfeksi.

Terapi antiparasit yang umum digunakan untuk infeksi selama kehamilan termasuk obat-obatan seperti:

- a. Metronidazole
- b. Tinidazole
- c. Pyrimethamine
- d. Sulfadoxine
- e. Ivermectin
- f. Mebendazole

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua obat antiparasit aman untuk digunakan selama kehamilan. Beberapa obat dapat menyebabkan efek samping berbahaya pada janin. Oleh karena itu, penggunaan obat antiparasit selama kehamilan harus diawasi dengan ketat oleh dokter spesialis.

Selain pengobatan dengan obat-obatan, terapi antiparasit juga dapat melibatkan perubahan gaya hidup, seperti menjaga kebersihan diri, menghindari konsumsi makanan mentah atau setengah matang, dan menghindari kontak dengan hewan yang terinfeksi

H. Komplikasi dan Risiko Kehamilan

1. Dampak terhadap Ibu

Infeksi selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi bagi ibu, termasuk:

- a. Preeklamsia
- b. Persalinan prematur
- c. Ketuban pecah dini
- d. Endometritis
- e. Sepsis

Beberapa infeksi juga dapat meningkatkan risiko komplikasi setelah persalinan, seperti infeksi luka jahitan atau infeksi saluran kemih

2. Dampak terhadap Janin

Infeksi selama kehamilan juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap janin, termasuk:

- a. Keguguran
- b. Kelahiran prematur
- c. Berat badan lahir rendah
- d. Gangguan perkembangan janin
- e. Infeksi bawaan

Beberapa infeksi, seperti toksoplasmosis, dapat menyebabkan cacat lahir yang serius. Infeksi lain dapat meningkatkan risiko kematian janin.

I. Kesimpulan

Infeksi selama kehamilan merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk bagi ibu dan Janin. Penting bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta menghindari paparan risiko infeksi. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan menerapkan pola hidup sehat, risiko infeksi dapat diminimalkan.

Diagnosis dan pengobatan infeksi pada ibu hamil harus dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman. Terapi yang tepat dapat mencegah komplikasi dan memastikan kesehatan ibu dan janin. Informasi yang akurat dan edukasi tentang infeksi kehamilan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan infeksi.

Dengan memahami faktor risiko, gejala, dan pencegahan infeksi, ibu hamil dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan dirinya dan perkembangan janin. Tetaplah berkomunikasi dengan dokter atau bidan untuk mendapatkan informasi dan panduan yang tepat.

J. Referensi

Kementerian Kesehatan RI. 2015 . Sekretariat r Jenderal. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI

Kementrian Kesehatan RI, 2019, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019, Jakarta, Kementrian Kesehatan RI.

Barry,Dede demet,et al.(2013).Bersepeda Untuk Kebugaran.Penerbit:Pakar raya.Bandung.

K. Glosarium

Janin - bayi yang belum lahir sejak minggu kedelapan setelah pembuahan hingga persalinan.

Asam folat - zat gizi yang ditemukan dalam beberapa sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, buncis, buah jeruk, sereal sarapan yang diperkaya, dan beberapa suplemen vitamin. Asam folat dapat membantu mengurangi risiko cacat lahir pada otak dan sumsum tulang belakang.

Prematur - menggambarkan bayi yang lahir sebelum 37 minggu kehamilan.

Prematur - terjadi sebelum 37 minggu kehamilan.

Penyakit Rh - komplikasi yang terjadi akibat ketidakcocokan antara golongan darah ibu dan

Toksoplasmosis - infeksi yang disebabkan oleh parasit yang dapat menyebabkan penyakit serius atau kematian pada janin.

Ultrasonografi - teknik pencitraan diagnostik yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk membuat gambar tubuh dan organ janin serta jaringan di sekitarnya.

Dinding rahim - dinding rahim.

Rahim (disebut juga rahim) - organ berongga berbentuk buah pir yang terletak di perut bagian bawah wanita, di antara kandung kemih dan rektum, yang melepaskan lapisannya setiap bulan selama menstruasi dan tempat sel telur yang telah dibuahi (ovum) tertanam dan janin berkembang.

Vagina - bagian alat kelamin wanita, di belakang kandung kemih dan di depan rektum, yang membentuk saluran yang memanjang dari rahim ke vulva.

Vernix caseosa (juga disebut vernix) - zat putih yang menutupi kulit janin (saat berada di dalam rahim) dan membantu melindungi janin.

CHAPTER 5

PENYUSUAN ASI: PERSIAPAN DAN TANTANGAN YANG MUNGKIN DIHADAPI IBU BARU

Anis Ervina, S.S.T., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi utama yang direkomendasikan bagi bayi karena mengandung zat gizi lengkap serta antibodi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi dan dilanjutkan hingga dua tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) merupakan standar emas dalam pemberian nutrisi bagi bayi (WHO, 2021).

Di Indonesia, angka cakupan ASI eksklusif masih bervariasi antar daerah. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI (2022), cakupan ASI eksklusif secara nasional mencapai 50,2%, namun masih ada daerah dengan angka yang lebih rendah dari target yang ditetapkan. Rendahnya keberhasilan pemberian ASI dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai penyusuan sejak masa kehamilan, yang dapat berujung pada kegagalan menyusui setelah melahirkan.

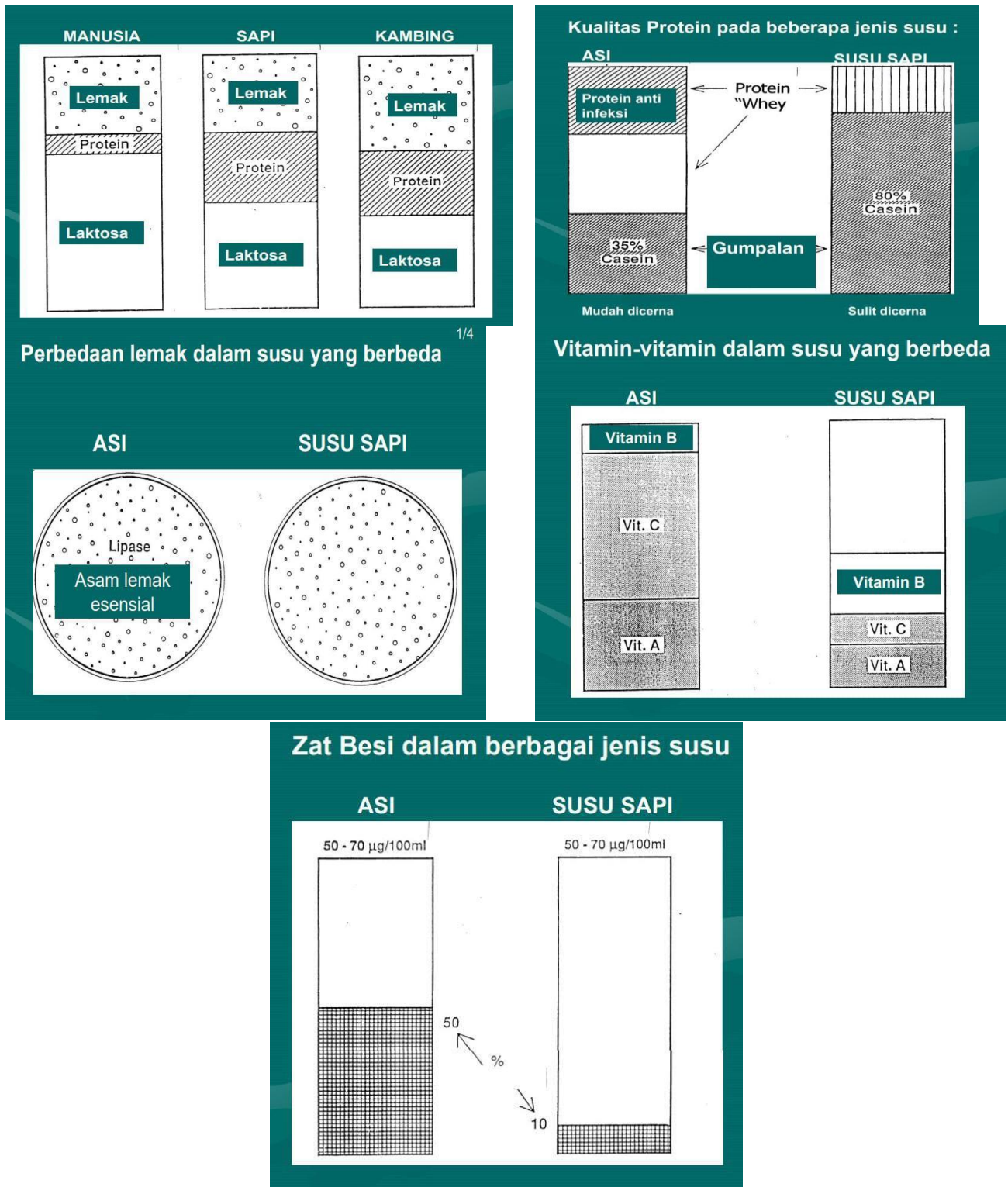
Persiapan menyusui yang dimulai sejak kehamilan sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI. Kurangnya edukasi mengenai manajemen laktasi, mitos seputar ASI, serta minimnya dukungan dari lingkungan dan fasilitas kesehatan turut menjadi hambatan dalam pemberian ASI yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang penyusuan ASI agar ibu dapat mempersiapkan diri secara fisik dan psikologis sebelum proses menyusui dimulai.

B. Persiapan Penyusuan ASI

1. Pentingnya Pemberian ASI

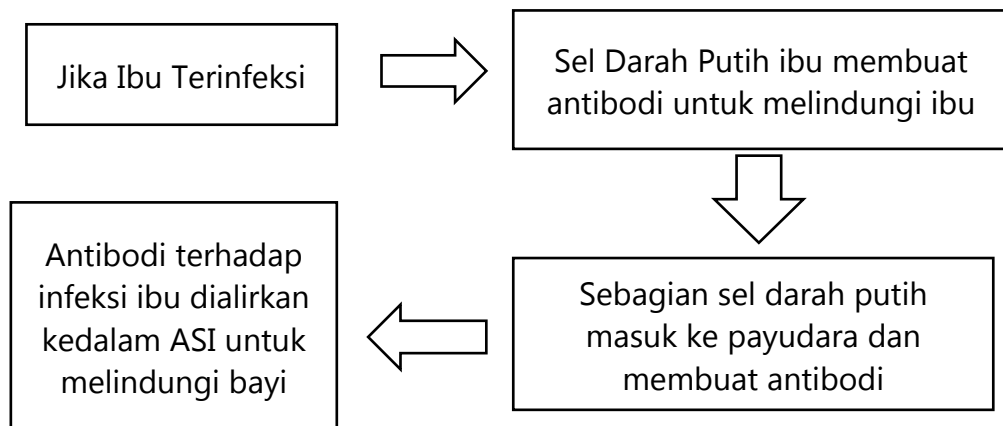
ASI eksklusif diberikan selama enam bulan pertama kehidupan bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lain, dan dianjurkan untuk dilanjutkan hingga usia dua tahun dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Adapun Manfaat ASI mencakup:

- a. Pemberian Nutrisi Optimal: ASI mengandung zat gizi sesuai dengan kebutuhan bayi, termasuk protein, lemak, karbohidrat, serta vitamin dan mineral penting. Mudah dicerna dan diserap secara efisien

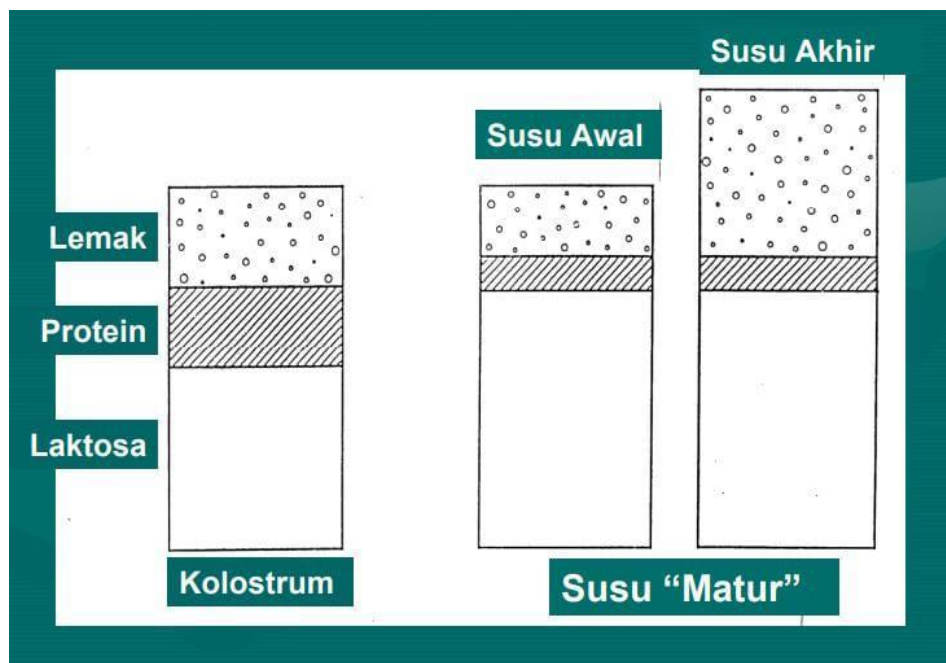


**Gambar 5.1 Perbandingan Kandungan ASI dengan jenis susu lain
(sumber: Modul 40 Jam WHO Konseling Laktasi)**

b. Perlindungan terhadap infeksi



Gambar 5.2 Perlindungan terhadap Infeksi
(sumber: Modul 40 Jam WHO Konseling Laktasi)

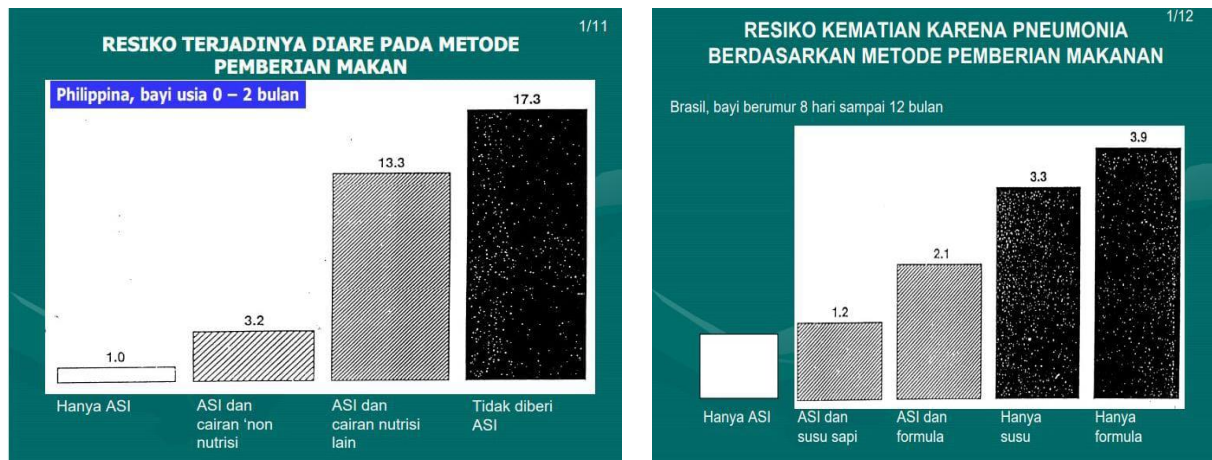


Gambar 5.3 Perbedaan kandungan Kolostrum dan ASI Matur
(sumber: Modul 40 Jam WHO Konseling Laktasi)

Tabel 5.1 Kandungan Kolostrum dan Manfaatnya

KANDUNGAN	MANFAAT
Kaya Antibodi	Melindungi terhadap infeksi dan alergi
Banyak Sel Darah Putih	Melindungi terhadap infeksi
Pencakar	Membersihkan dari Mekonium Membantu mencegah terjadinya kuning pada bayi (icterus)
Faktor-faktor Pertumbuhan	Membantu usus berkembang lebih matang, mencegah alergi dan ketidakcocokan (intoleransi)

Kaya Vitamin A	Mengurangi Keparahan infeksi dan mencegah penyakit mata.
----------------	--



Gambar 5.4 Resiko Kesakitan dan Kematian Berdasarkan Metode Pemberian makan pada Bayi.
(sumber: Modul 40 Jam WHO Konseling Laktasi)

c. Membantu Bonding dan perkembangan bayi

1) Ikatan Emosi

- Kedekatan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak
- Secara Emosional, ibu mendapatkan rasa puas terhadap pengasuhan bayinya
- Bayi menjadi jarang menangis
- Ibu berperilaku lebih menyayangi bayinya
- Meniadakan keinginan untuk menyiksa atau menelantarkan bayinya

2) Perkembangan

Lebih baik dalam melakukan test kecerdasan pada masa kanak-kanak.

d. Membantu menunda kehamilan baru

Pemberian ASI eksklusif dapat menunda ovulasi dan mengurangi kemungkinan kehamilan baru dalam enam bulan pertama setelah melahirkan. Metode ini dikenal sebagai Lactational Amenorrhea Method (LAM). LAM efektif jika ibu menyusui secara eksklusif tanpa pemberian makanan tambahan, bayi berusia di bawah enam bulan, dan ibu belum mengalami menstruasi pascapersalinan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Namun, efektivitasnya dapat menurun jika tidak diterapkan dengan benar, sehingga metode kontrasepsi tambahan tetap disarankan setelah enam bulan.

e. Melindungi Kesehatan Ibu

Menyusui membantu mengurangi risiko berbagai penyakit seperti kanker payudara, kanker ovarium, osteoporosis, dan diabetes tipe 2, Proses menyusui menurunkan kadar estrogen yang tinggi dalam tubuh pasca kehamilan, yang berperan dalam memicu pertumbuhan sel kanker pada payudara dan ovarium. Selain itu, menyusui membantu ibu dalam menurunkan berat badan setelah melahirkan dengan membakar kalori lebih banyak. Proses menyusui juga merangsang pelepasan hormon oksitosin yang mempercepat kontraksi rahim kembali ke ukuran normal setelah persalinan, sehingga mengurangi risiko perdarahan postpartum (Lawrence & Lawrence, 2020).

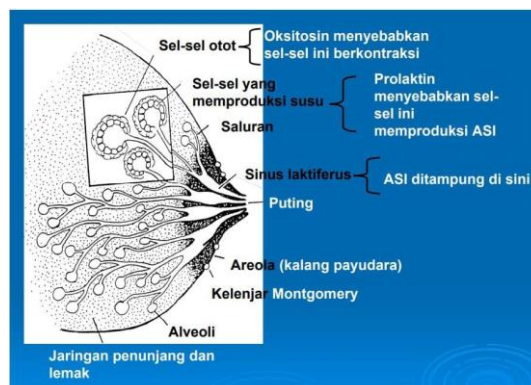
2. Persiapan Fisik dan Psikologis

a. Persiapan Fisik

1) Anatomi Payudara

Struktur anatomi payudara berperan penting dalam produksi dan aliran ASI. Bagian utama payudara yang mempengaruhi penyusuan meliputi:

- Kelenjar Alveolus: Bertanggung jawab dalam produksi ASI yang distimulasi oleh hormon prolaktin.
- Duktus Laktiferus: Saluran yang membawa ASI dari alveolus ke puting.
- Sinus Laktiferus: Tempat penampungan ASI sementara sebelum dikeluarkan melalui puting saat bayi menyusui.
- Areola dan Puting Susu: Membantu bayi dalam melakukan pelekatan yang baik untuk menyusui secara efektif.
- Kelenjar Montgomeri: Berfungsi untuk mengeluarkan zat pelumas yang menjaga kelembaban dan kebersihan puting serta memiliki aroma khas yang membantu bayi dalam menemukan puting saat menyusui.
- Jaringan Lemak dan Ligamen Cooper: Memberikan dukungan struktur dan bentuk payudara.

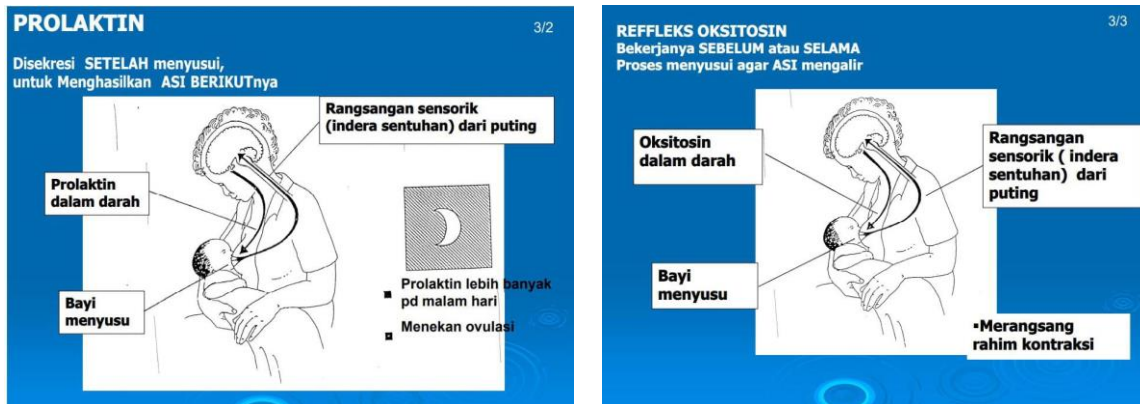


Gambar 5.5 Anatomi Payudara

Maka secara teoritis, ukuran payudara, baik besar maupun kecil, tidak mempengaruhi kemampuan ibu dalam menyusui. Perbedaan ukuran payudara hanya ditentukan oleh jumlah jaringan lemak, sedangkan jumlah kelenjar alveolus yang berperan dalam produksi ASI umumnya sama. Oleh

karena itu, semua ibu, terlepas dari ukuran payudara mereka, dapat menyusui dengan baik selama terdapat stimulasi yang cukup dan dukungan yang memadai.

2) Let-Down Refleks



Gambar 5.6 Let Down Reflex

Let down Reflex adalah mekanisme fisiologis yang memungkinkan ASI mengalir dari kelenjar alveolus ke puting susu sehingga dapat dihisap oleh bayi. Proses ini dikendalikan oleh dua hormon utama, yaitu prolaktin dan oksitosin.

a) Refleks Prolaktin (*Prolactin Reflex*)

Refleks prolaktin bertanggung jawab atas produksi ASI. Prosesnya sebagai berikut "

- (1) Saat bayi mengisap puting susu, reseptor saraf di puting dan areola terstimulasi.
- (2) Stimulasi ini mengirim sinyal ke hipotalamus di otak.
- (3) Hipotalamus kemudian memberi perintah kepada kelenjar hipofisis anterior untuk melepaskan hormon prolaktin ke dalam aliran darah.
- (4) Prolaktin merangsang sel alveolus di kelenjar payudara untuk memproduksi ASI.
- (5) Produksi prolaktin lebih tinggi saat malam hari, sehingga menyusui di malam hari membantu mempertahankan produksi ASI.

b) Refleks Oksitosin (*Oxytocin Reflex*)

Refleks oksitosin bertanggung jawab atas pengeluaran ASI yang telah diproduksi oleh kelenjar alveolus. Prosesnya:

- (1) Saat bayi mengisap payudara, rangsangan sensorik dari puting dikirim ke hipotalamus.
- (2) Hipotalamus mengaktifkan kelenjar hipofisis posterior untuk melepaskan hormon oksitosin ke dalam aliran darah.
- (3) Oksitosin menyebabkan kontraksi sel mioepitel di sekitar alveolus, sehingga ASI terdorong melalui duktus laktiferus menuju puting.

(4) Hormon oksitosin juga bisa dipicu oleh suara bayi menangis atau kontak kulit dengan ibu

Faktor penunjang yang dapat mempengaruhi *let down reflex* adalah relaksasi, *skin to skin contact* dan hisapan bayi yang efektif. Sementara faktor yang dapat menghambat *let down reflex* adalah stress, kecemasan, kelelahan dan rasa sakit.

Dari penjelasan diatas maka terdapat beberapa cara untuk mempertahankan dan memperbanyak produksi ASI, yaitu :

(1) Menyusui bayi secara langsung, setiap kali bayi menunjukkan tanda lapar dapat merangsang let-down reflex dan meningkatkan produksi ASI. Selain hormone prolactin dan oksitosin, di dalam ASI juga mengandung zat inhibitor (penghambat) yaitu Dopamin sebagai Inhibitor Prolaktin, dimana dopamin adalah neurotransmitter yang berperan menghambat sekresi prolaktin dari kelenjar pituitari. Prolaktin, pada gilirannya, merangsang produksi ASI. Ketika payudara tidak disusui atau tidak dipompa dalam waktu yang lama, hal ini dapat mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa kebutuhan ASI telah tercukupi, yang kemudian merangsang peningkatan kadar dopamin. Dopamin ini akan menghambat sekresi prolaktin, sehingga produksi ASI akan menurun.

(2) Pemijatan lembut pada payudara merangsang ujung saraf di sekitar payudara dan puting susu, yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak untuk melepaskan hormon oksitosin. Hormon ini memicu kontraksi otot-otot di sekitar saluran ASI, sehingga ASI dapat keluar dengan lebih lancar. Selain itu Pemijatan membantu meningkatkan sirkulasi darah ke payudara, yang mendukung kesehatan jaringan payudara dan memfasilitasi aliran ASI dari kelenjar susu ke saluran-saluran susu. Aliran darah yang baik juga memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang optimal untuk produksi ASI. Pemijatan yang dilakukan dengan teknik yang tepat dapat membantu melepaskan saluran susu yang tersumbat. Sumbatan pada saluran susu dapat mengurangi aliran ASI, dan pemijatan lembut dapat membantu melancarkan saluran susu tersebut.

3) Teknik Menyusui: Posisi dan Perlekatan

a) Posisi (sikap tubuh bayi terhadap tubuh ibu)

Posisi menyusui merujuk pada cara bayi diletakkan di tubuh ibu saat menyusui. Posisi yang benar memastikan kenyamanan ibu dan bayi, serta mendukung kelancaran ASI.

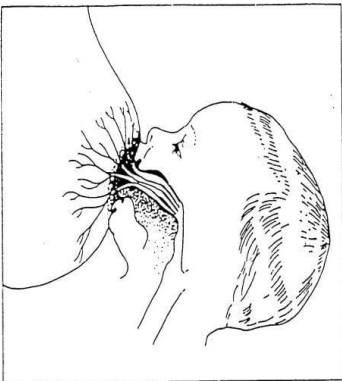
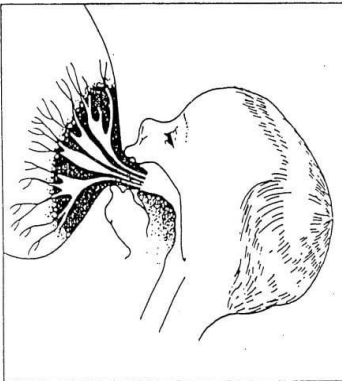
Berbagai posisi menyusui yang telah banyak diajarkan kepada ibu menyusui, dengan prinsip utama bahwa telinga, lengan, dan kaki bayi berada dalam satu garis lurus. Posisi bayi harus menghadap ibu, dengan ciri-ciri wajah bayi menghadap langsung ke payudara ibu dan perut bayi menempel pada perut ibu.

b) Perlekatan (Mulut bayi terhadap Areola Ibu)

Perlekatan yang benar adalah saat mulut bayi terbuka lebar dan mengambil sebagian besar areola (bukan hanya puting susu) ke dalam mulutnya. Perlekatan yang baik penting untuk memastikan bayi mendapatkan ASI dengan efisien dan mencegah rasa sakit yang dirasakan ibu akibat proses penyusuan. Berikut adalah ciri-ciri perlekatan yang benar:

- A** : **Areola** (Sebagian besar areola, terutama bagian bawah, masuk ke dalam mulut bayi).
- Mu** : **Mulut bayi terbuka lebar** (Pastikan mulut bayi terbuka lebar, sehingga tidak melukai puting)
- Bi** : **Bibir** (bibir bayi terbalik ke luar, bukan terlipat ke dalam. Bibir yang terbalik keluar memastikan perlekatan yang tepat).
- Da** : **Dagu** (dagu bayi menempel dengan erat pada payudara ibu).

Tabel 5.2 Perlekatan

Perlekatan Benar	Perlekatan Salah
	

b. Persiapan Psikologis

1) Mendukung Kepercayaan diri ibu dalam menyusui

Menyusui bisa menjadi tantangan awal bagi ibu, terutama bagi ibu baru. Kepercayaan diri yang tinggi sangat penting untuk memberikan ASI secara efektif dan mengurangi rasa cemas atau ragu. Berikut beberapa cara untuk mendukung kepercayaan diri ibu dalam menyusui:

- a) Pendidikan dan Informasi: Memberikan informasi yang benar tentang proses menyusui dan manfaat ASI akan membuat ibu merasa lebih siap dan percaya diri.

- b) Dukungan dari Pasangan dan Keluarga: Dukungan dari pasangan dan keluarga sangat penting dalam memberikan motivasi bagi ibu untuk terus menyusui.
- c) Pengalaman Positif: Membantu ibu berbagi pengalaman positif dari ibu lain yang berhasil menyusui bisa meningkatkan rasa percaya diri ibu.
- d) Penyuluhan dan Konseling Laktasi: Jika ibu mengalami kesulitan dalam menyusui, konseling dengan konselor laktasi dapat membantu memperbaiki perlekatan dan memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

2) Mengelola Stress dan Kecemasan

Menyusui dapat memberikan beban emosional dan fisik, terutama bagi ibu yang baru pertama kali melahirkan. Salah satu hormon yang berperan dalam proses menyusui adalah hormon oksitosin, yang tidak dapat diproduksi dengan **optimal** jika ibu merasa tidak bahagia atau stres. Oleh karena itu, mengelola stres dan kecemasan sangat penting agar ibu dapat menyusui dengan tenang dan nyaman. Beberapa cara untuk mengelola stres dan kecemasan adalah:

- a) Relaksasi dan Teknik Pernafasan: Mengajarkan teknik pernapasan dalam atau meditasi bisa membantu ibu untuk merasa lebih tenang dan mengurangi kecemasan. termasuk pijat oksitosin, yang dapat membantu merangsang produksi hormon oksitosin, serta teknik pernapasan dalam yang menenangkan.
- b) Ciptakan Lingkungan yang Nyaman: Menyusui di tempat yang nyaman, tenang, dan bebas gangguan dapat membantu ibu merasa lebih santai.
- c) Manajemen Waktu: Membantu ibu untuk mengatur waktu sehingga dia tidak merasa terburu-buru atau tertekan selama menyusui, seperti menyiapkan waktu khusus untuk menyusui.
- d) Dukungan Emosional: Mendengarkan keluhan dan memberikan dukungan emosional sangat penting untuk mengurangi perasaan cemas dan takut pada ibu.

3) Membangun Ikatan Emosional yang kuat melalui *skin to skin contact*

Skin-to-skin contact atau kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik bayi, tetapi juga penting dalam membangun ikatan emosional yang kuat. Kontak fisik ini mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis bayi serta memberikan kenyamanan kepada ibu. Beberapa manfaat dan cara untuk membangun ikatan emosional melalui *skin-to-skin contact* adalah:

- a) Meningkatkan Keterikatan Emosional: Kontak langsung kulit ibu dan bayi membantu menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Bayi merasakan kenyamanan dan keamanan di dekat ibu, yang dapat memperkuat ikatan emosional.
- b) Meningkatkan Produksi Hormon Oksitosin: Oksitosin adalah hormon yang mendukung perlekatan dan produksi ASI. *Skin-to-skin contact* membantu ibu merasa lebih rileks dan memperlancar produksi ASI.
- c) Mempercepat Proses Menyusui: Dengan membangun ikatan emosional melalui *skin-to-skin*, bayi lebih cepat belajar mencari dan menyusui dengan benar. Ini juga membantu ibu merasa lebih nyaman selama proses menyusui.
- d) Meningkatkan Rasa Percaya Diri Ibu: Ketika ibu merasakan kedekatan emosional dengan bayinya, ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dalam menyusui dan memberikan ASI.

3. Dukungan Lingkungan

Ibu menyusui dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan, baik yang dekat maupun yang lebih luas. Hal ini menjelaskan bahwa dukungan sosial berperan penting dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional individu. Untuk ibu menyusui, dukungan sosial dari keluarga, teman, tenaga medis, dan kelompok sebaya sangat memengaruhi keberhasilan menyusui.

C. Tantangan dalam Penyusuan ASI

1. Kurangnya Dukungan Keluarga : Dukungan keluarga, terutama dari pasangan dan orang tua, sangat penting dalam proses menyusui. Ketika ibu merasa kurang didukung oleh anggota keluarga, ini bisa menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat keberhasilan menyusui.
2. Mitos tentang ASI
Mitos atau informasi yang salah tentang ASI sering kali menjadi hambatan dalam proses menyusui. Beberapa mitos umum yang dapat mengganggu ibu menyusui adalah:
 - a. ASI tidak cukup untuk bayi: Banyak ibu yang merasa khawatir bahwa ASI mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, padahal ASI biasanya sudah cukup jika ibu menyusui secara teratur dan dengan teknik yang benar.
 - b. Bayi harus diberi air tambahan: Mitos bahwa bayi perlu diberi air tambahan atau susu formula meskipun ibu menyusui secara eksklusif dapat mengganggu proses menyusui. Padahal, ASI sudah mengandung cukup cairan untuk bayi, terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan.

- c. Menyusui menyebabkan payudara kendur: Banyak ibu khawatir bahwa menyusui akan merusak bentuk payudara mereka, padahal perawatan payudara yang baik dan teknik menyusui yang benar lebih berpengaruh pada kesehatan payudara.
3. Kembali Bekerja: Bagi ibu yang bekerja, kembali ke tempat kerja setelah melahirkan bisa menjadi tantangan besar dalam mempertahankan pemberian ASI eksklusif. Beberapa tantangan yang dihadapi ibu yang bekerja dalam hal menyusui antara lain keterbatasan waktu, kurangnya fasilitas menyusui, kekhawatiran tentang produksi ASI, dll.

D. Solusi dan Strategi Mengatasi Tantangan

1. Edukasi dan Konseling Laktasi

Edukasi dan konseling laktasi adalah intervensi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi ibu dalam proses menyusui. Banyak ibu, terutama yang baru pertama kali melahirkan, mengalami kesulitan dalam memahami cara menyusui yang benar, mengatasi masalah yang mungkin timbul, serta mengenali tanda-tanda bayi yang tidak mendapatkan ASI dengan baik. Konseling laktasi memberikan dukungan profesional dalam bentuk informasi, teknik, dan cara mengatasi masalah laktasi. Strategi yang dapat digunakan dalam konseling Pra dan Pasca Kelahiran dan meminta bantuan konselor laktasi yang terlatih.

2. Dukungan Sosial

Dukungan sosial yang kuat, baik dari keluarga, teman, maupun masyarakat sekitar, merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemberian ASI. Ibu yang merasa didukung oleh orang-orang terdekat cenderung lebih sukses dalam melanjutkan pemberian ASI eksklusif. Dukungan ini bisa berupa bantuan praktis, emosional, atau informasi yang relevan mengenai laktasi. Strategi yang dapat digunakan adalah program pemberdayaan pasangan/suami, bergabung dengan kelompok pendukung ASI, serta program penyuluhan bagi sasaran sekunder (keluarga) dan tersier (lingkungan).

3. Manajemen Waktu bagi ibu bekerja

Bagi ibu yang kembali bekerja setelah melahirkan, tantangan terbesar dalam mempertahankan pemberian ASI adalah manajemen waktu. Mengingat jadwal kerja yang padat, ibu perlu mengatur waktu secara efisien untuk menyusui bayi, memompa ASI, dan bekerja. Memiliki strategi yang baik dalam pengelolaan waktu dapat membantu ibu menyusui dengan lebih lancar tanpa mengganggu kewajiban pekerjaan. Strategi yang dapat digunakan adalah memompa ASI secara teratur, menggunakan waktu istirahat dengan efektif, menggunakan waktu

di malam hari atau saat ibu dirumah untuk menyusui secara langsung (*breastfeed*), dan melakukan persiapan pemberian ASI perah saat ibu sedang bekerja.

E. Kesimpulan

Menyusui adalah proses alami yang memberikan manfaat besar bagi ibu dan bayi. Dengan persiapan yang matang, dukungan yang memadai, serta pengetahuan yang cukup, ibu dapat menjalani proses menyusui dengan lebih percaya diri dan nyaman.

F. Referensi

- GINANJAR, A. (2020). Panduan Lengkap Menyusui: Manfaat, Teknik, dan Tantangan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- KEMENTERIAN KESEHATAN RI. (2022). Laporan Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- LAWRENCE, R. A., & LAWRENCE, R. M. (2020). Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession. 9th Edition. St. Louis: Elsevier.
- WHO. (2014). Modul Konseling Laktasi 40 Jam. World Health Organization.
- ROESLI, U. (2019). Mitos dan Fakta ASI: Panduan Menyusui yang Benar. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- WHO. (2021). Infant and Young Child Feeding. Retrieved from <https://www.who.int>

G. Glosarium

ASI	: Air Susu Ibu
<i>Breastfeed</i>	: Menyusui langsung dari payudara ibu
<i>Skin to Skin</i>	: perlekatan kulit bayi ke kulit ibu secara langsung

CHAPTER 6

PERSIAPAN MENTAL EMOSIONAL MENJELANG PERSALINAN

Maesaroh, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan merupakan salah satu tahap penting bagi seorang wanita yang tidak jarang menimbulkan kecemasan. Pada periode kehamilan akan terjadi berbagai perubahan fisik dan psikologis dalam tubuh seorang wanita. Perubahan fisiologis dalam kehamilan diantaranya perubahan sistem endokrin, sistem reproduksi, kardiovaskuler, sistem pencernaan dan lainnya. Selain itu, juga terjadi perubahan emosional yang kompleks. Perubahan emosi terutama adanya cemas yang berupa tegang, khawatir, sedih, gugup, takut menjadi persoalan mendasar. Keluhan psikis ini dapat ibu hamil alami sejak kehamilan trimester I sampai dengan trimester III. Perubahan psikologis pada ibu hamil trimester III terkesan lebih kompleks dan meningkat kembali dibandingkan trimester sebelumnya bahkan perasaan cemas dan ketakutan mulai muncul menjelang persalinan, sehingga diperlukan persiapan mental emosional menjelang proses persalinan.

Persalinan merupakan suatu proses fisiologis yang dialami oleh seorang ibu, dan kelahiran bayi merupakan proses yang sangat dinantikan oleh pasangan suami istri. Pada umumnya, ibu hamil mengharapkan persalinan yang normal, aman dan nyaman dengan rasa nyeri minimal. Namun, ibu primipara seringkali merasakan nyeri lebih hebat daripada multipara. Hal ini disebabkan primipara membutuhkan peregangkan serviks yang lebih kuat dibandingkan multipara (Salsabila & Nurchasanah, 2022).

Nyeri yang berhubungan dengan persalinan telah menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi ibu hamil, rasa nyeri ini digambarkan sebagai salah satu bentuk rasa sakit yang paling intens serta alami meskipun demikian beberapa wanita dapat juga tidak mengalami nyeri hebat selama persalinan. Ketakutan dan kecemasan dapat menyebabkan ketegangan otot dan peningkatan persepsi nyeri (Ahmar et al., 2021).

Bidan dapat berkontribusi yang membantu perkembangan profesi bidan dan menjadi pembaharu dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya adalah dengan memberikan edukasi terkait pengelolaan mental emosional ibu dalam menghadapi persalinan.

B. Konsep Dasar Kecemasan

1. Pengertian Kecemasan

Kecemasan atau disebut pula ansietas adalah suatu kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosional ini tidak memiliki obyek yang spesifik. Ansietas dialami secara subyektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Ansietas berbeda dengan takut, yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya (Stuart, 2015).

Pieter (2010) mendefinisikan bahwa perasaan cemas akan selalu menampakkan diri dalam berbagai bentuk intensitas, karena kecemasan merupakan sikap dasariah bagi setiap manusia dalam menghadapi setiap bahaya yang mengancam keseluruhan manusia sebagai pribadi dalam eksistensinya (Tamala, 2020).

Kecemasan (anxiety) dapat juga diartikan suatu kondisi takut, khawatir, dan emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang, dan merupakan pengalaman samar yang disertai dengan perasaan tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas (Tamala, 2020).

2. Faktor Penyebab Cemas

Menurut Stuart (2015) dalam Ningrum (2023) faktor yang dapat mengakibatkan rasa cemas dapat berasal dari sumber internal atau eksternal.

a. Faktor Eksternal

- 1) Ancaman pada integritas diri seseorang meliputi ketidakmampuan fisiologis yang akan terjadi atau menurunkan kapasitas untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Pada ancaman ini, stressor yang berasal dari sumber eksternal adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan fisik. Sedangkan yang menjadi sumber internalnya adalah kegagalan mekanisme fisiologis tubuh.
- 2) Ancaman terhadap sistem diri seseorang dapat membahayakan identitas, harga diri dan fungsi sosial yang terintegrasi seseorang. Ancaman yang berasal dari sumber eksternal yaitu kehilangan orang yang berarti dan ancaman yang berasal dari sumber internal berupa gangguan hubungan interpersonal di rumah, tempat kerja, atau menerima peran baru.

b. Faktor Internal

1) Usia

Usia berkaitan erat dengan tingkat perkembangan individu, semakin dewasa usia individu akan lebih mudah dalam mengendalikan kecemasan dan stress

2) Jenis kelamin

Gangguan psikis dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, namun laki-laki memiliki kemampuan dan ketahanan dalam menghadapi kecemasan, perempuan lebih cenderung mudah mengalami gangguan kecemasan.

3) Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan berperan penting dalam membantu individu mempersepsikan suatu hal, sehingga dapat lebih mengendalikan rasa cemas yang dialami.

4) Tipe Kepribadian

Seseorang dengan tipe kepribadian tidak sabar, ambisius, kompetitif dan ingin serba sempurna lebih mudah mengalami gangguan kecemasan daripada seseorang dengan tipe kepribadian yang sabar, tenang, dan bisa menerima keadaan

5) Lingkungan dan Situasi

Lingkungan dan situasi sekitar sangat berpengaruh terhadap kecemasan seseorang. Seseorang yang berada pada lingkungan yang asing bagi dirinya akan lebih mudah mengalami kecemasan dibandingkan dengan bertempat tinggal di lingkungan yang biasa ditempati (Ningrum, 2023).

Menurut Kaplan & Sadok (2010) dalam Ningrum (2023) faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu:

a. Faktor Intrinsik

1) Usia

Kecemasan dapat terjadi pada semua usia, namun kecemasan lebih sering terjadi pada usia dewasa dan lebih banyak pada wanita. Kecemasan sebagian besar terjadi pada usia 21-45 tahun.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan bagian penting dan sangat menentukan kondisi mental individu dikemudian hari. Sebagai contoh ibu hamil primigravida akan lebih mengalami cemas dibandingkan dengan ibu hamil multigravida.

3) Konsep Diri dan Peran

Konsep diri merupakan semua ide, kepercayaan, pikiran dan pendirian yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berhubungan dengan orang lain.

b. Faktor Ekstrinsik

1) Kondisi Medis

Kecemasan dapat terjadi karena adanya kondisi medis yang terjadi, meskipun insidensi gangguan kecemasannya dapat bervariasi. Contohnya seorang ibu hamil yang harus menjalani operasi section caesarea karena kondisi kesehatannya akan lebih tinggi tingkat kecemasannya dibandingkan dengan ibu hamil dengan diagnose kehamilan normal.

2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan berguna untuk merubah pola pikir, tingkah laku, dan sangat berperan dalam mengambil keputusan. Tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah dalam mengidentifikasi stressor yang muncul dari dalam ataupun luar dirinya. Tingkat pendidikan juga akan berpengaruh terhadap kesadaran dan pemahaman terhadap stimulus.

3) Akses Informasi

Akses informasi dapat mempengaruhi pola pikir, penataan hati, kesiapan diri, sehingga dapat mengelola kecemasan dalam diri seseorang. Saat ini begitu mudahnya seseorang mendapatkan informasi melalui berbagai media social, sehingga ini dapat dimanfaatkan oleh seseorang dalam mencari informasi yang dibutuhkan terhadap permasalahan atau sesuatu yang sedang mengganggu pikirannya.

4) Proses Adaptasi

Setiap orang harus bisa beradaptasi agar bisa survive dalam menjalani kehidupannya. Proses adaptasi berperan dalam menstimulasi individu untuk mendapat bantuan dari lingkungan disekitarnya

5) Tingkat Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap psikis seseorang. Kondisi ekonomi yang lemah akan menyebabkan rasa cemas terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan. Terutama pada seorang ibu hamil, disamping memikirkan kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tentu akan berdampak juga pada proses kehamilannya terutama dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan diri dan janin yang dikandungnya.

6) Komunikasi Terapeutik

Komunikasi sangat dibutuhkan baik bagi tenaga kesehatan maupun ibu hamil. Terlebih ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi yang lebih rentan mengalami kecemasan. Komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan ibu hamil akan dapat menentukan penanganan yang tepat sehingga menghindari terjadinya komplikasi bagi ibu maupun janinnya.

3. Tingkat Kecemasan

Menurut Stuart dalam Legawati & Riyanti (2020) ada 4 tingkatan kecemasan yaitu:

a. Kecemasan Ringan

Berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan area persepsinya. Kecemasan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan

pertumbuhan beraktivitas. Respon fisiologis ditandai dengan sekali nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, gejala ringan pada lambung, muka berkerut, bibir bergetar. Respon kognitif area persepsi luas, biasanya mampu menerima rangsangan yang kompleks, konsentrasi pada masalah, menyelesaikan masalah secara efektif. Respon perilaku dan emosi tergambar seperti tidak bisa duduk tenang, tremor halus, kadang-kadang suara meninggi.

b. Kecemasan Sedang

Memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Respon fisiologis ditandai dengan sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut kering, diare, gelisah. Respon kognitif area persepsi menyempit, rangsangan luar tidak mampu diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya. Respon perilaku dan emosi tergambar seperti meremas tangan, bicara banyak dan cepat, susah tidur dan perasaan tidak enak.

c. Kecemasan Berat

Sangat mengurangi area persepsi seseorang, seseorang cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik dan tidak dapat berfikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada sesuatu yang lain. Respon fisiologis ditandai dengan nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, berkeringat, ketegangan dan sakit kepala. Respon kognitif area persepsi sangat sempit, tidak mampu menyelesaikan masalah. Respon perilaku dan emosi perasaan ancaman meningkat.

d. Kecemasan Panik

Berhubungan dengan pengaruh teror dan ketakutan, pikiran terpecah. Karena mengalami kehilangan kendali orang yang mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu dengan pengarahan, panik melibatkan disorganisasi kepribadian. Bila panik terjadi peningkatkan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang dan kehilangan pemikiran rasional.

4. Gejala Klinis Cemas

Hawari dalam Tamala (2020). berpendapat bahwa, keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh orang yang mengalami gangguan kecemasan antara lain:

- a. Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikiranya sendiri, mudah tersinggung.
- b. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut.

- c. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang
- d. Gangguan pola tidur, mimpi yang menegangkan.
- e. Gangguan konsentrasi dan daya ingat.
- f. Keluhan-keluhan simatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdenging, berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala

C. Mengelola Kecemasan serta Mempersiapkan Mental Menghadapi Persalinan

Kecemasan pada kehamilan merupakan reaksi emosional yang terjadi pada ibu hamil yang berkaitan dengan kekhawatiran ibu terhadap kesejahteraan diri dan janinnya, keberlangsungan kehamilan, persalinan, nifas, dan ketika menjalankan peran sebagai seorang ibu. Kecemasan ini umumnya disebabkan oleh perubahan kadar hormon di dalam tubuh. Perubahan kadar hormon saat hamil dapat berpengaruh pada kadar zat kimia di dalam otak yang berperan pada pengaturan perasaan. Hal inilah yang menyebabkan ibu hamil mudah cemas, gelisah dan khawatir (Ningrum, 2023).

Selain itu terdapat beberapa faktor resiko yang memicu kecemasan pada kehamilan diantaranya umur, pendidikan, paritas, pendapatan, hubungan ibu dengan keluarganya, dukungan suami, faktor reproduksi yang meliputi kehamilan yang tidak diinginkan/tidak direncanakan, pengalaman kehamilan dan persalinan sebelumnya, status kesehatan ibu (Legawati & Riyanti, 2020).

Tingkat kecemasan wanita selama bersalin akan meningkat jika ia tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya atau yang disampaikan kepadanya. Wanita bersalin biasanya akan mengutarakan kekhawatirannya jika ditanya. Perilaku dan penampilan wanita serta pasangannya merupakan petunjuk berharga tentang jenis dukungan yang akan diperlukannya. Perilaku dalam hal membantu akan memenuhi harapan wanita akan hasil akhir persalinannya, membantu wanita menghemat tenaga, mengendalikan rasa nyeri merupakan suatu upaya dukungan dalam mengurangi kecemasan pasien. Dukungan psikologis dari orang-orang terdekat akan membantu memperlancar proses persalinan yang sedang berlangsung. Tindakan mengupayakan rasa nyaman dengan menciptakan suasana yang nyaman dalam kamar bersalin, memberi sentuhan, memberi penenangan nyeri non farmakologi, memberi analgesia jika diperlukan dan yang paling penting berada di sisi pasien adalah bentuk-bentuk dukungan psikologis. Dengan kondisi psikologis yang positif proses persalinan akan berjalan lebih mudah.

Dampak kecemasan yang dialami oleh ibu saat persalinan yaitu ibu akan menjadi lebih lelah, kehilangan kekuatan sehingga dapat mengganggu proses persalinan yang bisa mengakibatkan salah satunya Kala I lama ataupun Kala II lama.

Seorang ibu hamil yang mengetahui apa yang akan terjadi pada waktu persalinan akan lebih kooperatif dan merasakan nyeri yang lebih ringan. Hal ini dapat dilakukan pada saat Ante Natal Care (ANC), serta didukung dengan pemberian gizi seimbang, senam hamil, imunisasi, merencanakan tempat persalinan, penolong persalinan, persiapan perlengkapan bayi dan ibu agar persalinan dapat berjalan lancar (Weisberg dan Paquette, dalam Tamala, 2020).

Penanganan yang dapat dilakukan pada ibu hamil yang mengalami kecemasan dalam kehamilan diantaranya adalah dengan melakukan *strategi coping* (Lestari et al., 2024). Strategi *coping* didefinisikan secara terperinci sebagai bentuk usaha kognitif atau perilaku seseorang untuk mengatur tuntutan internal dan eksternal yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan. Strategi *Coping* yang dilakukan ibu hamil dapat dilakukan melalui dua faktor yaitu faktor dari dalam diri sendiri dan faktor dari luar diri. Faktor dari dalam diri dapat dilakukan seperti latihan relaksasi napas, *self healing*, istirahat yang cukup serta tidak lupa rutin kontrol kehamilannya. Sedangkan faktor dari luar yaitu berupa dukungan sosial, jika ibu hamil disertai dengan kesadaran bahwa bayinya itu didambakan oleh dirinya maupun suaminya maka akan disambut dengan gembira, demikian pula dengan lingkungan keluarga yang memberi dukungan tentu akan memberikan perasaan bahagia pada seorang ibu hamil (Lestari et al., 2024).

1. Pengertian Strategi *Coping*

Strategi *coping* adalah tingkah laku dalam menghadapi masalah atau tekanan. Chaplin dalam Melba (2023) mengartikan perilaku *coping* sebagai suatu tingkah laku dimana seseorang melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan menyelesaikan tugas atau masalah. Tingkah laku *coping* merupakan suatu proses dinamis dari suatu pola tingkah laku mampu pikiran-pikiran yang secara sadar digunakan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan dalam situasi yang menekan dan menegangkan.

Folkman dalam Melba (2023) mendefinisikan strategi *coping* sebagai bentuk usaha kognitif dan perilaku yang dilakukan seseorang untuk mengatur tuntutan internal dan eksternal yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan, yang dianggap mengganggu batas-batas yang dimiliki oleh individu tersebut. *Coping* yang dimaksud terdiri dari pikiran-pikiran khusus dan perilaku yang digunakan individu untuk mengatur tuntutan dan tekanan yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan, khususnya yang berhubungan dengan kesejahteraan.

2. Jenis-Jenis Strategi *Coping*

a. *Problem focused coping*

Merupakan bentuk *coping* yang lebih diarahkan kepada upaya untuk mengurangi tuntutan dari situasi yang penuh tekanan, artinya *coping* yang muncul terfokus pada masalah individu yang akan mengatasi stres dengan mempelajari cara-cara keterampilan yang baru. Individu cenderung menggunakan strategi ini ketika mereka percaya bahwa tuntutan dari situasi dapat diubah (Yulianti, dalam Lestari et al., 2024).

b. *Emotion focused coping*

Merupakan bentuk *coping* yang diarahkan untuk mengatur respon emosional terhadap situasi yang menekan. Individu dapat mengatur respon emosionalnya dengan pendekatan behavioral dan kognitif. Contoh dari pendekatan behavioral adalah penggunaan alkohol, narkoba, mencari dukungan emosional dari teman-teman dan mengikuti berbagai aktivitas seperti berolahraga atau menonton televisi yang dapat mengalihkan perhatian individu dari masalahnya (Rofiqoch et al., 2022 dalam Lestari et al., 2024). Sementara pendekatan kognitif melibatkan bagaimana individu berfikir tentang situasi yang menekan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi *Coping*

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi *coping* antara lain:

a. Kesehatan Fisik

Status kesehatan menjadi hal penting selama dalam usaha individu mengatasi kecemasan, karena dalam menangani kecemasan maupun stress akan membutuhkan tenaga yang cukup besar.

b. Keyakinan atau pandangan positif

Keyakinan dalam hal ini berhubungan dengan karakter kepribadian dan harapan umum individu tentang apa yang akan dicapai

c. Keterampilan memecahkan masalah

Keterampilan ini berkaitan erat dengan kemampuan individu dalam menganalisis masalah sehingga dapat dipecahkan yang meliputi keterampilan mencari informasi, mengidentifikasi masalah dan menganalisa situasi.

d. Keterampilan social

Keterampilan ini berkaitan dengan bagaimana cara individu membangun hubungan dengan orang lain serta mematuhi norma dan peraturan yang ada di masyarakat.

e. Dukungan sosial

Dukungan sosial disini sebagai pemenuhan emosional dan informasi dari orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat dan saudara.

f. Materi

Berkaitan dengan keuangan, karena barang-barang penunjang atau layanan sekarang ini dapat dibeli.

g. Perkembangan usia

Sejumlah struktur psikologis seseorang dan sumber-sumber untuk melakukan *coping* akan berubah menurut perkembangan usianya sehingga terjadi pula perbedaan dalam merespon tekanan yang dihadapi.

h. Tingkat Pendidikan

Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pola pikir untuk berani mengambil resiko dan sikap dalam mengatasi masalah.

i. Jenis Kelamin

Dalam melakukan *coping* perempuan cenderung untuk mencari dukungan social dan berorientasi pada emosi dibandingkan dengan laki-laki yang lebih berorientasi pada tugas dalam mengatasi masalah (Melba, 2023).

Salah satu upaya ibu hamil dalam menghadapi kecemasan menjelang persalinan adalah dengan melakukan strategi coping salah satunya dengan melakukan latihan relaksasi napas dalam.

D. Teknik Relaksasi Nafas Dalam

1. Pengertian Relaksasi Napas Dalam

Smeltzer & Bare (2002) dalam Handayani et al., (2021) mendefinisikan relaksasi nafas dalam merupakan teknik relaksasi yang berfokus pada pernafasan guna meningkatkan proses keluar masuknya udara di paru-paru dan oksigenasi darah. Relaksasi pernafasan adalah pernapasan abdomen dengan frekuensi lambat atau perlahan, berirama, dan nyaman yang dilakukan dengan memejamkan mata (Argaheni et al., 2023).

Relaksasi nafas adalah pernapasan abdomen dengan frekuensi lambat atau perlahan, berirama, dan nyaman yang dilakukan dengan memejamkan mata. Latihan pernafasan dan teknik relaksasi menurunkan konsumsi oksigen, frekuensi pernafasan, frekuensi jantung, dan ketegangan otot, yang menghentikan siklus nyeri-ansietas-ketegangan otot. Relaksasi merupakan metode efektif untuk menurunkan sensasi emosional yang tidak menyenangkan (Faisol, 2022).

2. Tujuan dan Manfaat Relaksasi Napas Dalam

Tujuan melakukan teknik relaksasi pernapasan dalam untuk mencapai aliran udara yang lebih baik, mengurangi kerja pernapasan, meningkatkan inflasi alveolus secara maksimal, merelaksan otot, dan memperbaiki system

pernapasan agar bekerja lebih maksimal (Brunner & Suddart dalam Handayani et al., 2021).

Menurut Priharjo (2003) dalam Handayani et al., (2021) teknik relaksasi dalam mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan ketenangan pikiran.
- b. Mengurangi kecemasan, kekhawatiran dan kegelisahan.
- c. Menurunkan detak jantung.
- d. Menurunkan tekanan darah.
- e. Meningkatkan rasa percaya diri.
- f. Meningkatkan kesehatan mental individu.

Melakukan relaksasi dapat memberikan keuntungan secara emosional dan psikologis ketika stress terjadi;

- a. Keuntungan emosional
 - 1) Memberikan pengalaman positif tentang melahirkan pada ibu
 - 2) Mengurangi ketegangan dan ketakutan ibu pada saat persalinan
 - 3) Berpartisipasi nyata dalam melahirkan anaknya
 - 4) Membantu tumbuhnya hubungan antara orang tua dan anak
 - 5) Membantu tumbuhnya hubungan antara ibu dan bapak
- b. Keuntungan fisiologis
 - 1) Dapat mengurangi rasa sakit tanpa menggunakan obat-obatan dan dapat mengurangi risiko terhadap bayi
 - 2) Mencegah terjadinya komplikasi seperti nyeri sampai dengan menurunnya oksigen
 - 3) Ibu dapat bekerjasama pada saat pemeriksaan
 - 4) Ibu tidak merasa lelah pada saat dan sesudah melahirkan (Faisol, 2022).

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Teknik Relaksasi

Menurut Smeltzer dan Bare (2002) dalam Jannatiah, (2020), teknik relaksasi napas dalam dipercaya dapat menurunkan intensitas nyeri sehingga secara langsung juga dapat menurunkan tingkat kecemasan ibu menjelang persalinan melalui mekanisme:

- a. Dengan merelaksasikan otot-otot skelet yang mengalami spasme yang disebabkan oleh peningkatan prostaglandin sehingga terjadi vasodilatasi pembuluh darah dan akan meningkatkan aliran darah ke daerah yang mengalami spasme dan iskemik.
- b. Teknik relaksasi napas dalam dipercayai mampu merangsang tubuh untuk melepaskan opioid endogen yaitu endorphen dan enkefalin.
- c. Mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat. Teknik relaksasi napas dalam merupakan cara yang paling mudah dilakukan dalam mengontrol emosi serta

mengurangi nyeri. Relaksasi melibatkan sistem otot dan respirasi dan tidak membutuhkan alat lain sehingga mudah dilakukan kapan saja atau sewaktu-waktu.

4. Patofisiologi Teknik Relaksasi Napas Dalam

Menurut Brunner & Suddarth (2002) dalam Jannatiah, (2020), teknik relaksasi napas dalam dapat meminimalkan aktivitas simpatik dalam sistem saraf otonom sehingga mengurangi kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan. Relaksasi melibatkan otot dan respirasi dan tidak membutuhkan alat lain sehingga mudah dilakukan kapan saja atau sewaktu-waktu.

Prinsip yang mendasari penurunan oleh teknik relaksasi terletak pada fisiologi sistem saraf otonom yang merupakan bagian dari sistem saraf perifer yang mempertahankan homeostatis lingkungan internal individu. Pada saat terjadi pelepasan mediator kimia seperti bradikinin, prostaglandin dan substansi yang akan merangsang saraf simpatis sehingga menyebabkan saraf simpatis mengalami vasokonstriksi yang akhirnya meningkatkan tonus otot yang menimbulkan berbagai efek spasme otot yang akhirnya menekan pembuluh darah. Mengurangi aliran darah dan meningkatkan kecepatan metabolisme otot yang menimbulkan pengiriman impuls nyeri dari medulla spinalis ke otak dan dipersepsikan nyeri.

Menurut Rukmala, ketika seseorang melakukan relaksasi napas dalam maka tubuh akan meningkatkan komponen saraf parasimpatik secara stimulant yang menyebabkan penurunan kadar hormon kortisol dan adrenalin yang mempengaruhi tingkat stress seseorang hingga dapat meningkatkan konsentrasi dan membuat klien merasa tenang untuk mengatur ritme pernapasan menjadi teratur (Pratiwi et al., 2021).

5. Penatalaksanaan Teknik Relaksasi Napas Dalam

Ada beberapa posisi relaksasi napas dalam yang dapat dilakukan menurut Smeltzer & Bare (2002) dalam Utami & Fitriahadi (2019) yaitu :

a. Posisi relaksasi dengan terlentang

Letakkan kaki terpisah satu sama lain dengan jari-jari kaki agak meregang lurus kearah luar, letakkan pada lengan pada sisi tanpa menyentuh sisi tubuh, pertahankan kepala sejajar dengan tulang belakang dan gunakan bantal yang tipis dan kecil di bawah kepala.

b. Posisi relaksasi dengan berbaring miring

Berbaring miring, kedua lutut ditekuk, dibawah kepala diberi bantal dan dibawah perut sebaiknya diberi bantal juga, agar perut tidak menggantung.

c. Posisi relaksasi dalam keadaan berbaring terlentang

Kedua lutut ditekuk, berbaring terlentang, kedua lutut ditekuk, kedua lengan disamping telinga.

d. Posisi relaksasi dengan duduk

Duduk dengan seluruh punggung bersandar pada kursi, letakkan kaki datar pada lantai, letakkan kaki terpisah satu sama lain, gantungkan lengan pada sisi atau letakkan pada lengan kursi dan pertahankan kepala sejajar dengan tulang belakang.

6. Prosedur Teknik Relaksasi Napas Dalam

Hormon adrenalin dan kortisol yang menyebabkan stres akan menurun, ibu dapat meningkatkan konsentrasi dan merasa tenang sehingga memudahkan ibu untuk mengatur pernafasan sampai frekuensi pernafasan kurang dari 60-70x/menit. Kadar PaCO₂ akan meningkat dan menurunkan PH sehingga akan meningkatkan kadar oksigen dalam darah (Faisol, 2022).

Prosedur yang dapat dilakukan dalam melakukan teknik relaksasi napas dalam Menurut Priharjo (2003) dalam Handayani et al., (2021) langkah-langkah dalam melakukan teknik relaksasi napas dalam adalah :

- a. Buatlah lingkungan yang tenang dan nyaman mungkin.
- b. Kondisikan diri agar tetap santai dan tenang
- c. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung.
- d. Buang napas perlahan melalui mulut.
- e. Selanjutnya menarik nafas secara perlahan kemudian dihembuskan
- f. Anjurkan klien untuk merilekskan bagian telapak tangan dan kaki
- g. Menganjurkan klien untuk focus
- h. Kemudian klien diarahkan untuk benar-benar rileks dengan mengulangi prosedur tersebut
- i. Anjurkan klien untuk mengulangi sampai 15 menit, dan istirahat pendek bergantian setiap lima napas

Adapun menurut Wardani (2015) dalam Mulki et al., (2020) langkah-langkah teknik relaksasi napas dalam adalah sebagai berikut:

- a. Ciptakan lingkungan yang tenang'
- b. Usahakan tetap rileks dan tenang
- c. Menarik napas dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara melalui hitungan
- d. Perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut sambil merasakan ekstremitas atas dan bawah rileks
- e. Anjurkan bernapas dengan irama normal 3 kali
- f. Menarik napas lagi melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan

- g. Membiarkan telapak tangan dan kaki rileks
- h. Usahakan agar tetap konsentrasi
- i. Anjurkan untuk mengulangi prosedur hingga benar-benar rileks
- j. Ulangi selama 15 menit dan selingi istirahat singkat setiap 5 kali pernafasan

Tabel 6.1 Instruksi Hitungan Latihan Napas Dalam

Tahap	Instruksi Latihan Napas Dalam		
1	Tarik Napas	Tahan napas sampai hitungan ke 3	Hembuskan
2	Tarik Napas	Tahan napas sampai hitungan ke 5	Hembuskan
2	Tarik Napas	Tahan napas sampai hitungan ke 7	Hembuskan
4	Tarik Napas	Tahan napas sampai hitungan ke 10	Hembuskan

(Rejeki, 2020).

E. Kesimpulan

Kehamilan merupakan salah satu tahap penting bagi seorang wanita yang tidak jarang menimbulkan kecemasan. Perubahan psikologis pada ibu hamil trimester III menjadi lebih kompleks dan meningkat kembali dibandingkan trimester sebelumnya bahkan perasaan cemas dan ketakutan mulai muncul menjelang persalinan, sehingga diperlukan persiapan mental emosional menjelang proses persalinan. Kecemasan atau disebut pula ansietas adalah suatu kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Kecemasan pada kehamilan merupakan reaksi emosional yang terjadi pada ibu hamil yang berkaitan dengan kekhawatiran ibu terhadap kesejahteraan diri dan janinnya, keberlangsungan kehamilan, persalinan, nifas, dan ketika menjalankan peran sebagai seorang ibu. Kecemasan ini umumnya disebabkan oleh perubahan kadar hormon di dalam tubuh. Perubahan kadar hormon saat hamil dapat berpengaruh pada kadar zat kimia di dalam otak yang berperan pada pengaturan perasaan. Tingkat kecemasan wanita selama bersalin akan meningkat jika ia tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya atau yang disampaikan kepadanya. Penanganan yang dapat dilakukan pada ibu hamil yang mengalami kecemasan dalam kehamilan diantaranya adalah dengan melakukan *strategi coping*. Strategi *coping* didefinisikan secara terperinci sebagai bentuk usaha kognitif atau perilaku seseorang untuk mengatur tuntutan internal dan eksternal yang timbul dari hubungan individu dengan lingkungan. Strategi *Coping* yang dilakukan ibu hamil dapat dilakukan melalui dua faktor yaitu faktor dari dalam diri sendiri dan faktor dari luar diri. Faktor dari dalam diri dapat dilakukan seperti latihan relaksasi napas dalam, *self healing*, istirahat yang cukup serta tidak lupa rutin kontrol kehamilannya. Sedangkan faktor dari luar yaitu berupa dukungan sosial, baik dari suami, keluarga, maupun tenaga kesehatan.

F. Referensi

- Ahmar, H., Suryanti, Sharief, S. A., Azizah, N., Ningsih, D. andariya, Kartikasari, R., Silviani, Y. E., Puspitasari, I., & Rufaindah, E. (2021). *Manajemen Nyeri Persalinan Non Farmakologis*. Ahlimedia Press.
- Argaheni, N. B., Amir, N., Dewi, S. U., Sari, P. I. A., Harahap, Y. W., Rahmi, U., Sepang, L., Utami, R. A., Wuisang, M., Nasution, J. D., & Nasution, E. M. (2023). Terapi Komplementer pada Remaja. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Faisol. (2022). *Teknik Relaksasi Nafas Dalam*. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1054/teknik-relaksasi-nafas-dalam
- Handayani, R., Batubara, S., Dewi, R., & dkk. (2021). *Terapi Komplementer Dalam Kehamilan Mind and Body Therapy*. <https://docplayer.info/226255795-Terapi-komplementer-dalam-kehamilan-mind-and-body-therapy.html>
- Jannatiah, S. (2020). *Pengaruh Teknik Relaksasi Napas Dalam Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif di BPM Lismarini dan BPM Meli Rosita Kota Palembang Tahun 2020*. Politeknik Kesehatan Palembang.
- Legawati, & Riyanti. (2020). *Kecemasan dan Pendampingan Suami Terhadap Outcome Perinatal Pada Kehamilan Remaja*. CV. Wijaya Purnama Nusantara.
- Lestari, A. S., Pratiwi, D. I., Rudtitasari, A., Kurniati, P. T., Haryanti, Y., Amartani, R., & Chairunnisa, M. (2024). Hubungan Strategi Coping, Dukungan Keluarga dan Dukungan Bidan Terhadap Kecemasan Primigravida Menghadapi Persalinan di PMB Ambarwati Kabupaten Sintang. *Jurnal Medika Nusantara*, 2(1), 246–263.
- Melba, F. K. M. (2023). *Strategi Coping Ibu Hamil Dalam Menghadapi Kecemasan Menjelang Persalinan* [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35412>
- Mulki, M. M., Ta'adi, & Sunarjo, L. (2020). *Buku Panduan Efektivitas Teknik Relaksasi Nafas Dalam dan Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Ope* (1st ed.). Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemknk.eu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Ningrum, N. M. (2023). *Self Healing Dalam Menurunkan Kecemasan Pada Kehamilan* (Y. S. Rosyad (ed.)). Pustaka Panasea.
- Pratiwi, D., Hadi, S. P. I., Sari, N., & Okinarum, G. Y. (2021). Asuhan Kebidanan

- Komplomenten Dalam Mengatasi Nyeri Persalinan. In *Pustaka Aksara* (p. 53).
- Rejeki, S. (2020). *Buku Ajar Manajemen Nyeri Dalam Proses Persalinan (Non Farmaka)* (A. Yanto (ed.)). Unimus Press. http://repository.unimus.ac.id/3596/1/buku_ajar_nyeri_persalinan_full%284%29.pdf
- Salsabila, & Nurchasanah, Y. (2022). Pengaruh Pijat Endorphine Terhadap Intensitas Nyeri Pada Ibu Bersalin Kala 1 Fase Aktif: Evidence Based Case Report The Effect of Endorphin Massage on Pain Intensity in Active First Stages of Labour. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 2(3), 878. <https://doi.org/10.34011/jks.v2i3.781>
- Stuart, G. W. (2015). Buku Saku Keperawatan Jiwa. Alih Bahasa: Ramona P. Kapoh & Egi Komara Yudha. In *Jakarta: EGC*.
- Tamala, I. D. (2020). *Hubungan Pendampingan Suami Dengan Tingkat Kecemasan Pada Ibu Primigravida Menghadapi Persalinan Di PMB Widiyastuti, S.ST Kabupaten Magetan*. STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun.
- Utami, I., & Fitriahadi, E. (2019). *Buku Ajar Asuhan Persalinan & Manajemen Nyeri Persalinan*. Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

G. Glosarium

Ansietas = kecemasan

Coping = upaya individu untuk menanggulangi kecemasan, ketakutan, atau stress baik secara kognitif ataupun perilaku.

CHAPTER 7

KONSELING PSIKOSOSIAL BAGI IBU HAMIL

Bdn. Dian Fitriyani, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Selama masa kehamilan, kadar progesteron dan estrogen akan meningkat dan hormon tersebut menyebabkan perubahan pada fisik dan psikologis ibu selama kehamilan (Syaiful & Fatmawati, 2019). Periode kehamilan ini terdiri dari tiga trimester dimana setiap trimester memiliki perubahan fisik dan psikologis yang berbeda antara trimester satu dan lainnya yang memerlukan adaptasi atau penyesuaian (Ratnawati, 2018).

Perubahan yang dialami oleh ibu selama kehamilan dapat menjadi masalah jika tidak tertangani dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Khouj et al. (2022) di Jeddah bahwa ibu hamil akan mengalami masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan stres. Kecemasan adalah masalah psikologis yang paling banyak dialami oleh ibu hamil dengan prevalensi 54%, namun depresi dan stres juga dialami oleh ibu hamil dengan tingkat prevalensi yang cukup tinggi yakni 37,5% dan 25% (Khouj et al., 2022). Masalah psikologis yang dialami oleh ibu dan menyebabkan terjadinya kecemasan, stres dan depresi akan meningkatkan hormon stres (kortisol) pada ibu hamil dimana hal ini dapat memengaruhi fungsi plasenta, mengurangi suplai oksigen ke janin dan pada akhirnya, mengakibatkan gawat janin atau kematian pada janin dan juga dapat mengakibatkan masalah-masalah. Masalah yang terjadi adalah aborsi spontan, perdarahan antenatal, preeklampsia, eklampsia, apgar rendah, bayi baru lahir dengan berat lahir rendah (Dadi, Miller, Woodman, Azale, & Mwanri, 2020). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dadi, Miller, Woodman, Azale, dan Mwanri (2020) di Ethiopia didapatkan bahwa risiko lahir mati 3,22 kali lebih tinggi pada wanita dengan mekanisme koping tidak efektif dan 73% lebih rendah pada ibu yang memiliki tingkat mekanisme koping yang lebih tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan Syafrani tahun 2004 di Jakarta Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling kehamilan masih sederhana dan hanya terfokus pada hal-hal khusus mengenai kehamilan yang dikeluhkan pasien saat kunjungan kehamilan, proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan belum dapat dilakukan, konseling dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga penggalian informasi dari pasien tidak maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Retno di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa praktik konseling

yang diberikan di Puskesmas maupun Bidan Praktik Swasta (BPS) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi yang banyak didominasi oleh bidan. Informasi yang disampaikan bidan sebatas menjawab keluhan ibu hamil saja, sehingga masih banyak informasi yang belum diberikan pada ibu hamil. Hal ini menunjukkan bahwa bidan belum memahami benar tentang konseling pada ibu hamil. Upaya peningkatan keterampilan konseling selama ini hanya dengan cara membaca buku tentang konseling dan kehamilan, belajar dari teman dan belajar dari pengalaman selama praktik menjadi bidan. Bidan tidak belajar dari pelatihan-pelatihan tentang konseling karena belum pernah ada.⁸ Keterampilan konseling merupakan salah satu kompetensi bidan dalam asuhan kehamilan yang bertujuan agar ibu hamil memahami tentang kehamilannya dan dapat mengembangkan proses kehamilan secara dewasa. Pembuatan modul ini berdasarkan hasil temuan berbagai pihak yang melakukan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar untuk menentukan apa yang perlu disampaikan, dan bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikannya, dalam rangka meningkatkan keterampilan konseling bidan. Kualitas komunikasi bidan dalam memberikan pelayanan kehamilan diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya terhadap peningkatan dalam mutu pelayanan kehamilan. Ini berarti pelayanan kehamilan bukan hanya berorientasi pada pengobatan medis saja, melainkan juga berorientasi pada komunikasi, karena pelayanan melalui komunikasi sangat penting. Maka diperlukan panduan kegiatan yang membantu para bidan ketika melakukan kegiatan ANC khususnya pada pelaksanaan konseling kehamilan.

B. Perubahan Psikologi Dalam Kehamilan

1. Perubahan Psikologi Pada Kehamilan

Pada semua tahap kehamilan, hampir semua ibu mengalami banyak masalah selama hamil. Perlu beradaptasi dengan perubahan kehamilan dan kondisi lainnya. Akibat kehamilan dan perubahan sosial dalam keluarga secara otomatis sang ibu juga akan mengalami perubahan psikologis pertama yang terjadi selama hamil (Winarsih, 2019). Perubahan psikologi yang terjadi dalam masa awal kehamilan pertama kali dialami sang ibu. Perlu support dari untuk meringankan bebanya (Febriati, 2022).

a. Perubahan psikologis pada trimester I

- 1) Ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan kehamilannya.
- 2) Kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan dan kesedihan. Bahkan ibu berharap dirinya tidak hamil.
- 3) Ibu selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar hamil. Hal ini dilakukan hanya sekedar untuk meyakinkan dirinya.

- 4) Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu mendapat perhatian dengan seksama.
 - 5) Ketidakstabilan emosi dan suasana hati.
- b. Perubahan yang terjadi pada trimester II
- 1) Ibu sudah merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi.
 - 2) Ibu sudah bisa menerima kehamilannya.
 - 3) Ibu sudah dapat merasakan gerakan bayi.
 - 4) Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran.
 - 5) Merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan bagian dari dirinya.
 - 6) Hubungan sosial meningkat dengan wanita hamil lainnya/pada orang lain.
 - 7) Ketertarikan dan aktifitasnya terfokus pada kehamilan, kelahiran dan persiapan untuk peran baru.
 - 8) Perut ibu belum terlalu besar sehingga belum dirasa beban oleh ibu.
- c. Perubahan yang terjadi pada trimester III
- 1) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh dan tidak menarik.
 - 2) Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu.
 - 3) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya.
 - 4) Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya.
 - 5) Ibu tidak sabar menunggu kelahiran bayinya.
 - 6) Semakin ingin menyudahi kehamilannya.
 - 7) Aktif mempersiapkan kelahiran bayinya
 - 8) Bermimpi dan berkhayal tentang bayinya. (Pairman, 2010)

C. Dukungan Psikososial Pada Ibu Hamil

1. Support Keluarga

Dukungan selama masa kehamilan sangat dibutuhkan bagi seorang wanita yang sedang hamil, terutama dari orang terdekat apalagi bagi ibu yang baru pertama kali hamil, seorang wanita akan merasa tenang dan nyaman dengan adanya dukungan dan perhatian dari orang-orang terdekat.

Kehamilan merupakan peristiwa penting yang menuntut peran dari seluruh anggota keluarga. Penerimaan kehadiran anggota baru tergantung dari dukungan dari seluruh anggota keluarga, tidak hanya dari suami saja. Ayah dan ibu kandung maupun mertua, juga saudara kandung maupun saudara dari suami juga perlu memperhatikan. dengan sering berkunjung, menanyakan keadaan

kehamilan, bisa juga lewat sms atau telpon dapat menambah dukungan dari keluarga. Upacara adat istiadat yang tidak mengganggu kehamilan juga mempunyai arti tersendiri bagi sebagian ibu hamil sehingga hal ini tidak boleh diabaikan. Keterlibatan kakek nenek dalam menyongsong kehadiran cucu tergantung dengan banyak faktor diantaranya keinginan kakek nenek untuk terlibat, kedekatan hubungan kakek nenek dan peran kakek nenek dalam konteks budaya dan etnik yang bersangkutan. Nenek dari ibu merupakan model yang penting dalam praktik perawatan bayi. Ibu selalu teringat ketika ibunya dulu merawat anaknya sehingga merasa menjadi suatu hal yang patut ditiru. Nenek dari ibu dapat menjadi sumber pengetahuan dan merupakan pendukung. Seringkali kakek nenek mengatakan bahwa cucu dapat untuk mengatasi kesepian dan kebosanan. Kakek nenek dapat dilibatkan untuk memberi semangat dalam mempersiapkan menjadi orangtua baru. Dukungan kakek nenek dapat berpengaruh untuk menstabilkan keluarga yang sedang mengalami krisis perkembangan yaitu dalam kehamilan dan menjadi orangtua baru. Kakek nenek dapat membantu anak-anak mereka mempelajari ketrampilan menjadi orangtua dan mempertahankan tradisi budaya. Bidan akan selalu memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil pada berbagai setting pelayanan, baik primer, sekunder maupun tertier. Dalam menjalankan asuhan kehamilan, upayakan Anda tidak terjebak pada suatu kegiatan rutinitas kebiasaan lama yang tidak berdasar pada suatu evidence based menuju asuhan yang terfokus (refocusing asuhan), senantiasa menelaah isu terkini dalam asuhan kehamilan agar mampu mengembangkan pelayanan kehamilan. Asuhan kehamilan memerlukan acuan, patokan atau indikator, hal inilah yang disebut standar asuhan kebidanan. Sehingga pelayanan kebidanan bisa diberikan secara efektif dan efisien, untuk memahami dasar-dasar dalam asuhan kehamilan, tujuan asuhan kehamilan dan tipe pelayanan. Sehingga dapat memahami hak-hak wanita hamil dan standar asuhan kehamilan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka Bidan perlu mempelajari secara rinci mengenai pokok-pokok materi seperti: Tujuan asuhan kehamilan, Tipe pelayanan, Hak-hak wanita hamil, Standar asuhan kehamilan.

2. Suami

Dukungan dan peran serta suami dalam masa kehamilan terbukti meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi kehamilan dan proses persalinan, bahkan juga memicu produksi asi. Suami sebagai seorang yang paling dekat, dianggap mengetahui kebutuhan istri. Tugas penting suami yaitu memberikan perhatian dan membina hubungan baik dengan istri, sehingga istri

mengkonsultasikan setiap saat dan setiap masalah yang dialaminya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan selama mengalami kehamilan.

Keterlibatan Suami sejak awal masa kehamilan, sudah pasti akan mempermudah dan meringankan pasangan dalam menjalani dan mengatasi berbagai perubahan yang terjadi pada tubuhnya akibat hadirnya sosok “manusia mungil” di dalam rahimnya. Bahkan, keikutsertaan suami secara aktif dalam masa kehamilan, dapat mempengaruhi keberhasilan seorang istri dalam mencukupi kebutuhan asi untuk si bayi kelak. Sangat ditentukan oleh seberapa besar peran dan keterlibatan suami dalam masa-masa kehamilannya.

Saat hamil merupakan saat yang sensitif bagi seorang wanita, jadi sebisa mungkin seorang suami memberikan suasana yang mendukung perasaan istri.

Suami adalah orang yang terdekat dari istri. Dukungan dari suami selama hamil sangat diperlukan untuk kesiapan ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Dukungan suami yang dibutuhkan istrinya yang sedang hamil diantaranya adalah :

- a. Suami sangat mendambakan bayi dalam kandungan istrinya
- b. Suami merasa senang dan bahagia mendapat keturunan
- c. Suami menunjukkan kebahagiaan pada kehamilan ini
- d. Suami memperhatikan kesehatan istri.
- e. Suami tidak menyakiti istri.
- f. Suami menghibur / menenangkan ketika ada masalah yang dihadapi istri.
- g. Suami menasehati istri agar istri tidak terlalu capek bekerja.
- h. Suami membantu tugas istri.
- i. Suami berdoa untuk kesehatan dan keselamatan istrinya.
- j. Suami mengantar ketika pemeriksaan hamil.
- k. Suami menemani jalan – jalan.
- l. Suami merencanakan mendampingi pada saat melahirkan.

Suami yang menerima dan memahami perubahan yang terjadi pada istrinya, akan merencanakan dan diskusi bersama istri tentang rencana persalinan. Suami tidak hanya diperlukan untuk menyiapkan biaya persalinan dan mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi suami penting untuk memperhatikan keadaan istrinya selama hamil. Seorang istri yang merasa gembira selama hamil, dia akan lebih bersemangat dan akhirnya mempunyai tenaga yang kuat untuk melahirkan bayinya sehingga mempermudah dalam persalinan yang artinya dapat mencegah terjadinya persalinan lama

3. Dukungan Dari Keluarga

Lingkungan keluarga yang harmonis ataupun lingkungan tempat tinggal yang kondusif sangat berpengaruh terhadap keadaan emosi ibu hamil. Wanita hamil seringkali mempunyai ketergantungan terhadap orang lain disekitarnya,

terutama pada ibu primigravida. Keluarga harus menjadi bagian dalam mempersiapkan pasangan menjadi orang tua.

Kehamilan merupakan peristiwa penting yang menuntut peran dari seluruh anggota keluarga. Penerimaan kehadiran anggota baru tergantung dari dukungan dari seluruh anggota keluarga, tidak hanya dari suami saja. Ayah dan ibu kandung maupun mertua, juga saudara kandung maupun saudara dari suami juga perlu memperhatikan dengan sering berkunjung, menanyakan keadaan kehamilan, bisa juga lewat sms atau telpon dapat menambah dukungan dari keluarga. Upacara adat istiadat yang tidak mengganggu kehamilan juga mempunyai arti tersendiri bagi sebagian ibu hamil sehingga hal ini tidak boleh diabaikan. Keterlibatan kakek nenek dalam menyongsong kehadiran cucu tergantung dengan banyak faktor diantaranya keinginan kakek nenek untuk terlibat, kedekatan hubungan kakek nenek dan peran kakek nenek dalam konteks budaya dan etnik yang bersangkutan. Nenek dari ibu merupakan model yang penting dalam praktik perawatan bayi. Ibu selalu teringat ketika ibunya dulu merawat anaknya sehingga merasa menjadi suatu hal yang patut ditiru. Nenek dari ibu dapat menjadi sumber pengetahuan dan merupakan pendukung. Seringkali kakek nenek mengatakan bahwa cucu dapat untuk mengatasi kesepian dan kebosanan. Kakek nenek dapat dilibatkan untuk memberi semangat dalam mempersiapkan menjadi orangtua baru. Dukungan kakek nenek dapat berpengaruh untuk menstabilkan keluarga yang sedang mengalami krisis perkembangan yaitu dalam kehamilan dan menjadi orangtua baru. Kakek nenek dapat membantu anak-anak mereka mempelajari ketrampilan menjadi orangtua dan mempertahankan tradisi budaya. Bidan akan selalu memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil pada berbagai setting pelayanan, baik primer, sekunder maupun tertier. Dalam menjalankan asuhan kehamilan, upayakan Bidan tidak terjebak pada suatu kegiatan rutinitas kebiasaan lama yang tidak berdasar pada suatu evidence based menuju asuhan yang terfokus (refocusing asuhan), senantiasa menelaah isu terkini dalam asuhan kehamilan agar mampu mengembangkan pelayanan kehamilan. Asuhan kehamilan memerlukan acuan, patokan atau indikator, hal inilah yang disebut standar asuhan kebidanan. Sehingga pelayanan kebidanan bisa diberikan secara efektif dan efisien, untuk memahami dasar-dasar dalam asuhan kehamilan, tujuan asuhan kehamilan dan tipe pelayanan. Sehingga dapat memahami hak-hak wanita hamil dan standar asuhan kehamilan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka Anda perlu mempelajari secara rinci mengenai pokok-pokok materi seperti: Tujuan asuhan kehamilan, Tipe pelayanan, Hak-hak wanita hamil, Standar asuhan kehamilan.

Dukungan Keluarga Dapat Berbentuk:

- a. Ayah ibu kandung maupun mertua sering berkunjung dalam periode ini.
- b. Ayah ibu kandung maupun mertua sangat mendukung kehamilan ini.
- c. Seluruh keluarga berdo'a untuk keselamatan ibu dan bayi.
- d. Adanya ritual adat istiadat yang memberikan arti tersendiri yang tidak boleh ditinggalkan.

4. Lingkungan

Dukungan lingkungan dapat berupa:

- a. Membicarakan dan menasehati tentang pengalaman hamil dan melahirkan.
- b. Doa bersama untuk keselamatan ibu dan bayi dari ibu-ibu pengajian/ perkumpulan/kegiatan yang berhubungan dengan sosial / keagamaan.
- c. Adanya diantara mereka yang bersedia mengantarkan ibu untuk periksa.
- d. Menemani ibu ketika melahirkan.
- e. Mereka dapat menjadi seperti saudara ibu hamil

5. Dukungan Dari Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang paling dekat dengan ibu hamil adalah bidan, karena bidan merupakan tenaga kesehatan dari lini terdepan yang mempunyai tugas untuk menjaga dan meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak termasuk ibu hamil. Bidan harus memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil baik secara fisik maupun psikologis. Dengan memahami keadaan pasien maka bidan dapat memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dukungan dari bidan yang diperlukan ibu hamil adalah :

- a. Bidan melayani ibu dengan baik dan ramah.
- b. Bidan menjalin hubungan baik dan saling percaya.
- c. Bidan memberi kesempatan pada ibu untuk bertanya dan menjawab setiap pertanyaan dengan jelas.
- d. Bidan meyakinkan bahwa ibu akan melalui kehamilan dengan baik.
- e. Bidan memberi semangat pada ibu dalam rangka menghadapi persalinan.
- f. Bidan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi ibu hamil.
- g. Bidan meyakinkan bahwa akan mendampingi selama dalam persalinan.
- h. Bidan juga bisa menjadi pendamping dan pembimbing pada kelas ibu hamil.
- i. Dukungan Aktif: melalui kelas antenatal
- j. Dukungan Pasif: dengan memberikan kesempatan kepada ibu hamil yang mengalami masalah untuk berkonsultasi.

Peran bidan dalam perubahan dan adaptasi psikologi adalah dengan memberi support atau dukungan moral bagi klien, meyakinkan bahwa klien dapat menghadapi kehamilannya dan perubahan yang dirasakannya adalah sesuatu yang normal.

Bidan harus bekerja sama dan membangun hubungan yang baik dengan klien agar terjalin hubungan yang terbuka antara bidan dan klien. Keterbukaan ini akan mempermudah bidan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi klien.

Bidan juga berfungsi sebagai fasilitator bagi kliennya. Bidan dapat membagi pengalaman yang pernah dirasakan bidan itu sendiri, misalnya jika bidan tersebut juga pernah merasakan kehamilan.

Bidan juga berperan sebagai seorang pendidik, bidan yang memutuskan apa yang harus diberitahukan kepada klien dalam menghadapi kehamilannya agar selalu waspada terhadap perubahan yang terjadi.

Tenaga kesehatan juga dapat memberikan peranannya melalui dukungan, yaitu:

a. Rasa Aman dan Nyaman Selama Kehamilan

Orang yang paling penting bagi seorang wanita hamil biasanya adalah ayah dari sang anak. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa wanita yang diperhatikan dan dikasihi oleh suaminya selama hamil menunjukkan lebih sedikit gejala emosi dan fisik, lebih sedikit komplikasi persalinan, dan lebih mudah melakukan penyesuaian selama masa nifas.

Peran keluarga khususnya suami sangat diperlukan bagi seorang wanita hamil. Keterlibatan dan dukungan yang diberikan suami kepada kehamilan akan mempererat hubungan antara suami istri dan dukungan yang diperoleh oleh ibu hamil akan membuatnya lebih tenang dan nyaman dalam kehamilannya. Ibu hamil membutuhkan perasaan aman dan nyaman yang dapat didapat dari diri sendiri dan orang sekitar. Untuk memperoleh rasa aman dan nyaman maka ibu hamil sendiri harus dapat menerima kehamilan dengan senang hati. Rasa aman dan nyaman dari orang sekitar terutama dari orang terdekat yaitu bapak dari bayi yang dikandungnya. Maka perlu dukungan orang terdekat untuk memperoleh rasa aman dan nyaman. Misalnya perasaan nyeri di pinggang pada saat hamil tua, respon ibu hamil terhadap nyeri bisa berbeda – beda, apabila ibu hamil tersebut cukup mendapat dukungan dari orang sekitar maka mungkin tidak terlalu merasakan nyeri, tapi sebaliknya jika ibu hamil tidak mendapat dukungan dari orang terdekat maka nyeri akan dirasakan sangat mengganggu. Untuk memperoleh rasa aman dan nyaman ini dapat dilakukan relaksasi atau dukungan dari orang terdekat. Rasa nyaman saat hamil dapat dirasakan jika ibu hamil dengan posisi duduk, berdiri dan berjalan dengan benar, melatih relaksasi sehingga dapat mengurangi nyeri pada pinggang dan perasaan serta pikiran yang tenang.

Contoh dukungan yang dapat diberikan oleh suami misalnya dengan mengantar ibu memeriksakan kehamilan, mengingatkan minum tablet besi, maupun membantu ibu melakukan kegiatan rumah tangga selama ibu hamil.

b. Persiapan Menjadi Orang Tua

Pasangan yang menanti anggota baru dalam keluarga yaitu datangnya seorang bayi adalah merupakan tanggung jawab besar. Bagi seorang ayah merupakan beban besar dari segi biaya termasuk biaya kehamilan, biaya persalinan, biaya peralatan yang diperlukan ibu dan bayinya, kebutuhan tambahan setelah anaknya lahir, semua ini harus disiapkan dengan perencanaan matang. Disamping itu juga perlu persiapan psikologis untuk merawat bayinya dan anak yang sebelumnya (sibling). Kalau ayah belum siap maka dapat menimbulkan gangguan psikologis pada suami sehingga dapat mengurangi dukungan pada istri yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil juga harus sudah menyiapkan diri menjadi ibu karena akan bertambah beban dan tanggung jawabnya karena kehadiran bayinya. Mungkin ibu akan lebih repot dalam menjaga bayinya, akan kurang tidur, kurang waktu merawat tubuhnya, tidak dapat bekerja seperti biasanya, kurang waktu untuk rekreasi dsb. Jika ibu tidak dengan senang hati melaksanakan kewajiban sebagai orangtua maka dapat timbul stress dan kemungkinan akan menderita post partum blues pada saat setelah persalinan.

- a. Kehamilan dan peran sebagai orang tua dapat dianggap sebagai masatransisi atau peralihan
- b. Terlihat adanya peralihan yang sangat besar akibat kelahiran dan peran yang baru sebagai orang tua
- c. Untuk pasangan baru, kehamilan merupakan kondisi perubahan menjadi orang tua, dan apabila kehamilan berakhir maka akan bertambah tanggung jawab keluarga.
- d. Reaksi pertama seorang pria ketika mengetahui dirinya akan menjadi seorang ayah maka timbulnya kebanggaan atas dirinya dan harus bertanggung jawab menjadi seorang ayah dan pencari nafkah untuk keluarganya.

6. Keterampilan Kognitif-Efektif

Keterampilan Kognitif-Motorik

- a. Dalam proses ini orang tua melibatkan aktifitas perawatan anak, seperti memberi makan, menjaganya dari bahaya, memungkinkannya untuk bisa bergerak. Kemampuan ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya dan budayanya. Banyak orang tua harus belajar untuk melakukan tugas ini dan proses belajar ini mungkin sukar bagi mereka.

- b. Komponen psikologis menjadi orang tua, sifat keibuan atau kebapakan tampaknya berakar dari pengalaman orang tua di masa kecil saat mengalami dan menerima kasih sayang dari ibunya. Dalam hal ini orang tua bisa dikatakan mewarisi kemampuan untuk menunjukkan perhatian dan kelembutan.

7. Persiapan Sibling

Kehadiran seorang adik yang baru dapat merupakan krisis utama bagi seorang anak. Anak sering mengalami perasaan kehilangan atau merasa cemburu karena digantikan oleh bayi yang baru, sehingga anak itu perlu dipersiapkan untuk perubahan baru ini.

Kehadiran seorang adik baru dalam rumah dapat menyebabkan perasaan cemburu dan merasa adik adalah saingannya (rival sibling). Untuk mencegah itu semua maka sejak hamil calon kakak harus sudah disiapkan dengan baik untuk menyambut kelahiran adiknya. Respon sibling dapat dipengaruhi oleh persiapan menghadapi datangnya adik, sikap orangtua, umur, lama waktu berpisah dengan orangtua, peraturan kunjungan rumah sakit dan perhatian selama berpisah dengan ibunya. Anak umur lebih dari 3 tahun sudah dapat diajak komunikasi untuk disiapkan menerima adiknya. Orangtua dan lingkungan sering tidak sadar bahwa tindakannya sangat menyakitkan sang kakak dan akhirnya membuat sang kakak menjadi tidak sayang pada adiknya, padahal sebelumnya sudah disiapkan untuk menerima adiknya, misalnya seorang anak sudah disiapkan untuk menerima kelahiran adiknya, sejak adik dalam kandungan sudah diberi peran untuk komunikasi dengan adik dengan cara diajak meraba perut ibunya ketika ada gerakan janin. Ketika adiknya sudah lahir diberi peran juga dengan diminta mengambilkan popok untuk adiknya sehingga sang kakak merasa senang dan menerima adiknya. Tetapi ketika ada anggota keluarga lain atau tetangga yang datang menengok adik selalu memuji adik, memberikan hadiah selalu untuk adik maka sang kakak dapat berubah menjadi benci pada adik, tidak sayang pada adik karena merasa semua orang lebih memperhatikan adiknya, Jadi perhatian kepada sang kakak tidak hanya pada saat sebelum adiknya lahir tetapi seterusnya jangan sampai kakak merasa perhatiannya dirampas oleh adiknya. Orangtua yaitu ibu dan ayah mempunyai tugas penting yang terkait dengan penyesuaian dan permusuhan antar saudara kandung. Tugas tersebut antara lain :

- a. Orangtua harus membuat anak yang lebih tua merasa dikasihi dan diinginkan. Meskipun orangtua sibuk dengan kedatangan bayi tetapi harus tetap memperhatikan anak yang lebih tua supaya tidak merasa ada saingan.
- b. Mengatasi rasa bersalah yang timbul dari pemikiran bahwa anak yang lebih tua mendapat perhatian dan waktu yang kurang.

- c. Mengembangkan rasa percaya diri bahwa mereka mampu mengasuh lebih dari satu anak.
- d. Menyesuaikan waktu dan ruang untuk menampung bayi baru yang akan lahir.
- e. Memantau perlakuan anak yang lebih tua terhadap bayi yang masih lemah dan mengalihkan perilaku agresif.

Untuk mempersiapkan orangtua dan anak kandung yang lebih tua, klas persiapan untuk saudara kandung sangat efektif. Respon saudara kandung terhadap kehamilan menurut umur:

- a. Umur satu tahun, tidak banyak menyadari proses kehamilan ibunya. b. Umur dua tahun, menyadari perubahan tubuh ibunya yang semakin besar perutnya. Mengalami kemunduran perilaku : lebih manja, saat makan biasanya sudah mau belajar makan sendiri sekarang selalu minta disuap.
- b. Umur tiga atau empat tahun : sudah bisa menerima kehamilan ibunya, mereka senang mendengar bunyi jantung janin dan merasakan gerakan janin dalam rahim.
- c. Anak usia sekolah: ingin tahu lebih secara rinci, sehingga banyak mengajukan pertanyaan–pertanyaan, bagaimana bayi masuk kedalam perut ibunya, bagaimana nanti bisa keluar? Mereka ikut menantikan kehadiran adik baru, senang diajak berbelanja untuk perlengkapan bayi. Persiapan untuk sibling supaya menyesuaikan dengan umur sehingga persiapan yang dilakukan orangtua bisa tepat, akhirnya sibling akan dapat menerima kehadiran adiknya dengan senang hati tanpa ada cemburu.

D. Konseling Psikososial Pada Ibu Hamil

Kecemasan kehamilan adalah jenis yang sangat spesifik tekanan psikologis ibu didefinisikan sebagai kecemasan mengenai kesehatan ibu sendiri, kesehatan bayi, dan persalinan di konteks kehamilan tertentu. Dukungan kesehatan Klien selama kehamilan penting diperhatikan karena selama kehamilan risiko komplikasi kelahiran, status neonatal, dan depresi postpartum meningkat. Perubahan psikologis dalam kehamilan seperti stres dapat diperkuat oleh perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan. yang mengakibatkan peningkatan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan tekanan emosional pada ibu.

Tekanan emosional berkelanjutan dalam kehamilan dapat mempengaruhi pengembangan neuroendokrin pada janin dan pembentukan ikatan batin dengan bayi baru lahir dan, akibatnya, perkembangan sosioemosional anak. Depresi pada ibu hamil dapat mengubah pola perkembangan otak pada bayi. Banyak penelitian tentang faktor risiko untuk kecemasan dan depresi gejala selama kehamilan menunjukkan bahwa risiko depresi dikaitkan dengan hubungan yang buruk dengan

teman, dukungan rendah atau tidak ada dukungan keluarga / teman faktor demografi seperti rendah pendidikan, status tunggal, ekonomi sulit, ibu usia muda, banyak anak, gaya hidup tinggi, kehamilan pertama, sejarah masa lalu dari aborsi, kehamilan yang tidak diinginkan dan riwayat depresi.

Sebesar 65% wanita hamil takut janinnya akan cedera, sehingga enggan berhubungan seksual.^{43,45} Asuhan kebidanan yang dapat diberikan untuk mengurangi keluhan ibu yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada ibu bahwa hubungan seks aman dilakukan selama kehamilan kecuali jika ada indikasi
2. Mengajarkan ibu untuk memilih posisi saat berhubungan seksual sesuai dengan kenyamanan ibu
3. Mengajarkan ibu untuk menghindari stress

Perubahan psikologis yang terjadi tidak lepas dari pengaruh keseimbangan hormonal serta kemampuan ibu mengatasi ketidaknyamanan akibat perubahan fisiologi yang terjadi sejak awal kehamilan. Pada trimester II perubahan psikologis sangat dipengaruhi oleh kemampuan ibu mengatasi ketidaknyamanan yang terjadi pada trimester I serta penerimaan ibu terhadap kehamilannya. Perubahan psikologis yang terjadi pada trimester II merupakan suatu kelanjutan dari kemampuan ibu mengatasi perubahan yang terjadi (coping stress) pada trimester I. Perubahan tubuh yang dimulai terjadi pada trimester II akan menjadikan ibu mengalami krisis kepercayaan diri atau yang disebut dengan krisis body image.

Kenaikan berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi pada janin. Pada saat kehamilan ini kenaikan berat badan memang sangat diharapkan. Hubungan antara citra tubuh berhubungan dengan kenaikan berat badan khususnya pada kehamilan. Citra tubuh berhubungan dengan persepsi seseorang, perasaan dan pikiran tentangnya atau tubuhnya, dan biasanya dikonseptualisasikan sebagai tubuh menggabungkan estimasi ukuran, evaluasi tarik tubuh dan emosi yang terkait dengan bentuk tubuh dan ukuran. Asuhan yang bisa dilakukan bidan yaitu:

1. Mengajarkan pada ibu hamil untuk melakukan diet rendah gula, lemak
2. Mengajarkan pada ibu hamil untuk melakukan olahraga ringan seperti berjalan atau berenang.

Ibu hamil yang mendapatkan dukungan sosial yang baik selama kehamilan memiliki level kecemasan yang lebih rendah. Dukungan dan kualitas hubungan yang tinggi dengan pasangan berhubungan erat dengan tingkat kecemasan yang rendah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek kecemasan menghadapi masa persalinan pada ibu hamil adalah :

1. Aspek psikologis meliputi gejala-gejala yang dapat menyebabkan kecemasan. Misalnya, rasa takut, mudah tersinggung, tidak tenang, gelisah, cemas akan suatu hal, tidak dapat berkonsentrasi, dan lain sebagainya.
2. Aspek fisiologis meliputi gejala-gejala fisik yang dapat menimbulkan kecemasan. Seperti, cepatnya detak jantung dan keringat yang berlebihan, sulit tidur, nafsu makan menurun bahkan hilang.
3. Aspek perilaku meliputi usaha-usaha yang dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan.

Asuhan kebidanan yang dapat dilakukan oleh bidan adalah dengan intervensi non-farmakologi. Intervensi non farmakologi ini biasa disebut dengan mind-body interventions yang terdiri dari proses berpikir, kesadaran fisik dan perilaku, seperti hipnosis, tai-chi, yoga dan meditasi. Selain intervensi non farmakologis yang sudah disebutkan, psychoeducation dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman diri ibu hamil yang mampu merubah sikap, perilaku, tujuan hidup, kemampuan dan perhargaannya terhadap kehamilan.

E. Referensi

- Chamberlain, G dan Margery (2013), Asuhan Antenatal Edisi 4, EGC, Jakarta
- Cunningham, FG. (2012), Obstetri Ginekologi, EGC, Jakarta Djami, MEU (2013). Isu Terkini dan Evidence Based dalam Praktik Kebidanan. Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang.
- Field T, Hernandez-Reif M, Hart S, Theakston H, Schanberg S, Kuhn C. *Pregnant women benefit from massage therapy*. J Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology. 1999; 20(1): 31-38
- Heru, Retno. (2011) Konseling Ibu Hamil Pada Bidan Praktik Swasta (BPS) Dan Puskesmas Di Kabupaten Bantul, Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Hutchison BL, Stone PR, McCowan LME, Stewart AW, Thompson JMD, et al. (2012) A postal survey of maternal sleep in late pregnancy. BMC Pregnancy and Childbirth page 12:144
- Ibrahim S. Analisis terhadap pelaksanaan konseling kehamilan oleh bidan di Puskesmas Kecamatan Wilayah Jakarta Timur. Tesis FKM Universitas Indonesia. 2004
- Kusmiyati, Y, (2010), Penuntun Praktikum Asuhan Kehamilan, Fitramaya, Yogyakarta
- Mandriwati, GA, (2011). Asuhan kebidanan Antenatal : Penuntun Belajar, Edisi 2 Jakarta : EGC
- Mindell JA, Jacobson BJ: (2000) *Sleep disturbances during pregnancy*. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000, 29(6):590–597.

- Mochtar, Megasari, M dkk (2014), Panduan Belajar Asuhan Kebidanan I, Deepublish, Yogyakarta
- Mufdalifah (2009). Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil, Nuha Medika, Yogyakarta
- Mufdlilah, (2009). Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil. Yogyakarta : Nuha Medika
- Narendran, S., Nagarathna, R., Gunasheela, S., & Nagendra, H. R. (2005) *Efficacy of yoga in pregnant women with abnormal Doppler study of umbilical and uterine arteries. J Indian Med Assoc.*USA
- Nurul Jannah, (2012). Buku Ajar Asuhan Kebidanan – Kehamilan.Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Nanny, V, (2011), Asuhan Kehamilan untuk Kebidanan, Salemba Medika, Jakarta
- Pantrikawati, I dan Saryono (2010), Asuhan Kebidanan I (Kehamilan), Nuha Medika, Yogyakarta.
- Neau JP, Texier B, Ingrand P (2009) *Sleep and vigilance disorders in pregnancy.* Eur Neurol, Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000, 62(1):23–29.
- Pien GW, Fife D, Pack AI, Nkwuo JE, Schwab RJ (2005): *Changes in symptoms of sleep-disordered breathing during pregnancy.* Obstet Gynecol Neonatal Nurs page 140:144
- Sulistiyawati, A. (2011). Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan, Salemba Medika, Jakarta
- Sunarsih, T, dkk (2011), Asuhan Kehamilan Untuk Kebidanan, Salemba, Jakarta

CHAPTER 8

PERAWATAN GIGI DAN KESEHATAN MULUT SELAMA KEHAMILAN

Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, baik secara jasmani maupun rohani, tidak terkecuali pada ibu hamil. Salah satu bagian Kesehatan secara menyeluruh adalah Kesehatan gigi dan mulut. Pemeliharaan Kesehatan gigi dan mulut harus dilakukan dengan baik dan benar, supaya terwujud Kesehatan gigi dan mulut yang optimal dimana termasuk dalam Kesehatan ibu hamil pada umumnya (Kemenkes RI, 2012)

Kesehatan yang perlu diperhatikan selain kesehatan tubuh secara umum adalah kesehatan gigi dan mulut karena kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, prevalensi masalah kesehatan gigi-mulut adalah 23 %, dengan prevalensi karies aktif sebesar 43,3 % (Kemenkes RI, 2019)

Peningkatan prevalensi ini terjadi seiring dengan meningkatnya usia dan gejala yang dijumpai pada seluruh populasi, dan salah satu kelompok yang rentan terhadap masalah ini adalah kelompok wanita hamil. Beberapa studi menyatakan bahwa efek perubahan hormonal akan mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut wanita hamil, di mana didapatkan bahwa 27-100% wanita hamil mengalami gingivitis dan 10% mengalami granuloma pyogenik. Hal ini disebabkan karena perubahan hormonal dan vaskular yang disertai dengan kehamilan akan memperberat respon gingiva terhadap plak bakteri. Ibu hamil dengan *gingivitis* memiliki faktor resiko terjadinya bayi lahir dengan berat badan rendah. Seperti penelitian yang dilakukan Retnoningrum pada tahun 2006 di rumah sakit Dr. Kariadi Semarang, melaporkan bahwa *gingivitis* pada ibu hamil mempunyai faktor resiko bayi lahir dengan berat badan lahir rendah sebesar 8,75 kali dibanding ibu yang tidak mengalami *gingivitis*. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) mencatat radang gusi merupakan masalah mulut dan gigi yang sering menimpa ibu hamil dimana 5%-10% mengalami pembengkakan gusi. Catatan PDGI diperkuat temuan *Journal of Periodontology* yang diterbitkan tahun 1996. Riset itu mencatat 7 dari 10

perempuan hamil yang menderita radang gusi berpotensi besar memiliki anak yang lahir secara prematur. (Santoso et al., 2009)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karies gigi tetap tinggi selama kehamilan yaitu sekitar 40-90% wanita hamil menderita karies gigi di negara-negara berkembang. Perubahan kondisi periodontal ibu hamil dapat dihubungkan dengan perubahan kadar hormon steroid yang mempengaruhi vaskularisasi subgingiva, mikrobia subgingiva, sel spesifik periodontal dan sistem imun lokal selama kehamilan, perhatian masyarakat terhadap kesehatan ibu selama masa kehamilan semakin meningkat, tetapi tidak dibarengi kesehatan gigi dan mulut sehingga terlewatkan dari perhatian. Berdasarkan pengamatan klinis, prevalensi penyakit periodontal selama kehamilan hasil beberapa penelitian bervariasi antara 20% - 100% (Nazir, 2017)). Kesehatan gigi dan mulut yang buruk pada ibu hamil dapat memberi efek terhadap janin seperti bayi prematur dan berat badan lahir rendah di samping dampaknya terhadap kesehatan gigi dan mulut bayi nantinya. (Budiarti & Suja, 2023)

Masalah kesehatan gigi saat hamil seringkali terabaikan. Wanita hamil lebih senang “menyibukkan diri” dengan pemeriksaan kandungan dan USG untuk melihat perkembangan janinnya. Walaupun memang pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*) memang perlu dilakukan secara teratur dan berkala, tapi pemeriksaan gigi juga tidak boleh disepelekan. Wanita hamil, terutama pada masa trimester pertama cenderung lebih malas untuk melakukan banyak aktivitas, salah satunya merawat kesehatan gigi dan mulut, karena ibu hamil mengalami mual dan muntah (*morning sickness*). Selain itu, kebiasaan mengonsumsi makanan berasa asam dan manis membuat masalah gigi lebih mudah untuk muncul. Sebagaimana kesehatan umum dan wanita hamil dirasakan penting untuk diperhatikan, maka sebaiknya pemeliharaan kesehatan dan perawatan gigi mulutpun harus mendapat perhatian juga. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut akan mengurangi infeksi gingivitis selama kehamilan, dan sebenarnya perawatan gigi dan mulut pada masa kehamilan relative aman. Tingkat prevalensi pengguna pelayanan kesehatan gigi selama masa kehamilan dilaporkan berkisar 23-43 % dari jumlah ibu hamil, sekitar 58 % tidak melakukan perawatan gigi selama masa kehamilan. (Lydon-Rochelle et al., 2004).

B. Pentingnya Perawatan Gigi dan Kesehatan Mulut Selama Kehamilan

Seorang ibu hamil harus menjaga kondisi kesehatan dengan baik, mengonsumsi berbagai jenis makanan dan vitamin demi kesehatan ibu dan bayinya. Kehamilan adalah suatu proses fisiologis yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada tubuh wanita, baik fisik maupun psikis. Keadaan ini disebabkan adanya perubahan hormon estrogen dan progesteron. Saat kehamilan disertai

berbagai keluhan lain seperti ngidam, mual, muntah termasuk keluhan sakit gigi dan mulut. Kondisi gigi dan mulut ibu hamil seringkali ditandai dengan adanya pembesaran gusi yang mudah berdarah karena jaringan gusi merespons secara berlebihan terhadap iritasi lokal. Bentuk iritasi lokal ini berupa karang gigi, gigi berlubang, susunan gigi tidak rata atau adanya sisa akar gigi yang tidak dicabut. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan ibu pada saat tidak hamil. Pembesaran gusi ibu hamil biasa dimulai pada trimester pertama sampai ketiga masa kehamilan. Keadaan ini disebabkan aktivitas hormonal yaitu hormon estrogen dan progesteron (ANJANI et al., 2022)

Merawat gigi selama hamil merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian serius para ibu. Percaya atau tidak, kesehatan organ mulut ibu hamil terutama gigi, sangat berkaitan dengan kehamilannya. Kesehatan gigi selama kehamilan yang tidak terjaga tidak hanya akan mengganggu ibu hamil saja tetapi dapat juga berdampak pada bayi di dalam rahimnya.

Pada sebagian wanita, kehamilan dapat menimbulkan beberapa gangguan organ oral. Perubahan hormon yang besar dapat mengakibatkan pelunakan jaringan gusi dan gingivitis atau gusi mudah berdarah, terutama di usia kehamilan 2 sampai 8 bulan. Pada kondisi gusi berdarah, berarti ada pembuluh darah yang pecah, pada saat yang bersamaan jika gigi ibu hamil dalam keadaan tidak terawat maka bisa jadi bakteri yang menempel di gigi akan masuk melalui pembuluh darah tadi dan dapat menyebabkan infeksi. Kemudian terjadilah "efek domino", di mana infeksi tadi akan menimbulkan sejumlah keluhan lain, seperti demam dan nyeri yang kemudian menyebabkan ibu hamil mengalami kesulitan makan dan istirahat, akibat selanjutnya kehamilan dapat terganggu. Inilah salah satu alasan pentingnya merawat gigi ibu sejak merencanakan kehamilan.

Merawat gigi ibu hamil, terutama yang mengalami kerusakan cukup parah harus segera dilakukan, karena kerusakan yang cukup parah di organ ini dapat merangsang tubuh ibu menghasilkan hormon prostaglandin. Tubuh terdorong untuk menghasilkan hormon ini lebih dari biasanya karena hormon ini bertugas untuk melawan racun yang dikeluarkan oleh bakteri ke dalam aliran darah ibu. Ironisnya, hormon ini merupakan salah satu pencetus kontraksi, sehingga memicu kelahiran bayi prematur, dengan usia dan berat badan yang belum cukup.

Selama kehamilan ibu membutuhkan asupan zat makanan bergizi. Bila ibu hamil mengalami gangguan pada mulut dan gigi maka kebutuhan pemenuhan makanan tersebut akan terganggu. Terutama bila ibu hamil mengalami caries atau gigi keropos dan berlubang ibu tidak dapat mengunyah makanan dengan baik, akibatnya gizi janin kurang dan bayi mengalami gangguan pertumbuhan dalam kandungan. Manfaat Perawatan Gigi Selama Hamil : 1) Supaya gigi tetap bersih; 2)

Untuk menambah percaya diri karena memiliki gigi putih, bersih, dan senyum yang sehat; 3) Agar terhindar dari penyakit gigi dan mulut. 4) Dapat berfungsi dengan baik; 5) Ibu dan janin menjadi sehat.

C. Masalah Kesehatan Gigi Dan Mulut Selama Kehamilan

Kondisi mual dan muntah mengakibatkan kadar asam di mulut meningkat, ibu hamil umumnya merasa takut untuk menyikat gigi karena dapat memicu rasa mual. Beberapa ibu hamil senang mengonsumsi makanan yang asam dan manis untuk mengurangi rasa mual dan muntah. (Habib et al., 2019). Jika ibu hamil tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, maka terjadi peningkatan plak dalam gigi yang akan memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut. Berikut jenis gangguan kesehatan gigi dan mulut yang sering terjadi selama masa kehamilan:

1. Karies Gigi

Kehamilan tidaklah langsung menyebabkan karies gigi. Meningkatnya karies gigi atau menjadi lebih cepatnya proses karies yang sudah ada pada masa kehamilan lebih disebabkan karena perubahan lingkungan di sekitar gigi dan kebersihan mulut yang kurang. Faktor-faktor yang dapat mendukung lebih cepatnya proses karies yang sudah ada pada wanita hamil seperti pH saliva wanita hamil lebih asam jika dibandingkan dengan yang tidak hamil. (Lei et al., 2019a)

Kemudian waktu hamil biasanya sering memakan-makanan kecil yang banyak mengandung gula. Adanya rasa mual dan muntah membuat wanita hamil malas memelihara kebersihan rongga mulutnya, akibatnya serangan asam pada plak yang dipercepat dengan adanya asam dari mulut karena mual atau muntah tadi dapat mempercepat proses terjadinya karies gigi. Pada pH lebih rendah menyebabkan rongga mulut mempunyai suasana asam dan menyebabkan demineralisasi gigi. Beberapa ibu hamil mengalami keluhan rasa asam dan tidak enak pada mulutnya terutama pada awal masa kehamilan. Rasa asam pada mulut yang terjadi pada wanita hamil dapat terjadi karena mual dan muntah yang menyebabkan asam lambung naik hingga ke rongga mulut sehingga kadar asam di dalam mulut meningkat (Hemalatha et al., 2013)

Rasa mual menyebabkan ibu hamil malas untuk menyikat gigi karena menyikat gigi cenderung memicu rasa mual, hal tersebut dapat menyebabkan oral hygiene ibu hamil memburuk. Ibu hamil juga mempunyai kebiasaan mengonsumsi makanan manis atau asam. Kebiasaan ini biasanya timbul untuk memenuhi rasa ngidam atau untuk mencegah terjadinya mual dan muntah. Kebiasaan mengonsumsi makanan manis dan asam dapat meningkatkan

produksi asam dan bakteri dan semakin menurunnya pH saliva (Karnik et al., 2015).

Penurunan pH saliva terjadi karena peningkatan enzim amilase dalam saliva. Enzim amilase merupakan protein terpenting dalam saliva yang dikeluarkan oleh kelenjar saliva parotid. Enzim amilase ini biasanya meningkat pada usia kehamilan 10 dan 21 minggu. Peningkatan kadar enzim ini dapat menurunkan pH saliva dan meningkatkan proses dekomposisi karbohidrat menjadi gula sederhana yang merupakan nutrisi baik untuk berkembangnya bakteri kariogenik sehingga meningkatkan risiko terjadinya karies. (Kamate et al., 2017) pH dan kapasitas buffer saliva mencapai titik terendah pada usia kehamilan trimester III. pH dan kapasitas buffer saliva berperan penting dalam menjaga stabilitas email. Penurunan pH saliva akan mempermudah terjadinya pengikisan email gigi dan meningkatkan pembentukan bakteri yang menyebabkan karies gigi seperti *Streptococcus mutans* yang dapat meningkatkan risiko perkembangan karies. Dimana periode trimester III dan awal postpartum memiliki resiko yang lebih tinggi (Karnik et al., 2015)

2. Gingivitis kehamilan (*pregnancy gingivitis*).

Perubahan gingiva ini biasanya mulai terlihat sejak bulan kedua dari kehamilan dan mencapai puncaknya pada bulan kedelapan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya hormon sex wanita dan vaskularisasi gingival sehingga memberikan respon yang berlebihan terhadap factor iritasi lokal. Dalam hal ini faktor iritasi lokal dapat berupa rangsangan lunak, yaitu plak bakteri dan sisa-sisa makanan, maupun berupa rangsang keras seperti kalkulus, tepi restorasi yang tidak baik, gigi palsu dan permukaan akar yang kasar. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan bukanlah menjadi penyebab langsung dari gingivitis kehamilan, tetapi juga tergantung pada tingkat kebiasaan kebersihan mulut pasien. Kenaikan jumlah estrogen dan progesteron pada masa kehamilan mempengaruhi rongga mulut (gingiva) yang secara mikroskopis terlihat adanya peningkatan proliferasi kapiler, dilatasi pembuluh darah, kenaikan permeabilitas vaskular, edema, infiltrasi, leukosit, degenerasi jaringan ikat sekitar serta proliferasi dan degenerasi sel-sel epitelium. Secara klinis, gingivitis kehamilan ditandai dengan warna merah pada tepi gingiva dan papilla interdental. Pada waktu yang sama, gingiva membesar, disertai pembengkakan yang terutama menyerang papilla interdental. Gingiva memperlihatkan kecenderungan yang meningkat terhadap pendarahan terutama pada saat menyikat gigi. Kadang-kadang penderita mengalami sedikit rasa sakit

Gingivitis merupakan reaksi inflamasi dari gingiva yang disebabkan oleh faktor iritasi lokal di sepanjang gingival margin atau daerah garis gingiva. Adanya

faktor iritasi lokal yang berupa rangsangan lunak yaitu plak, bakteri dan sisa makanan maupun berupa rangsangan keras seperti karang gigi, tepi tambalan gigi yang tidak baik, gigi palsu dan permukaan akar yang kasar (Hidayati et al., 2012) Radang gusi merupakan masalah gigi dan mulut yang sering terjadi pada ibu hamil. Kehamilan dapat memperberat gingivitis yang biasa dikenal dengan pregnancy gingivitis atau radang gusi selama kehamilan, radang gusi ini disebabkan oleh perubahan hormonal yaitu peningkatan hormon progesteron dan estrogen yang biasa terjadi selama masa kehamilan. Hormon inilah yang dapat merangsang pembentukan prostaglandin pada gingiva ibu hamil. Selain itu penyebab gingivitis pada ibu hamil karena adanya respon inflamasi yang berlebih dari gingiva oleh karena akumulasi plak. Buruknya kebersihan gigi dan mulut ibu hamil juga menjadi penyebab utama gingivitis sehingga memudahkan terjadinya iritasi pada gingiva oleh enzim dan toksin bakteri yang terkandung dalam plak.(Lei et al., 2019b) Bila peradangan pada gusi semakin parah, gusi menjadi membesar dan bengkak (inflamasi) dan perlahan jaringan ikat pada gusi lepas dari gigi dan gigi mudah goyang. Perbesaran gusi pada ibu hamil disebut gingivitis gravidarum (pregnancy gingivitis) ((Senjaya et al., 2020)).

Meskipun epulis gravidarum tidak terlalu berbahaya tetapi tidak menutup kemungkinan akan membuat keadaan rongga mulut ibu hamil semakin tidak sehat. Ibu hamil yang menderita epulis gravidarum harus segera diberikan penanganan yang sesuai disamping penanganan mengenai gingivitis. Karena bisa dipastikan bahwa ibu hamil yang menderita epulis gravidarum diakibatkan oleh gingivitis yang meluas, dalam keadaan seperti itu pemberian pemahaman mengenai penanganan kondisi rongga mulut ibu hamil harus diberikan secara detail agar ibu hamil memahami bahwa kesehatan rongga mulut penting untuk tumbuh kembang janin yang dikandungnya (Rahmawati & Mayong, 2017).

3. Tumor kehamilan (*pregnancy tumor*).

Kehamilan dapat pula menimbulkan suatu pembentukan pertumbuhan pada gingiva seperti tumor. Istilah yang digunakan untuk keadaan ini adalah pregnancy tumor atau tumor kehamilan, epulis gravidarum ataupun granuloma kehamilan. Gambaran perubahan rongga mulut yang paling spesifik pada masa kehamilan adalah perluasan dari gingivitis serta munculnya epulis gravidarum (*pregnancy epulis*). *Epulis Gravidarum* merupakan tumor kehamilan yang berbentuk seperti nodul yang muncul pada gusi yang ditandai dengan lesi berwarna merah cerah dan banyak vaskularisasi yang kadang memiliki flek putih di permukaannya, biasanya bertangkai, lunak, kemerahan dan dapat mencapai diameter 2 cm, serta tidak menimbulkan rasa sakit sehingga tidak menimbulkan keluhan berarti selain karena ukurannya. Meskipun dapat timbul pada setiap

lokasi di gingiva, epulis gravidarum kebanyakan timbul di antara gigi, dan umumnya lebih sering di daerah yang berhadapan dengan bibir pada rahang atas. Gigi yang berdekatan dengan epulis dapat bergeser dan menjadi lebih mudah goyang, namun tidak sampai menyebabkan kerusakan tulang penyangga gigi yang berdekatan dengan epulis (Souliissa, 2014). Interaksi antara bakteri dan hormon pada masa kehamilan menimbulkan perubahan pada komposisi plak dan menyebabkan peradangan gingiva. Kondisi ini diakibatkan oleh progesteron yang menghambat aktivitas enzim yang mengatasi hidrolisis kolagen (kolagnase) yang menyebabkan akumulasi dari kolagen sehingga muncul pembengkakan dan meningkatkan aliran pembuluh darah (Wijaksana, 2019). Selain itu penyebab timbulnya epulis gravidarum adalah gingivitis yang tidak diobati yang akan berkembang menjadi granuloma, didukung dengan kebersihan rongga mulut yang kurang. Apabila kondisi rongga mulut tidak diperhatikan dengan tentunya granuloma ini akan meluas (Akbar et al., 2016). Epulis Gravidarum ini biasanya terjadi pada trimester kedua dan dapat tumbuh lebih dari diameter 2 cm. Epitel yang menutupi lesi ini sangat tipis dan pada area jaringan lunak pada gingiva yang kehilangan lapisan epitel (ulserasi), protein yang dikeluarkan oleh pembuluh darah karena peradangan dan membeku (eksudat fibrin) akan menutupinya. Epulis Gravidarum akan sembuh spontan setelah masa kehamilan namun jika epulis ini mengganggu fungsi rongga mulut maupun estetika, dapat dilakukan eksisi atau pengangkatan jaringan dengan pembedahan dengan anestesi lokal pada masa kehamilan. Namun pada saat eksisi dilakukan akan menimbulkan pendarahan berlebih akibat kondisi pembuluh darah yang mudah berdarah ((Wijaksana, 2019)).

D. Dampak kehamilan terhadap kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil dan dampak gangguan kesehatan gigi dan mulut terhadap kehamilan

1. Ibu hamil mengalami perubahan hormon baik itu progesteron maupun estrogen. Dampak dari perubahan hormon kehamilan itu dapat mempengaruhi kesehatan mulut dan gigi, contoh ibu hamil trimester pertama sering muntah dan kelebihan air liur, rasanya ingin meludah terus menerus. Bila tidak rajin kumur dan menggosok gigi maka kuman dan bakteri penyakit mudah tumbuh, bau mulut (halitosis) dan jamur atau sariawan pada rongga mulut.
2. Peningkatan resiko terjadinya pembengkakan gusi maupun perdarahan pada gusi. Hal ini karena terjadi pelunakan dari jaringan daerah gusi akibat peningkatan hormon. kadang timbul benjolan - benjolan berwarna bengkak kemerahan pada gusi, dan gusi mudah berdarah

3. Terganggu kenyamanan dan kurang istirahat akibat sering sakit gigi dan ngilu. Pada saat hamil kondisi gigi yang mengalami caries akan bertambah parah akibat penyerapan kalsium dari tubuh ibu hamil yang dibutuhkan bayi untuk proses pertumbuhan.
4. Ibu hamil dengan keadaan gigi yang rusak cukup parah akan merangsang keluarnya hormon prostaglandin. Hormon bersifat merangsang timbulnya kontraksi pada rahim. Bila terus menerus rahim berkontraksi maka kelahiran prematur bahkan keguguran dapat terjadi.
5. Infeksi pada gigi ibu hamil dapat menginfeksi janin dalam kandungan. Menurut hasil penelitian dari *Journal Of Obstetrics Gynecology*, Yiping Han peneliti dari Case Western Reserve University tahun 2010, melaporkan ibu yang gusinya terinfeksi dapat menularkan infeksi pada janin melalui peredaran darah plasenta. Pada kasus yang diteliti ini terbukti kuman *Fusobacterium nucleatum* yang menginfeksi gusi ibu ditemukan dalam tubuh janin dan mengakibatkan keguguran. Sementara itu North Carolina menemukan fakta bahwa Bakteri *Streptococcus mutans* yang merupakan penyebab gigi berlubang dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah, dan selanjutnya dapat mencapai jantung dan menyebabkan gangguan pada jantung ibu hamil. (Wihardja & Tono Djuwantono, 2021)

E. Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut Selama Kehamilan

Perubahan fisiologis selama kehamilan dapat menyebabkan perubahan pada kondisi rongga mulut ibu hamil. Perubahan ini akan memicu masalah kesehatan gigi selama kehamilan seperti karies, radang gusi, mobilitas gigi, erosi gigi, periodontitis, dan penyakit kesehatan gigi dan mulut lainnya. Penyakit gigi ini bisa disebabkan oleh respons imun yang berubah atau dikaitkan dengan stress dan kecemasan selama kehamilan, mengakibatkan ibu hamil tidak begitu memperhatikan kebersihan mulut dan menyebabkan terjadinya kerusakan pada mulut ibu hamil itu sendiri. Karena ibu hamil mempunyai resiko yang besar terjadinya karies gigi, karena berbagai faktor baik dari perubahan saliva dan flora mulut, muntah, kebersihan mulut yang kurang, nutrisi yang terabaikan dan perhatian yang tidak memadai terhadap kesehatan gigi dan mulut. Maka beberapa hal yang dianjurkan bagi ibu hamil untuk mencegah terjadinya kerusakan gigi yaitu dengan membatasi mengonsumsi makanan yang manis, menggosok gigi secara teratur dengan pasta gigi yang mengandung fluoride, kumur dengan larutan garam apabila mual dan muntah untuk mencegah pengikisan email yang disebabkan karena muntah. Melakukan topikal apikasi dengan fluoride pada gigi yang belum berlubang untuk mencegah terjadinya karies. Menghindari penggunaan obat-obatan metamfetamin

karena dapat memperburuk kerusakan gigi. (Naseem et al., 2016). Gingivitis selama kehamilan dapat di kelola dengan cara, tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut, menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride secara teratur, menggunakan obat kumur yang dapat membantu meredakan iritan seperti obat kumur chlorhexidine. Konsumsi Vitamin C, Kalsium dan Fosfor juga dapat mengurangi peradangan (Yenen & Ataçağ, 2019)

Wanita hamil rentan terhadap berbagai kondisi kesehatan mulut yang dapat membahayakan kesehatan mereka sendiri dan masa depan bayinya. Kesehatan gigi dan mulut menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh ibu hamil. Selama kehamilan terjadi perubahan pada rongga mulut terkait dengan perubahan hormonal, perubahan pola makan, perubahan perilaku dan berbagai keluhan seperti ngidam, mual dan muntah. Sebelum membahas tentang hal yang harus diperhatikan tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan, ada beberapa **mitos** tentang keamanan perawatan gigi selama kehamilan. Akibatnya, wanita hamil menerima perawatan gigi yang lebih sedikit dibandingkan saat mereka tidak hamil.

Beberapa mitos berkaitan Kesehatan ibu selama kehamilan yang mempengaruhi pertumbuhan gigi anak setelah dilahirkan ((Diyah Fatmasari, 2022)

1. Ibu hamil tidak boleh cabut gigi. Jika seorang ibu hamil mengalami sakit gigi yang sangat mengganggu, tindakan pencabutan gigi bisa dilaksanakan di kehamilan trimester kedua. Pada trimester awal, pembentukan janin masih terjadi, kemungkinan belum terjadi maturitas, sedangkan pada trimester ketiga kemungkinan ibu hamil akan mengalami kesulitan untuk duduk di dental unit.
2. Ibu hamil tidak boleh minum antibiotic Sebaiknya mengkonsumsi obat-obatan dibatasi dan dilakukan seleksi ketat dalam pemilihan jenis obat jika memang ibu hamil membutuhkan pengobatan untuk mengurangi sakit gigi.
3. Ibu hamil tidak boleh merawat gusi Perawatan gusi bahkan menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh ibu hamil.
4. Ibu hamil tidak boleh memakai pasta gigi Pasta gigi untuk menyikat gigi menjadi bagian yang penting digunakan bagi ibu hamil, jika perlu agar merasa nyaman dalam menyikat gigi pilih pasta gigi yang segar sehingga akan mengurangi rasa mual.
5. Ibu hamil pasti akan kehilangan 1 gigi jika sudah melahirkan Ibu hamil yang tidak memperhatikan keadaan kebersihan giginya ada kemungkinan akan berpengaruh terhadap kesehatan gigi sehingga akan menjadi gangren sehingga harus di cabut giginya. Proses gigi menjadi gangren sehingga harus di cabut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga

Tidak ada patokan yang pasti tentang usia kandungan dalam merawat gigi ibu. Merawat gigi ibu harus sudah dilakukan jauh hari sejak sebelum menikah, bahkan idealnya, kebiasaan merawat gigi sudah dilakukan sejak masih kanak-kanak. Cara merawat gigi ibu hamil, yaitu:

1. Gunakan sikat gigi yang lembut dengan ukuran yang sesuai, mengingat selama kehamilan gusi lebih rentan, gunakan sikat gigi yang lebih lembut bulu sikatnya
2. Sikat gigi dengan cara yang benar dan rutin. Gosoklah gigi dengan hati-hati, paling tidak 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride
3. Gunakan *dental floss* untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi, dan jangan menggunakan tusuk gigi karena berisiko menimbulkan luka dan infeksi
4. Setelah menyikat gigi dengan baik, kumurlah dengan obat kumur yang mengandung antiseptik, sesuai aturan
5. Bila gusi terasa tidak nyaman, misalnya sedikit membengkak, cobalah untuk berkumur dengan air es
6. Pola makan yang benar. Penuhi kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi. Sedapat mungkin, hindari atau kurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis-manis
7. Serta lakukan pemeriksaan ke dokter gigi secara berkala.

F. Simpulan

Kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan memiliki peran yang sangat krusial, baik bagi ibu maupun bayi yang dikandung. Perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah gigi dan gusi, seperti gingivitis dan karies. Jika tidak diatasi dengan baik, kondisi ini dapat berdampak buruk, mulai dari meningkatkan risiko kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan rendah hingga meningkatkan risiko infeksi pada ibu dan bayi

Oleh karena itu, perawatan gigi dan mulut yang baik selama kehamilan sangat penting. Kunjungan rutin ke dokter gigi, teknik menyikat gigi yang benar, penggunaan benang gigi, dan pemilihan pasta gigi yang tepat merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Selain itu, menjaga pola makan yang sehat dan menghindari makanan serta minuman manis juga sangat penting.

Periksa gigi secara rutin: Ibu hamil sangat dianjurkan untuk memeriksakan gigi secara rutin selama kehamilan, minimal dua kali. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini masalah gigi dan gusi serta mendapatkan perawatan yang tepat.

Tingkatkan edukasi: Perlu adanya peningkatan edukasi kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, leaflet, atau media sosial. Tujuannya adalah agar ibu hamil memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut serta mengetahui cara merawatnya

dengan benar. Kolaborasi: Perlu adanya kerjasama yang baik antara dokter gigi dan dokter kandungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan perawatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Dengan perawatan yang tepat, ibu hamil dapat menjaga kesehatan gigi dan mulutnya serta memberikan yang terbaik bagi tumbuh kembang janinnya.

G. Referensi

- Akbar, F. H., Pratiwi, R., & Multazam, A. (2016). Hubungan status karies gigi dengan kualitas hidup terkait kesehatan mulut anak usia 8-10 tahun. *Pros Balidental Sci Exhib*, 242–254.
- ANJANI, A. D. W. I., SUNESNI, S. S., & AULIA, D. L. N. (2022). *Pengantar Praktik Kebidanan*. Cv Pena Persada.
- Budiarti, I., & Suja, M. D. D. (2023). PREGNANCY GINGIVITIS TERHADAP BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR): STUDI LITERATUR. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 5374–5381.
- Diyah Fatmasari, S. R. S. (2022). *buku kesehatan gimul ibuhamil*. 1–98.
- Habib, I. S. A., Wihardja, R., & Kintawati, S. (2019). Perbedaan pH saliva antara wanita hamil dan tidak hamil. *J Ked Gi Unpad. April 2019; 31 (1): 37, 42, 38*.
- Hemalatha, V. T., Manigandan, T., Sarumathi, T., & Amudhan, A. (2013). Dental considerations in pregnancy-a critical review on the oral care. *Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR*, 7(5), 948.
- Hidayati, H., Kuswardani, K., & Rahayu, G. (2012). Pengaruh kebersihan gigi dan mulut dengan status gingivitis pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang tahun 2012. *Majalah Kedokteran Andalas*, 36(2), 215–224.
- Kamate, W. I., Vibhute, N. A., & Baad, R. K. (2017). Estimation of DMFT, salivary streptococcus mutans count, flow rate, Ph, and salivary total calcium content in pregnant and non-pregnant women: A prospective study. *Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR*, 11(4), ZC147.
- Karnik, A. A., Pagare, S. S., Krishnamurthy, V., Vahanwala, S. P., & Waghmare, M. (2015). Determination of salivary flow rate, pH, and dental caries during pregnancy: A study. *Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology*, 27(3), 372–376.
- Kemenkes RI. (2012). *pedoman PKM Gimul 2012*.
- Kemenkes RI. (2019). *Laporan Riskesdas 2018 Nasional*.

- Lei, P. F., Krisyudhanti, E., Ngadilah, C., & Obi, A. L. (2019a). Status karies gigi, status kebersihan gigi dan mulut dan status gingivitis ibu hamil trimester I dan II. *Dental Therapist Journal*, 1(1), 28–38.
- Lei, P. F., Krisyudhanti, E., Ngadilah, C., & Obi, A. L. (2019b). Status karies gigi, status kebersihan gigi dan mulut dan status gingivitis ibu hamil trimester I dan II. *Dental Therapist Journal*, 1(1), 28–38.
- Lydon-Rochelle, M. T., Krakowiak, P., Hujoel, P. P., & Peters, R. M. (2004). Dental care use and self-reported dental problems in relation to pregnancy. *American Journal of Public Health*, 94(5), 765–771.
- Naseem, M., Khurshid, Z., Khan, H. A., Niazi, F., Zohaib, S., & Zafar, M. S. (2016). Oral health challenges in pregnant women: Recommendations for dental care professionals. *The Saudi Journal for Dental Research*, 7(2), 138–146.
- Nazir, M. A. (2017). Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention. *International Journal of Health Sciences*, 11(2), 72.
- Santoso, O., SR, W. A., & Retnoningrum, D. (2009). Hubungan Kebersihan Mulut dan Gingivitis Ibu Hamil Terhadap Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah Kurang Bulan di RSUP Dr. Kariadi Semarang dan Jejaringnya (The association between maternal oral hygiene and gingivitis to preterm low birth weight in Dr. Kariadi Hospital Semarang). *Media Medika Indonesiana*, 43(6), 288–293.
- Senjaya, A. A., Arini, N. W., Ratmini, N. K., & Handayani, N. K. A. S. S. (2020). Hubungan Sextan Yang Mengalami Gingivitis Dengan Usia Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Manggis Ii Kabupaten Karangasem Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Gigi (Dental Health Journal)*, 7(2), 53–58.
- Soulissa, A. G. (2014). Hubungan kehamilan dan penyakit periodontal. *Jurnal Pdgi*, 63(3), 72.
- Wihardja, D. R., & Tono Djuwantono, S. K. (2021). *Kesehatan Gigi dan Rongga Mulut Pada Masa Kehamilan*. CV Ciptakarya Paramacitra.
- Wijaksana, I. K. E. (2019). Dental Treatment Consideration in Pregnant Women. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 6(2), 118–125.
- Yenen, Z., & Ataçağ, T. (2019). Oral care in pregnancy. *Journal of the Turkish German Gynecological Association*, 20(4), 264.

H. Glosarium

Epulis gravidarum (*pregnancy epulis*): tumor kehamilan yang berbentuk seperti nodul yang muncul pada gusi yang ditandai dengan lesi berwarna merah cerah dan banyak vaskularisasi yang kadang memiliki flek putih.

Halitosis: bau mulut

Gingivitis: Peradangan pada gusi yang ditandai dengan gusi bengkak, merah, dan mudah berdarah. Kondisi ini sering terjadi pada ibu hamil akibat perubahan hormon.

Plak: Lapisan lengket yang menempel pada gigi dan mengandung bakteri. Plak merupakan penyebab utama gingivitis dan penyakit periodontal

Kalkulus (karang gigi): Plak yang sudah mengeras dan menempel kuat pada permukaan gigi. Kalkulus dapat menyebabkan peradangan gusi yang lebih parah.

Kalkulus (karang gigi): Plak yang sudah mengeras dan menempel kuat pada permukaan gigi. Kalkulus dapat menyebabkan peradangan gusi yang lebih parah.

Periodontal: Berkaitan dengan jaringan penyangga gigi, seperti gusi dan tulang alveolar. Penyakit periodontal adalah infeksi pada jaringan penyangga gigi.

Stomatitis: Peradangan pada lapisan mulut, termasuk lidah, pipi bagian dalam, dan langit-langit mulut.

Mual dan muntah: Kondisi yang sering dialami ibu hamil, terutama pada trimester pertama. Asam lambung yang naik ke mulut dapat merusak email gigi.

Scaling: Prosedur pembersihan gigi yang lebih dalam untuk menghilangkan kalkulus yang sudah menempel di bawah garis gusi.

Root planing: Prosedur menghaluskan permukaan akar gigi untuk menghilangkan bakteri dan mencegah terbentuknya kembali kalkulus.

Rontgen gigi: Pemeriksaan penunjang untuk melihat kondisi gigi dan jaringan penyangga gigi dari dalam.

Ibu hamil: Wanita yang sedang mengandung janin.

Trimester: Periode kehamilan yang dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing terdiri dari tiga bulan.

Hormon: Zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh.

Email gigi: Lapisan terluar gigi yang berfungsi melindungi bagian dalam gigi.

Dentin: Lapisan di bawah email gigi yang berwarna kekuningan.

Pulpa: Bagian terdalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah.

Ngidam: Keinginan kuat untuk mengonsumsi makanan tertentu. Beberapa makanan yang sering menjadi objek ngidam dapat berdampak buruk pada kesehatan gigi.

Fluorosis: Perubahan warna pada email gigi akibat paparan fluoride yang berlebihan saat pembentukan gigi.

Prophylaxis: Prosedur pembersihan gigi secara profesional untuk menghilangkan plak dan kalkulus.

CHAPTER 9

MANAJEMEN NYERI DAN KETIDAKNYAMANAN SELAMA KEHAMILAN

Aida ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Setiap wanita hamil mengharapkan kesehatan yang paripurna selama menjalani fase kehamilannya. Namun, seiring perubahan fisiologi dan psikologi pada wanita hamil, ia mungkin mengalami ketidaknyamanan fisik tertentu. Jumlah dan kualitas keluhan serta tingkat keparahan gejala yang mungkin dialami setiap wanita bervariasi (Biringer, 1988). Kehamilan dan kelahiran merupakan suatu peristiwa yang normal dan sehat yang dijalani oleh Wanita. Meskipun bugar secara fisik belum menjamin persalinan akan berjalan dengan mudah. Meskipun seorang ibu hamil melakukan aktivitas ringan pada saat berdiri maupun bergerak dengan benar, sakit dan nyeri tetap umum terjadi. Seiring berjalannya waktu kehamilan akan menimbulkan ketidaknyamanan karena adanya perubahan secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perasaan jengkel, dan khawatir. Kebanyakan ketidaknyamanan dialami selama kehamilan dianggap sebagai akibat dari perubahan hormon. Ketidaknyamanan dikaitkan dengan perubahan fisik yang terkait dengan memperbesar rahim. Dalam perkembangan normal kehamilan, banyak gejala yang dialami. Gejala fisik yang berhubungan dengan kehamilan mungkin berdampak negatif pada kualitas hidup ibu hamil. Namun, ibu hamil menghindari penggunaan obat karena takut obat yang digunakan dapat berdampak buruk pada janin. Oleh karena itu, mereka mempraktikkan metode nonfarmakologis untuk membantu mereka mengelola gejala fisik terkait kehamilan (Nazik & Eryilmaz, 2014).

Pertumbuhan rahim yang membesar menghasilkan tekanan, ketegangan, dan peregangan pada ligamen pendukung. Kejang yang tajam dan menyakitkan yang disebut "nyeri ligamen" dapat terjadi ketika ligamen tegang. Nyeri dapat digambarkan sebagai nyeri akut (tiba-tiba dan parah) seperti nyeri yang disebabkan oleh cedera atau infeksi, atau nyeri kronis (berlangsung selama lebih dari 3 bulan) seperti nyeri akibat penyakit medis seperti artritis reumatoid. Nyeri yang berhubungan dengan kehamilan juga dapat terjadi. Pengobatan nyeri tanpa menggunakan obat-obatan harus dicoba terlebih dahulu (Black et al., 2019).

B. Nyeri Fisiologis yang Bisa Terjadi pada Kehamilan

Selama kehamilan, beberapa perubahan anatomi dan fisiologis terjadi dalam tubuh. Perubahan ini dapat memicu nyeri, yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kecacatan. Selain itu, kondisi hamil dapat memperburuk kondisi nyeri yang sudah ada sebelumnya. Kondisi nyeri selama kehamilan dapat dikelompokkan lebih lanjut ke dalam klasifikasi berbasis sistem seperti sindrom nyeri muskuloskeletal, reumatologi, neuropatik, dan pelvis-abdominal (Shah et al., 2015). Nyeri fisiologis yang dapat terjadi pada kehamilan

1. Nyeri Pada awal Kehamilan

Kebanyakan ibu hamil akan merasakan nyaman pada awal masa kehamilannya, beberapa wanita mengalami rasa sakit seperti nyeri haid, walaupun demikian belum tentu itu merupakan pertanda buruk, rasa ini menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Rasa nyeri yang sangat pada awal masa kehamilan dapat menimbulkan kondisi patologis oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan yang tepat untuk dapat segera ditangani oleh tenaga kesehatan (Byrom et al., 2019).

2. Nyeri Ligamen, Panggul dan Punggung Bawah

Nyeri ligamen, nyeri panggul, dan nyeri punggung bawah hanyalah dua dari sekian banyak keluhan muskuloskeletal yang dialami ibu hamil. Ada banyak pendekatan nonfarmakologis yang dapat dipertimbangkan yaitu :

- a. Yoga prenatal dapat sangat menenangkan tubuh ibu hamil, dan pose (asana) sering kali dapat disesuaikan dengan keluhan tertentu
- b. Meminta ibu untuk memiringkan panggul ke depan dan ke belakang sambil berdiri dapat meredakan ketidaknyamanan ligamen.
- c. Ibu juga dapat merangkak di lantai. Kemudian, mereka melengkungkan dan merelaksasikan punggung secara berirama untuk meredakan nyeri punggung bawah. Ini dikenal sebagai urutan pose kucing-sapi dalam yoga.
- d. Pijat prenatal bersifat menenangkan dan dapat meredakan ketegangan dan kejang otot. Pasien harus diarahkan ke terapis pijat yang secara khusus dilatih untuk menangani wanita hamil, karena titik pijat tertentu dapat merangsang kontraksi rahim.
- e. Wanita harus berkonsultasi dengan praktisi yang berpengalaman, Akupunktur, olahraga, Terapi Kraniosakral, dan sabuk panggul juga efektif untuk nyeri punggung bawah dan panggul (Liddle SD, 2015)
- f. Terapi Fisik Prenatal dapat berperan dalam pencegahan nyeri panggul dan punggung bawah (Bergamo TR, Latorraca COC, Pachito DV, Martimbianco ALC, 2018)

C. Manajemen Nyeri melalui Relaksasi selama Kehamilan

Menikmati relaksasi selama kehamilan dan menjelang persalinan merupakan hal yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang bisa saja mengalami ketegangan atau nyeri yang masih bersifat fisiologis. Relaksasi dapat melepaskan ketegangan dan membuat ibu merasa nyaman. Relaksasi ini perlu dilatih selama hamil karena sangat diperlukan untuk pengendalian diri selama proses melahirkan. Serviks akan membuka lebih lancar dan uterus akan bekerja lebih baik. Relaksasi ini akan meningkatkan rasa percaya diri pada ibu hamil menjelang proses persalinan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketegangan sebagai berikut (Stela Kitzinger, 1996).

1. Duduk atau berbaring dengan banyak bantal

Duduk atau berbaring dengan di sangga oleh banyak bantal, dalam posisi apapun yang dapat membuat ibu hamil rileks atau nyaman untuk tertidur. Bagian pinggul dan leher harus tersangga dengan baik, bahu membulat, dan kepala sedikit turun ke depan seperti bunga di tangkainya. Kemudian Tarik bahu ke bawah, rasakan tarikan ke belakang leher, dan biarkan untuk kembali ke posisinya dengan mudah. Biarkan otot otot leher untuk mengendur, rahang turun dan hanya mendengarkan bunyi nafas. Ibu diminta untuk terus bernafas dengan lambat dan penuh, pikirkan semua bagian tubuh yang berbeda dan biarkan setiap ketegangan mengalir keluar dari bagian tubuh tersebut yaitu lengan, kaki, paha, bokong, perut, otot otot sekitar mata dan mulut sampai semua bagian tubuh. Maka ibu hamil bisa menikmati perasaan tenang saat ketegangan otot semua terlepas.

2. Sentuhan dan masase bahu dan punggung bawah

Masase dapat menjadi pengalaman sensual yang mendalam, membantu menyimpan energi dan percaya diri untuk yang akan terjadi kemudian. Masase abdomen dilakukan dengan lembut, saat tubuh rileks maka ketegangan mengalir keluar dari pusat tubuh mengarah ke perifer dan otot otot di dekat permukaan kulit dan akan menghilang. Tangan pemijat dapat menolong hal ini dengan memberikan gerakan menekan ke bawah dan keluar, dan membuat tekanan perlahan ke atas dan ke bawah.

3. Sentuhan dan masase lengan

Pemijatan pada lengan dapat dilakukan dengan menyangga lengan pada pergelangan, keluarga / suami dapat melakukan masase otot-otot dari lengan atas dalam dengan lambat dan lembut. Teknik memijat dapat dilakukan dengan :

- a. Selalu memijat dengan tangan dan lengan yang rileks
- b. Pijatlah dengan lambat, dengan mengikuti bentuk tubuh

- c. Gunakan tekanan kuat di punggung, dan jika memijit di bagian abdomen maka gunakan tekanan ringan (mengusap)
- d. Ketika menggunakan sentuhan kuat jangan tegangkan otot-otot lengan, tetapi biarkan berat dari punggung atas untuk mengalir ke lengan yang relaks ke bawah ke bagian tubuh yang dipijat.

D. Ketidaknyamanan Sesuai Dengan Usia Kehamilan

Banyaknya perubahan endokrin dan hormonal mulai terjadi pada saat pembuahan, tahap perkembangan janin, dan puncaknya pada saat melahirkan. Beberapa ketidaknyamanan bisa terjadi berbeda pada ibu hamil satu dengan yang lainnya.

Tabel 8.1 Timeline Ketidaknyamanan Selama Kehamilan

Trimester I (0-14 minggu)	Trimester 2 (15-28 minggu)	Trimester 3 (29-42 minggu)
1. <i>Breast Tenderness</i> 2. Perubahan kulit 3. Mual di pagi hari 4. Peningkatan frekuensi buang air kecil 5. Kelelahan 6. Sakit punggung 7. Sakit kepala 8. Nyeri ligamen 9. Hidung tersumbat 10. Gusi berdarah 11. Perubahan suasana hati 12. Ambivalensi 13. Sifat lekas marah 14. Depresi 15. Mengubah citra tubuh 16. Rasa takut 17. Peningkatan sensitivitas 18. Keragu-raguan 19. Meningkat atau menurunnya hasrat seksual	1. Perubahan kulit 2. Sakit punggung 3. Sakit kepala 4. Sembelit 5. Pingsan/pusing 6. Maag 7. Sesak napas 8. Nyeri ligamen 9. Varises 10. Edema pergelangan kaki 11. Pertambahan berat badan 12. Kram kaki 13. Peningkatan gerakan janin 14. Hidung tersumbat 15. Gusi berdarah 16. Peningkatan keputihan 17. Perubahan suasana hati 18. Sifat lekas marah 19. Depresi 20. Mengubah citra tubuh 21. Rasa takut 22. Peningkatan sensitivitas 23. Keragu-raguan 24. Meningkat atau menurunnya hasrat seksual	1. Sedikit mual 2. Peningkatan frekuensi buang air kecil 3. Kelelahan 4. Sakit punggung/pinggul 5. Sakit kepala 6. Sembelit 7. Maag 8. Dispnea 9. Nyeri ligamen 10. Pembuluh mekar 11. Edema pergelangan kaki 12. Pertambahan berat badan 13. Kram kaki 14. Gerakan janin 15. Wasir 16. Hidung tersumbat 17. Gusi berdarah 18. Peningkatan keputihan 19. Perubahan suasana hati 20. Sifat lekas marah 21. Kecemasan 22. Depresi 23. Insomnia 24. Mengubah citra tubuh 25. Rasa takut

		26. Peningkatan sensitivitas 27. Keragu-raguan 28. Meningkat atau menurunnya hasrat seksual
--	--	---

Sumber : (Davis, 1996)

E. Ketidaknyamanan Umum dan Tindakan Mendapatkan Kenyamanan Selama Kehamilan

Beberapa ketidaknyamanan akan muncul selama kehamilan. Berikut beberapa ketidaknyamanan yang bisa terjadi dan cara mengatasinya :

1. Mual dan Muntah

Meskipun umumnya terjadi pada pagi hari, namun mual dapat terjadi kapan saja dan pada tahapan kehamilan manapun. Mual akan muncul sekitar minggu keenam dan mereda sekitar minggu ke-14 hingga ke-16. Terjadi pada sekitar 80% wanita karena gangguan gastrointestinal selama kehamilan (Biringir, 1988).

Penyebabnya tidak diketahui dengan pasti, walaupun ada beberapa teori terkait perubahan kadar hormon selama kehamilan. Mual ini dapat diatasi dengan :

- a. Makan makanan kecil atau camilan lebih sering
 - b. Minum cukup cairan untuk menghindari dehidrasi, bisa mencoba minum jus, sup, air mineral, dsb
 - c. Hindari makanan pemicu mual seperti makanan yang berlemak, pedas atau berbau menyengat
 - d. Hindari aktivitas yang tiba-tiba seperti melompat dari tempat tidur atau berlari ke kamar mandi dapat membuat merasa mual.
 - e. Istirahat yang cukup
- (Burnside Hospital, 2018)

2. Peningkatan Saliva

Terjadi pada trimester ke satu dan dapat berakhir pada saat kehamilan akhir. Pada ibu hamil terjadi peningkatan air liur/ saliva yang dapat meningkatkan rasa mual dan ketidaknyamanan. Tatalaksana dapat dengan mengunyah permen karet bebas gula, menggunakan obat kumur dan menjaga kebersihan mulut, menghindari makanan dengan kandungan pati / karbohidrat tinggi (Ellis, 2011)

3. Gusi Berdarah

Gusi berdarah atau epulis adalah pembengkakan pembuluh darah fokal pada gusi yang dapat kembali secara spontan setelah melahirkan. Epulis pada kehamilan dipengaruhi oleh hormon estrogen menyebabkan gusi menjadi hiperemis dan melunak yang dapat menyebabkan gusi mudah berdarah terutama pada saat menyikat gigi (Biringer, 1988). Epulis gravidarum pada kehamilan biasanya menyerang wanita hamil antara bulan ke-3 dan ke-9 kehamilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa frekuensi epulis gravidarum sebesar 4,38% pada ibu hamil. Terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok, usia muda, dan tidak menggunakan benang gigi dengan terjadinya epulis gravidarum. Oleh karena itu, ibu yang ingin hamil sebaiknya diberikan informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut selama masa kehamilan dan kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan janin. Disarankan pula untuk merujuk ibu hamil ke dokter gigi untuk mendapatkan saran yang diperlukan mengenai pencegahan dan perawatan gigi jika diperlukan (Moghadam & Ganji, 2019).

Cara mencegah dan mengurangi epulis :

- a. Kumur dengan air hangat yang ditambah garam
- b. Menjaga kebersihan mulut
- c. Periksa ke dokter gigi lebih sering saat hamil
- d. Konsumsi makanan dengan kandungan vitamin C

4. Sinkop

Pingsan saat hamil diakibatkan oleh perubahan hormon yang terjadi pada tubuh, dan terjadi jika otak tidak cukup darah yang mengandung oksigen. Jika tingkat oksigen rendah maka akan terjadi pingsan. Pingsan ini dapat terjadi saat berdiam terlalu lama, bangun terlalu cepat, bahkan kondisi bersandar pada punggung. Pingsan dapat dicegah dengan :

- a. Cobalah bangun perlahan setelah duduk atau berbaring
- b. Saat terasa pingsan pada waktu berdiam diri maka segera mencari tempat duduk terdekat
- c. Lakukan pemeriksaan haemoglobin / Hb pada fasilitas kesehatan terdekat (Byrom et al., 2019)

5. Perubahan Kulit dan Rambut

Perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan membuat puting susu dan area di sekitarnya menjadi gelap. Tanda lahir, tahi lalat dan bintik-bintik juga bagian kulit lainnya dapat lebih gelap. Beberapa wanita memiliki garis gelap dari pusar hingga ke ujung rambut kemaluan, terjadi pada 90% wanita (Freeman, 1980). Perubahan ini akan berangsur memudar setelah bayi lahir, walaupun area disekitar puting susu masih sedikit gelap.

6. Konstipasi

Hormon kehamilan dapat memperlambat otot-otot di usus yang menyebabkan sembelit pada sebagian wanita (Burnside Hospital, 2018). Beberapa hal yang dapat membantu :

- a. Minum 8-10 gelas air sehari
- b. Makan makanan yang mengandung serat misal buah, sayuran segar, roti gandum, sereal, kacang-kacangan.
- c. Berolahraga secara teratur
- d. Minum teh herbal hangat air putih saat bangun tidur akan membantu sistem pencernaan lebih aktif
- e. Jangan minum obat pencahar tanpa berkonsultasi dengan dokter atau bidan. (Burnside Hospital, 2018; Lapuente Villar, 1987)

7. Hemoroid

Hemoroid / wasir adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena di anus dan rektum bawah. Wasir bisa terjadi di dalam atau di luar tubuh dan kehamilan serta sembelit akan memperparah faktor risiko. Penurunan motilitas Gastro Intestinal sering kali menyertai peningkatan tekanan intra-abdomen yang terkait dengan kehamilan, sehingga menjadi masalah yang umum. Selain itu, pengaruh hormon yang sama juga memengaruhi pembuluh darah ini. Baik wasir maupun varises vulva dapat bengkak dan nyeri sehingga membuat duduk terasa tidak nyaman (Nyange, 2017). Penatalaksanaan yang dapat dilakukan :

- a. Diet tinggi serat, peningkatan asupan cairan dan olahraga
- b. Analgesik ringan dapat dikonsultasikan dengan dokter
- c. Anestesi lokal topikal, antiinflamasi
- d. Mandi air hangat dapat digunakan untuk mengurangi tonus sfingter atau memperbaiki kongesti vena

8. Rasa Panas selama hamil

Selama hamil tubuh akan terasa lebih hangat dari biasanya, hal ini karena perubahan hormon dan peningkatan suplai darah ke kulit. Ibu hamil mungkin juga akan lebih banyak berkeringat. Cara menghindari rasa panas dengan :

- a. Kenakan pakaian longgar terbuat dari serat alami
- b. Jaga agar ruangan tetap sejuk.
- c. bisa menggunakan kipas angin listrik untuk mendinginkannya.
- d. Sering-seringlah mencuci untuk membantu merasa segar

(Byrom et al., 2019)

9. *Heartburn* (Nyeri Ulu Hati)

Hormon kehamilan mereksasi otot-otot di tubuh termasuk otot yang menahan asam lambung. Hormon ini dapat memperlambat pencernaan, sehingga makanan bertahan di lambung lebih lama. Hasilnya adalah rasa kembung, rasa terbakar di dada, bersendawa, rasa penuh, mual, dan bahkan muntah. Beberapa makanan yang dapat dihindari jika mengalami rasa nyeri pada ulu hati yaitu :

- a. Makanan asam seperti saus tomat, jus jeruk, tomat
- b. Minuman berkafein seperti kopi dan teh
- c. Minuman berkarbonasi seperti soda atau air soda
- d. Cokelat dan pepermin
- e. Makanan berminyak dan gorengan
- f. Bawang merah dan bawang putih
- g. Makanan pedas

Untuk mencegah nyeri ulu hati lakukan hal di bawah ini :

- a. Hindari berbaring setelah makan
- b. Minumlah air putih sedikit-sedikit saat makan, dan lebih banyak air di antara waktu makan
- c. Tinggikan kepala saat tidur
- d. Menempatkan kepala lebih tinggi dari tubuh sejauh empat hingga enam inci dapat membantu
- e. Berhenti atau kurangi merokok
- f. Berjalan-jalan setelah makan. Ini dapat membantu pencernaan dan juga mengurangi stres, yang dapat memicu mulas.
- g. Cobalah lima atau enam kali makan kecil daripada makan besar

h. Kenakan pakaian longgar
(Belleza, 2017)

10. Sakit Punggung Bawah

Peningkatan kesadaran terkait postur yang benar selama hamil serta penggunaan gerak tubuh yang baik mengurangi regangan mekanis pada sendi, ligamen dan tendon yang mengalami perubahan menjadi kendur karena perubahan hormon. Posisi yang dapat mengurangi sakit punggung dapat dilakukan dengan

- a. duduk posisi tukang jahit (duduk dengan tungkai bersilang) adalah cara yang nyaman untuk menjaga agar punggung bawah rileks.
- b. Berjongkok juga dapat meredakan sakit punggung bawah.
- c. Penggunaan kompres panas, botol berisi air panas, atau mandi air panas atau mandi pancuran dapat membantu meredakan sakit akibat ketegangan otot.
- d. Mengangkat panggul dengan posisi merangkak akan meredakan sakit punggung bagian bawah dengan meregangkan otot punggung bagian bawah dan menguatkan otot perut

(Penny Simkin, 2007).

11. Sakit Punggung Atas

Untuk mencegah dan meredakan sakit punggung bagian atas, cobalah mengurangi ketegangan pada bahu, leher dan rahang. Beberapa cara yang dapat dilakukan dengan

- a. Memutar bahu berdiri atau duduk dengan punggung lurus, lengan rileks dan dagu tegak. Angkat bahu ke arah telinga dengan perlahan putar ke depan, ke bawah, ke belakang, dan ke atas sekali lagi.
- b. Meregangkan bagian atas tubuh dengan duduk dengan tungkai bersilang atau berdiri dengan lengan lurus dan menggantung di depan tubuh. Silangkan lengan pada siku, rasakan bagian atas punggung meregang. Sementara menarik nafas perlahan angkat lengan ke arah langit-langit dan dengan bertahap buka silangan tangan. Angkat badan ke atas sehingga bisa merasakan regangan pada seluruh tubuh bagian atas

(Penny Simkin, 2007).

12. Lengan Tangan Yang Kesemutan Atau Baal

Ketidaknyamanan ini biasanya dirasakan pada waktu pagi atau setelah bangun tidur. Gejala ini dapat dirasakan karena adanya tekanan cairan jaringan yang berlebih pada saraf dan pembuluh darah di tangan dan pergelangan tangan. Jika gejala ini terbatas pada tangan maka disebut sebagai "sindrom karpal tunnel", mengacu pada jalur sempit di bagian dalam pergelangan tangan yang dilalui saraf dan pembuluh darah menuju ke lengan. Jika gejala ini mengenai seluruh

lengan, kondisi tersebut disebut “sindrom thoracic outlet” mengacu pada ruang yang dilalui saraf dan pembuluh darah ke lengan. Tindakan berikut dapat mencegah atau mengobati gejala tersebut :

- a. Gunakan posisi dan bantal untuk berbaring miring tanpa menggunakan lengan untuk pendukung
- b. Lakukan latihan untuk meredakan sakit punggung bagian atas-memutar bahu dan meregangkan bagian atas tubuh.
- c. Beberapa kali sehari angkat satu lengan, dan regangkan ke atas. Gerakkan jari-jari sampai lima hitungan lambat. Turunkan lengan dan ulangi dengan lengan satunya.

(Penny Simkin, 2007)

13. Sakit Kaki Atau Bengkak Pergelangan Kaki

Ketidaknyamanan ini bisa mengganggu karena kaki yang sakit, bengkak pergelangan kaki dan tungkai kaki, atau varises, beberapa tindakan ini dapat meningkatkan peredaran darah :

- a. Berjalan, berenang, atau bersepeda statis beberapa kali seminggu
- b. Saat duduk dapat memutar pergelangan kaki dan jangan menyilangkan lutut, atau duduk dengan kaki ke atas.
- c. Lakukan latihan mengangkat panggul pada posisi merangkak
- d. Berlatih berenang di dalam air selama 1 jam setiap dua hari sekali
- e. Gunakan stoking penopang, pakailah stoking ini sebelum bangun dari tempat tidur karena ini saatnya dimana jumlah pembengkakan adalah paling kecil.

(Penny Simkin, 2007)

14. Kram Kaki dan Tungkai

Terjadi pada kehamilan lanjut yang disebabkan oleh kelelahan otot betis, tekanan pada saraf kaki, terganggunya peredaran darah, atau ketidakseimbangan mineral pada darah. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan karena terlalu sedikit kalsium atau magnesium atau karena terlalu banyak fosfor yang terdapat pada makanan daging yang sudah di proses, makanan kecil, dan minuman ringan.

- a. Meredakan kram tungkai

Untuk meredakan kram di betis, luruskan lutut dan tekuk telapak kaki ke atas, membawa jari-jari ke arah garis. Berdiri dengan berat badan bertumpu pada tungkai yang kram. Jaga kaki tetap lurus dan tumit menapak pada lantai, kemudian bersandarlah ke depan untuk meregangkan otot betis. Jika kram kaki cukup parah, maka butuh bantuan orang lain untuk membantu ketidaknyamanan ini. Sementara duduk di kursi atau tempat tidur, maka mintalah pasangan menahan kaki lurus dengan satu tangan sementara tangan lain memegang tumit kaki. Dan menggunakan lengannya mintalah pasangan

untuk menekan perlahan kaki dan jari kaki ke atas. Jika kram sudah hilang jangan luruskan jari-jari Anda karena kram dapat timbul kembali.

b. Meredakan kram telapak kaki

Kram pada telapak kaki membuat otot-otot lengkung telapak mengencang dan jari-jari membengkok. Untuk meredakan kram ini, regangkan jari kaki dan telapak kaki dengan menarik jari ke atas. Untuk mencegah kram jangan menekuk jari kembali.

(Penny Simkin, 2007)

15. Sakit Lipat Paha yang Mendadak

Rasa tidak nyaman ini bisa terjadi pada bagian bawah perut atau lipat paha (pada satu atau kedua sisi) sewaktu bersin, bangun dengan cepat, tertawa pada posisi berbaring dengan kaki lurus atau berdiri. Rasa sakit ini disebabkan oleh meregangnya satu atau kedua ligamen rotundum rahim yang terjadi mendadak. Kedua ligamen ini yang menghubungkan bagian depan rahim ke lipat paha kiri dan kanan, berkontraksi dan berelaksasi seperti otot, tetapi dengan jauh lebih lambat. Jika bersin atau batuk maka dapat diikuti dengan menekuk atau melenturkan panggul untuk mengurangi ketegangan.

16. Keputihan

Adanya keputihan selama kehamilan dapat dinilai sebagai hal yang fisiologis, selama hamil terjadi peningkatan pembentukan lendir oleh kelenjar serviks di bawah pengaruh estrogen. Hal ini merupakan suatu yang normal, jika tidak disertai oleh gejala lain. Pastikan tidak ada infeksi lainnya, pada ibu hamil perlu edukasi terkait menjaga kebersihan vagina (Biringir, 1988). Keputihan harus bening dan putih serta tidak berbau tidak sedap. Jika keputihan berwarna atau berbau aneh, atau jika merasa gatal atau nyeri, mungkin mengalami infeksi vagina. Beri tahu bidan atau dokter jika keputihan berwarna, berbau aneh, atau jika merasa gatal atau nyeri (Huthwaite M., 2012).

Cara mencegah keputihan selama kehamilan adalah :

- a. Gunakan celana dalam katun.
- b. Kenakan pembalut mini.
- c. Jangan kenakan celana ketat atau celana pendek.
- d. Berkonsultasilah dengan dokter jika merasa sakit saat buang air kecil dan jika keputihan terasa panas, gatal, atau berbau
- e. Jangan melakukan douche (membilas bagian dalam vagina)

(Lapiente Villar, 1987)

17. Kontraksi Braxton Hicks

Kontraksi Braxton-Hicks adalah kontraksi rahim yang membantu tubuh bersiap untuk persalinan. Kontraksi ini tidak teratur dan sering kali tidak

menimbulkan rasa sakit. Saat mendekati tanggal persalinan, kontraksi ini membantu melunakkan serviks. Kontraksi ini bukan kontraksi persalinan yang sebenarnya. Untuk memperlambat atau meredakan kontraksi Braxton-Hicks:

- a. Minum lebih banyak cairan dan makan sesuatu.
- b. Mandi air hangat.
- c. Lakukan latihan pernapasan.
- d. Hubungi tenaga kesehatan jika telah mencoba melakukan semua hal namun usia kehamilan kurang dari 35 minggu, dan mengalami lebih dari 4-6 kontraksi per jam.

(Lapuente Villar, 1987)

18. Edema

Edema pada kehamilan dapat menjadi pertanda yang normal namun bisa menjadi patologis pada kondisi tertentu. Adanya peningkatan permeabilitas pembuluh darah terkecil (pembuluh darah tersebut memungkinkan lebih banyak cairan bocor ke jaringan), berat tambahan rahim, dan gaya gravitasi yang menurun, memperlambat laju pemompaan darah kembali ke jantung dari bagian bawah tubuh. Cairan sering terkumpul di jaringan tungkai dan kaki wanita hamil setelah trimester pertama. Pembengkakan yang disebabkan oleh terkumpulnya cairan ini disebut edema. Ini adalah kondisi umum pada wanita hamil, terutama jika mereka berdiri dalam waktu lama di siang hari. Edema pada tangan juga dapat terjadi. Anjurkan wanita tersebut untuk sering beristirahat dan meninggikan (mengangkat) kaki dan tungkainya saat duduk. Ini akan meningkatkan aliran darah kembali ke jantungnya dan mengurangi pembengkakan pada tungkai (Dr Sabiha Anjum, 2020). Berikut ini beberapa tips atau pengobatan yang dapat dicoba untuk mengurangi pembengkakan pada kaki dan telapak kaki:

- a. Saat duduk, hindari menyilangkan kaki atau pergelangan kaki dan regangkan sesekali.
- b. Angkat kaki sebisa mungkin.
- c. Renggangkan kaki dengan tumit terlebih dahulu, lalu tekuk kaki dengan lembut untuk merelaksasikan otot betis. Terus putar pergelangan kaki dan goyangkan jari-jari kaki.
- d. Tetap terhidrasi dengan minum banyak air dan cairan lainnya.
- e. Hindari duduk atau berdiri dalam posisi yang sama terlalu lama.
- f. Jalan-jalan sebentar untuk mencegah darah terkumpul di bagian bawah tubuh.
- g. Kenakan sepatu longgar yang dapat meregang untuk mengakomodasi pembengkakan di kaki.

- h. Kenakan stoking penyangga pinggang tinggi saat Anda bangun tidur agar darah tidak menggenang di sekitar pergelangan kaki.
- i. Hindari mengenakan kaus kaki atau stoking yang memiliki pita ketat di sekitar pergelangan kaki atau betis.
- j. Pastikan berolahraga setiap hari, meskipun hanya selama setengah jam misal berlatih yoga, berjalan, atau berenang. Aerobik air juga merupakan pilihan yang baik karena berada di dalam air dapat membantu mengurangi pembengkakan untuk sementara, terutama jika air setinggi bahu. Terapkan gaya hidup sehat dengan memilih pola makan yang sehat, dan hindari mengonsumsi junk food

Ibu hamil perlu mengetahui jika edema / pembengkakan di salah satu pergelangan kaki, telapak kaki, atau tungkai dan tidak ada penyebab yang jelas, seperti cedera. Pembengkakannya parah, menyakitkan, atau terjadi sangat tiba-tiba. Area yang bengkak berwarna merah atau terasa panas saat disentuh. Suhu tubuh sangat tinggi, atau merasa panas dan menggigil. Riwayat atau sedang menderita diabetes dan telapak kaki, pergelangan kaki, atau tungkai bengkak

F. Kesimpulan

Ketidaknyamanan dan nyeri yang terjadi selama kehamilan sangat wajar terjadi karena adanya perubahan yang terjadi pada tubuh. Ketidaknyamanan ini bisa berbeda satu dengan yang lainnya dan tidak semua ibu hamil akan mengalami seluruh ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Perlu adanya informasi yang tepat terkait perubahan selama kehamilan dan cara mengatasinya oleh tenaga kesehatan dokter atau bidan. Terkadang ketidaknyamanan tersebut dapat menjadi sangat parah dan oleh karena itu ibu hamil perlu mengetahui batasan fisiologis yang terjadi pada kehamilannya. Ibu hamil perlu diberikan KIE terkait dengan ketidaknyamanan dan cara mengatasinya secara nonfarmakologis terlebih dahulu.

G. Referensi

- Belleza, M. (2017). Discomforts of Pregnancy. *Nurselabs: Health Care in Advanced Practice Nursing*, 113–118. file:///D:/UNPAD/Semester 6/Discomforts During Pregnancy and the Nurse's Responsibility.pdf
- Bergamo TR, Latorraca COC, Pachito DV, Martimbianco ALC, R. R. (2018). Findings and methodological quality of systematic reviews focusing on acupuncture for pregnancy-related acute conditions. *Acupunct Med*, 36(3), 146–152.
- Biringer, A. (1988). Common physical discomforts of pregnancy. *Can Fam Physician*, 34, 1965–1968.

- Black, E., Khor, K. E., Kennedy, D., Chutatape, A., Sharma, S., Vancaillie, T., & Demirkol, A. (2019). Medication Use and Pain Management in Pregnancy: A Critical Review. *Pain Practice*, 19(8), 875–899. <https://doi.org/10.1111/papr.12814>
- Burnside Hospital. (2018). Coping With Common it is quite normal to have a few discomforts in early pregnancy. *Burnside Hospital*, April, 1–5.
- Byrom, S., Cooper, J., Edington, A., Elliman, D., Gutteridge, K., & Henry, S. (2019). *The Pregnancy*. 15(4), 381–384.
- Davis, D. C. (1996). The discomforts of pregnancy. *Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing: JOGNN / NAACOG*, 25(1), 73–81. <https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.1996.tb02516.x>
- Dr Sabiha Anjum. (2020). *Swelling During Pregnancy*. <https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.1996.tb02516.x>
- Ellis, S. A. (2011). Common Discomforts of Pregnancy. *MSN Coursework*, 1–9.
- Freeman, W. S. (1980). Common complaints in pregnancy. *Medical Times*, 108(11), 1–4.
- Huthwaite M., M. H. . R. C. . T. R. . K. L. (2012). The pregnancy. *Archives of Women's Mental Health*.
- Lapiente Villar, B. (1987). Common discomforts during pregnancy. *Revista de Enfermeria (Barcelona, Spain)*, 10(106), 39–47.
- Liddle SD, P. V. (2015). *Interventions for preventing and treating low-back and pelvic pain during pregnancy*.
- Moghadam, S. H., & Ganji, J. (2019). Evaluation of the nursing process utilization in a teaching hospital, Ogun State, Nigeria. *Journal of Nursing and Midwifery Sciences*, 6(3), 149–155. <https://doi.org/10.4103/JNMS.JNMS>
- Nazik, E., & Eryilmaz, G. (2014). Incidence of pregnancy-related discomforts and management approaches to relieve them among pregnant women. *Journal of Clinical Nursing*, 23(11–12), 1736–1750. <https://doi.org/10.1111/jocn.12323>
- Nyange, C. (2017). Nausea and vomiting continue to be uncomfortable symptoms associated with pregnancy. The precise etiology of nausea is unknown, but the most commonly referenced possible cause is the fluctuation of hormones during pregnancy. *International Journal of Childbirth Education*, 32(1), 25–26.
- Penny Simkin, dkk. (2007). *Panduan Lengkap Kehamilan, Melahirkan & Bayi* (Surya Satyanegara (ed.); I). Arcan.
- Shah, S., Banh, E. T., Koury, K., Bhatia, G., Nandi, R., & Gulur, P. (2015). Pain Management in Pregnancy: Multimodal Approaches. *Pain Research and Treatment*, 2015. <https://doi.org/10.1155/2015/987483>
- Stela Kitzinger, V. B. (1996). *Kehamilan: Apa yang Anda Hadapi Hari per Hari* (S.

H. Glosarium

Ambivalensi	: perasaan yang campur aduk atau bertentangan terhadap sesuatu, orang, atau situasi.
Akut	: bersifat sementara, mendadak, atau baru saja terjadi. Sering digunakan untuk menggambarkan penyakit atau kondisi yang berlangsung dalam waktu singkat, biasanya tidak lebih dari 6 bulan.
Depresi	: gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot (seperti muram, sedih, perasaan tertekan)
Dispnea	: kondisi kesehatan yang menyebabkan seseorang kesulitan bernapas, terhambatnya aliran udara (menyebabkan sesak nafas)
Endokrin	: kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur dan berkomunikasi dengan fungsi tubuh
Hormon	: senyawa kimia yang diproduksi oleh system endokrin yang terdiri dari beberapa kelenjar dalam tubuh.
Infeksi	: kondisi ketika organisme mikroba seperti bakteri, virus, jamur, atau makhluk lain dan mulai berkembang biak di dalamnya
Insomnia	: gangguan tidur yang mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup dalam satu hari
Kram	: kontraksi atau menegangnya otot secara tiba-tiba di suatu bagian tubuh selama beberapa detik atau menit, yang masih mungkin dirasakan sebagai rasa pegal hingga 24 jam setelah mereda.
Ligament	: jaringan ikat yang berbentuk seperti pita, kuat, dan elastis yang berfungsi untuk menghubungkan tulang, sendi, dan organ.
Relaksasi	: proses untuk merilekskan otot-otot yang tegang dan pikiran agar mencapai kondisi yang nyaman.
Sindrom	: kumpulan gejala dan tanda yang muncul bersamaan dan menandakan suatu kondisi atau kelainan tertentu.

PROFIL PENULIS



Nurrahma Layuk.,S.Tr.Keb.,M.Keb Lahir di Luwuk, 02 Juni 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Manado kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2021. Penulis bekerja dan menjadi dosen tetap di prodi D-IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate dan aktif dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif dalam penulisan buku dan karya ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nrrlayuk@gmail.com.

Motto: "Seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan dengan ikhlas dan hati gembira"



Bd. Hj. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb., M.KM., lahir pada tanggal 27 Agustus 1988 di Panyabungan-Mandailing Natal. Anak pertama dari Bapak Alm. H. Ali Hamzah, MM dan Ibu Hj. Mamnah, S.Pd. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga Fakultas Kesehatan Universitas Aupa Royhan Di Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2018. Selain menjadi dosen tetap penulis juga aktif dalam membuat buku sebagai sumbangsih untuk dunia pendidikan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

nuraliyahrangkuti88@gmail.com

Motto: "Jangan Bosan Berbuat Kebajikan"

PROFIL PENULIS



Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes., Penulis lahir di Tulungagung, domisili di Kota Kediri. Penulis menyelesaikan pendidikan SPK di SPK Pemkab Kabupaten Tulungagung , Pendidikan P2B di RS Baptis Kota Kediri, Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, D4 Bidan Pendidik di FK UGM Yogyakarta, S2 Pendidikan Kesehatan di UNS lulus tahun 2009, saat ini sedang menempuh program Doktoral. Riwayat karir, Penulis pernah bekerja di RSIA Trisna Medika Tulungagung selama 7 tahun, kemudian dunia pendidikan di Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri prodi D III Kebidanan mulai tahun 2003 sampai dengan April 2024.

Mulai Mei 2024 bergabung dengan Universitas Strada Indonesia Prodi Kebidanan yang sekarang menjadi Universitas Strada Indonesia (USI) Kediri. Buku yang pernah di tulis diantaranya tentang Kesehatan Reproduksi , Stimulasi Anak tumbuh kembang anak , Peduli Kesehatan Reproduksi Wanita, Diagnostik asuhan kebidanan pada kehamilan dengan permasalahannya, Buku Ajar Psikologi Kebidanan, Kumpulan Latihan Soal Osce Kebidanan, SOP Pelayanan Kebidanan masa persalinan, buku ajar persalinan, Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir (BBL). Saat ini penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian kesehatan khususnya kebidanan yang telah terbit di jurnal Sinta, aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan terpublikasi di Jurnal Nasional. Jalin kerja sama dengan penulis via surel sitikomariyah.dh@gmail.com.



Bd. Siti Nur Farida., SST., M.Kes., Lahir di Bondowoso 22 Oktober 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Stikes Husada Jombang ,Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, IIK Strada Indonesia Kediri .Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 dengan Menjadi Asisten Dosen Di stikes Husada Jombang Saat ini penulis bekerja di Stikes Husada Jombang mengampu mata kuliah Asuhan

Kebidanan Kehamilan,KDM,KDKK,Komunikasi dan Asuhan Kebidanan Nifas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sitinurfaridahusada22@gmail.com

PROFIL PENULIS



Anis Ervina, S.S.T., M.Kes., Lahir di Serang, 24 Maret 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D IV Bidan Pendidikan POLTEKKES Kemenkes Semarang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIKES Indonesia Maju dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 dan sampai saat ini penulis bekerja di Universitas La Tansa Mashiro mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan dan Epidemiologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikas dan narasumber dalam seminar lokal maupun nasional, penulis juga merupakan konselor lakatasi sejak tahun 2014 and bergabung kedalam kelompok pendukung ASI Komunitas Peduli Asi Banten (KPAB). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anis.ervina87@gmail.com

Motto: "Tak ada yang sempurna, tapi selalu ada yang bisa diperbaiki. Berdoa dan berusaha sebaik mungkin adalah kuncinya."



Maesaroh, S.ST., M.Kes., lahir di Subang pada tanggal 30 November 1989, penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada Cirebon Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan jenjang Pascasarjana Magister Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta tahun 2017. Penulis pernah bekerja di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada tahun 2011 sampai dengan 2020, dan saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Lembaga Pendidikan Prada sejak tahun 2020. Penulis telah mempublikasi beberapa hasil karya ilmiah yang sudah terindeks Google Scholar dan memiliki ID SINTA 6863812.

Motto: "terbanglah tinggi menggapai langit, namun hatimu tetaplah merendah di bumi Ilahi"



PROFIL PENULIS



Bdn. Dian Fitriyani, S.ST., M.Keb., Lahir di Indramayu, 16 Maret 1988 merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dr pasangan Bapak Tisno Hadi Saputra dan Ibu Khumaeroh. Dan seorang Istri dari Andri Yuliardi dan mempunyai seorang Putra bernama Arsyah Ahmad Alfatih. Adapun Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis yaitu : Menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung Angkatan IIA lulus th 2010. Menyelesaikan Pendidikan DIV Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung Angkatan XIVA lulus th 2011. Penulis melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung Angkatan IX Kelas Jabar lulus th 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Kadiri Angkatan XXI lulus th 2022. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Doktorat di Universitas Sebelas Maret. Sejak tahun 2011 penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan dan penulis aktif mengajar di STIKes Indramayu dan Saat ini Penulis menjadi Pengajar di Karsa Husada Garut. Penulis juga aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi serta aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: dfy.fitriyani@gmail.com

Pesan untuk para pembaca:

“Lakukan segala hal yang terbaik versimu, setiap orang berhak sukses sesuai jalan dan waktunya masing-masing, tetap semangat berkarya, berinovasi dan upgrade diri”. (Dian Fitriyani).

PROFIL PENULIS



Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes. Lahir di Mataram, 04 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Mataram lulus tahun 2004, DIV Bidan Pendidik pada Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram lulus tahun 2009, pendidikan S2 Magister Sains Terapan Kesehatan Program Pasca Sarjana pada Universitas Diponegoro lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998-2001 bekerja sebagai bidan desa (PTT) dan tahun 2005 – sekarang sebagai dosen (ASN)

di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aranimurni@gmail.com

Motto: **"Kebaikan yang kita berikan adalah investasi terbaik"**



Aida Ratna Wijayanti, S.Keb., Bd., M.Keb. Lahir di Ponorogo, 22 September 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Bidan, Universitas Airlangga tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kota Kediri, kemudian tahun 2019 bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Prodi D3 Kebidanan

Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) sampai saat ini. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Hypnosis dalam Asuhan Kebidanan, dan Praktik Klinik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi nasional dan internasional, seminar, pengabdian masyarakat, pengelola jurnal mahasiswa (*health sciences journal*) FIK UMPO sampai dengan tahun 2023, sebagai auditor internal non akademik universitas sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Aktif di organisasi kemasyarakatan di luar kampus, dan mengikuti berbagai pelatihan sesuai bidang ilmu, yang terakhir adalah hipnoterapi sehingga mendapatkan gelar non akademik Ch.,CHt tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aidaratna.Bd@gmail.com.

Sinopsis

Buku *Perawatan Kehamilan yang Optimal* adalah panduan komprehensif yang ditujukan untuk membantu ibu hamil, keluarga, dan tenaga medis dalam menjalani dan memahami perjalanan kehamilan dengan cara yang lebih sehat dan aman. Buku ini membahas berbagai aspek penting yang terkait dengan perawatan selama kehamilan, mulai dari pemeriksaan rutin hingga persiapan menyusui setelah kelahiran.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan informasi mendalam tentang pemeriksaan kehamilan yang rutin dan pentingnya pemantauan ibu serta janin untuk memastikan kehamilan berjalan dengan baik. Tidak kalah penting, buku ini juga menyajikan pembahasan mengenai nutrisi dan suplemen yang diperlukan selama kehamilan untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin.

Selain itu, buku ini mengulas dengan lengkap mengenai manajemen kehamilan berisiko tinggi, serta upaya pencegahan infeksi yang bisa membahayakan ibu dan janin. Bagi ibu baru, bagian tentang persiapan menyusui dan tantangan yang mungkin dihadapi memberikan wawasan yang sangat berguna.

Kehamilan bukan hanya masalah fisik, tetapi juga emosional. Oleh karena itu, buku ini juga menekankan persiapan mental emosional menjelang persalinan dan pentingnya konseling psikososial untuk ibu hamil. Tidak lupa, buku ini menyentuh kondisi medis tertentu yang dapat mempengaruhi ibu hamil, seperti Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), serta cara pengelolaan kondisi tersebut dengan aman selama kehamilan.

Terakhir, buku ini memberikan panduan tentang manajemen nyeri dan ketidaknyamanan yang sering dialami selama kehamilan, memberikan solusi dan strategi yang dapat membantu ibu menjalani masa kehamilan dengan lebih nyaman.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, buku *Perawatan Kehamilan yang Optimal* bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis, sehingga setiap ibu hamil dapat menjalani kehamilannya dengan penuh rasa aman, sehat, dan bahagia.

Buku Perawatan Kehamilan yang Optimal adalah panduan komprehensif yang ditujukan untuk membantu ibu hamil, keluarga, dan tenaga medis dalam menjalani dan memahami perjalanan kehamilan dengan cara yang lebih sehat dan aman. Buku ini membahas berbagai aspek penting yang terkait dengan perawatan selama kehamilan, mulai dari pemeriksaan rutin hingga persiapan menyusui setelah kelahiran.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan informasi mendalam tentang pemeriksaan kehamilan yang rutin dan pentingnya pemantauan ibu serta janin untuk memastikan kehamilan berjalan dengan baik. Tidak kalah penting, buku ini juga menyajikan pembahasan mengenai nutrisi dan suplemen yang diperlukan selama kehamilan untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin.

Selain itu, buku ini mengulas dengan lengkap mengenai manajemen kehamilan berisiko tinggi, serta upaya pencegahan infeksi yang bisa membahayakan ibu dan janin. Bagi ibu baru, bagian tentang persiapan menyusui dan tantangan yang mungkin dihadapi memberikan wawasan yang sangat berguna.

Kehamilan bukan hanya masalah fisik, tetapi juga emosional. Oleh karena itu, buku ini juga menekankan persiapan mental emosional menjelang persalinan dan pentingnya konseling psikososial untuk ibu hamil. Tidak lupa, buku ini menyentuh kondisi medis tertentu yang dapat mempengaruhi ibu hamil, seperti Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), serta cara pengelolaan kondisi tersebut dengan aman selama kehamilan.

Terakhir, buku ini memberikan panduan tentang manajemen nyeri dan ketidaknyamanan yang sering dialami selama kehamilan, memberikan solusi dan strategi yang dapat membantu ibu menjalani masa kehamilan dengan lebih nyaman.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, buku Perawatan Kehamilan yang Optimal bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis, sehingga setiap ibu hamil dapat menjalani kehamilannya dengan penuh rasa aman, sehat, dan bahagia.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-88-7



9

786347

139887